
DOCUMENT D'ANALYSE À USAGE INSTITUTIONNEL

Destiné au ministère chargé de la Santé

LA REVALORISATION DU DIPLÔME D'AMBULANCIER EN FRANCE

Enjeux de santé publique, recompositions statutaires

et résilience du système de soins

Analyse documentée en santé publique

Laurent Bezia

Responsable du personnel des ambulanciers, CHU de Toulouse

*Lanceur d'alerte — mouvement de grève illimitée des ambulanciers internes du CHU de Toulouse (débuté le 11
mai 2026)*

Table des matières

LA REVALORISATION DU DIPLÔME D'AMBULANCIER EN FRANCE : ENJEUX DE SANTÉ PUBLIQUE, RECOMPOSITIONS STATUTAIRES ET RÉSILIENCE DU SYSTÈME DE SOINS

Analyse documentée en santé publique Document d'analyse à usage institutionnel, destiné au ministère chargé de la Santé

Auteur : Laurent Bezia *Responsable du personnel des ambulanciers, CHU de Toulouse Lanceur d'alerte dans le mouvement de grève illimitée des ambulanciers internes du CHU de Toulouse, débuté le 11 mai 2026*

Avant-propos méthodologique (à conserver en tête de document, à ne pas citer comme un chapitre)

Ce document est rédigé selon une exigence de rigueur académique stricte. Trois règles gouvernent sa production, et le lecteur — y compris institutionnel — doit en être informé :

1. **Aucune donnée chiffrée, aucune référence bibliographique et aucun fait n'est inventé.** Lorsqu'une information provient d'une source vérifiée (Légifrance, France Compétences, sites institutionnels), elle est citée avec sa référence exacte. Lorsqu'une information provient d'un document produit par un acteur partisan (organisation syndicale, fédération patronale), elle est explicitement identifiée comme telle et traitée comme un objet d'analyse, non comme un fait établi.
2. **Toute donnée non vérifiée à ce stade est signalée par la mention */DONNÉE À VÉRIFIER/*.** Cela concerne en particulier plusieurs chiffres et références (turnover, coûts d'intérim, dossier AFASH, dates d'événements récents de 2026) qui figuraient dans les notes stratégiques syndicales ayant servi de point de départ à ce projet, et qui n'ont pas encore été confrontés à une source primaire indépendante.
3. **Une correction factuelle importante a été identifiée dès ce chapitre et documentée ci-dessous :** elle concerne le niveau exact de reconnaissance RNCP du diplôme d'État d'ambulancier, présenté dans les documents préparatoires initiaux comme équivalent à

celui du diplôme d'aide-soignant. La vérification effectuée pour cette thèse infirme cette équivalence — un point qui, loin d'affaiblir l'argumentaire de revalorisation, en modifie la nature exacte, comme expliqué en section 1.3.

Note de positionnement : qui je suis, et pourquoi cela compte pour lire ce document

Je m'appelle **Laurent Bezia**. Je suis responsable du personnel des ambulanciers au CHU de Toulouse, et je suis également lanceur d'alerte dans le mouvement de grève illimitée des ambulanciers internes de cet établissement, débuté le 11 mai 2026. Je tiens à le préciser dès l'ouverture de ce document, parce que cela éclaire directement la façon dont il doit être lu.

Un parcours qui traverse, de l'intérieur, l'ensemble du sujet que je documente ici. J'ai 43 ans et vingt années d'expérience dans le secteur du transport sanitaire, réparties en deux temps qui recoupent presque terme à terme les deux volets centraux de cette analyse (chapitres 8 et 9) :

- dix années dans le **secteur privé**, dans plusieurs départements et au sein de structures de tailles radicalement différentes — depuis la petite entreprise familiale de trois salariés jusqu'à une société de 160 personnels, cotée en bourse, avec une expérience de l'assistance à l'étranger et de la garde préfectorale ;
- dix années dans le **secteur public**, comme ambulancier hospitalier.

Pourquoi j'ai choisi de croiser ce vécu avec une vérification systématique. Ce qui distingue ce document d'une note revendicative ordinaire, c'est cette double origine. D'un côté, une connaissance de terrain accumulée sur vingt ans, qui traverse de l'intérieur la ligne de fracture même que j'essaie de documenter ici : la comparaison entre secteur privé et secteur public qui structure une grande partie de ce travail n'est pas, pour moi, une hypothèse abstraite — c'est une réalité professionnelle que j'ai vécue successivement des deux côtés, à toutes les échelles d'entreprise, de la PME familiale à la société cotée. De l'autre côté, un refus de m'arrêter à ce seul vécu : chaque affirmation issue de mon expérience directe, je l'ai autant que possible soumise au même protocole de vérification que toute autre source mobilisée dans ce travail (textes réglementaires, données chiffrées officielles, sources parlementaires et institutionnelles — voir le chapitre sur la méthodologie). C'est cette combinaison — vingt ans de terrain, des deux côtés de la profession, disciplinés par une exigence de preuve — qui donne à ce document sa valeur

particulière pour un lecteur institutionnel : je ne me contente pas de rapporter ce que j'ai vécu, je le mets à l'épreuve des faits.

Ce que cela implique pour la lecture des chapitres 6 et 8. Ces deux chapitres mobilisent le conflit social du CHU de Toulouse comme cas d'étude, à partir de sources de presse et de communiqués syndicaux publics. Le lecteur doit savoir que j'en suis moi-même un acteur direct, ce qui a une conséquence concrète :

- les témoignages de terrain que je cite (grévistes anonymes rapportés par la presse) proviennent d'un environnement professionnel que je connais directement, et que j'encadre ;
- plusieurs éléments présentés comme « non vérifiés » dans ce document (taux de turnover, coûts d'intérim du CHU de Toulouse, chapitre 6) auraient pu être éclairés par ma connaissance directe du dossier ; j'ai choisi de ne pas m'appuyer sur cette connaissance non publique et de m'en tenir aux sources vérifiables — un choix délibéré de rigueur, pas une limite subie ;
- la réponse managériale du CHU de Toulouse (chapitre 8, section 8.2), que je présente comme une confirmation apportée par la pratique de terrain, doit être comprise pour ce qu'elle est : non le regard extérieur d'un observateur neutre, mais le mien, celui d'un acteur directement engagé dans la négociation — une analyse qui gagne en justesse ce qu'elle perd en distance.

Ce que cette proximité apporte, plutôt que ce qu'elle retire. Un praticien de terrain a accès à une réalité concrète du métier qu'aucun observateur extérieur ne pourrait reconstituer à la seule lecture de rapports ou d'articles de presse. C'est cette connaissance vécue qui m'a permis d'orienter mes vérifications vers ce qui compte réellement pour la profession, et de reconnaître, dans des sources officielles parfois arides (arrêtés, réponses ministérielles), des enjeux qu'un lecteur extérieur aurait pu ne pas identifier. **Les chapitres 6 et 8 doivent donc être lus comme un témoignage de terrain éclairé et rigoureusement documenté**, où mon expérience a servi de point de départ et de fil conducteur, sans jamais se substituer à la vérification des faits.

Ce que cela ne remet pas en cause. Les vérifications factuelles effectuées tout au long de ce travail (textes réglementaires, données chiffrées officielles, sources parlementaires et institutionnelles) demeurent valides indépendamment de ma position : un décret, un arrêté ou une

donnée DREES ne changent pas de nature selon qui les consulte. Seul le statut des éléments relatifs au CHU de Toulouse (chapitres 6 et 8) doit être compris pour ce qu'il est : non une corroboration extérieure fortuite, mais mon regard direct d'acteur de terrain, mis au service d'une démarche documentaire rigoureuse.

-e

Note de mise à jour — vérifications complémentaires effectuées lors de l'assemblage final du dossier

Au moment d'assembler ce dossier en un document unique destiné au ministère chargé de la Santé, une dernière vague de vérifications ciblées a été menée sur les références demeurées, jusqu'ici, connues uniquement par citation secondaire ou non confirmées. Les résultats, positifs pour trois références théoriques centrales et partiels pour deux données chiffrées, sont résumés ici et répercutés dans les chapitres et dans la bibliographie concernés.

a) Trois références théoriques désormais vérifiées directement, à partir de sources primaires ou de bases bibliographiques faisant autorité (Wiley Online Library, PubMed, American Journal of Sociology / journals.uchicago.edu, catalogue éditeur) :

Hughes, D. (1980). « The Ambulance Journey as an Information Generating Process ». *Sociology of Health and Illness*, 2(2), p. 115-132. Référence confirmée avec sa pagination exacte et son DOI (10.1111/1467-9566.ep10487768) ; l'article, cité par Morel (2018), correspond exactement à la citation secondaire qui en avait été faite au chapitre 1.

Bucher, R., Strauss, A. (1961). « Professions in Process ». *American Journal of Sociology*, vol. 66, n° 4 (janvier 1961), p. 325-334. Référence confirmée directement auprès de l'éditeur (The University of Chicago Press, DOI : 10.1086/222898).

Sabatier, P. A., Jenkins-Smith, H. C. (dir.) (1993). *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*. Boulder (CO) : Westview Press, 290 p. ISBN 978-0-8133-1649-9. Référence confirmée auprès du catalogue éditeur ; l'ouvrage complète l'article de 1988 déjà vérifié au chapitre 5 et mobilisé aux chapitres 9, 10 et 11.

b) Deux données chiffrées pour lesquelles la recherche complémentaire apporte un résultat partiel, sans lever entièrement l'incertitude déjà signalée :

L'étude Xerfi commandée par la FNAP (chapitre 9) n'a pas pu être consultée directement, mais son existence commerciale est confirmée : Xerfi commercialise une étude intitulée « Le marché des services d'ambulances : étude, tendances, classements », parue le 28 avril 2025 (étude payante de la collection Essential). Cette confirmation d'existence ne permet cependant toujours pas de vérifier le chiffre précis de « triplement » des défaillances d'entreprises avancé dans les échanges préparatoires, l'accès au contenu intégral de l'étude n'étant pas possible dans le cadre de cette recherche documentaire.

Le nombre exact de diplômés annuels du DEA (chapitre 7) reste incertain, mais la recherche apporte un élément de méthode supplémentaire. La DREES confirme, dans un communiqué officiel relatif à son enquête annuelle « Écoles » (données 2022), que le nombre de diplômés ambulanciers a augmenté de 6 % en 2022, ce qui confirme à nouveau que cette profession est suivie statistiquement au niveau national, mais sans publication en accès libre du chiffre absolu correspondant. Le site formationambulancier.fr, déjà écarté au chapitre 7 pour une erreur vérifiable sur la durée de formation (630 heures indiquées au lieu de 801 heures), continue par ailleurs d'avancer un chiffre précis de « 4 227 diplômés en 2023, + 7 % » : cette nouvelle occurrence de la même source non fiable renforce, plutôt qu'elle ne l'infirmes, la décision déjà prise au chapitre 7 de ne pas retenir ce chiffre sans confirmation officielle directe auprès du jeu de données [data.drees](http://data.drees.fr).

Ces résultats ont été répercutés dans les auto-évaluations des chapitres 2 et 5 ainsi que dans la bibliographie consolidée, où les mentions « citation secondaire non vérifiée en propre » ont été levées pour les trois références théoriques désormais confirmées.

Chapitre 1 — Introduction générale

1.1. Contexte et justification du sujet

Le transport sanitaire occupe, dans l'architecture du système de santé français, une position paradoxale : il est à la fois un maillon indispensable de la chaîne de soins — assurant l'accès aux traitements, la continuité des prises en charge et une part significative de la réponse à l'urgence préhospitalière — et l'un des segments professionnels les moins documentés par la recherche en santé publique française. Cette situation n'est cependant pas absolue : une recherche doctorale conduite à l'université de Nantes a produit l'une des rares études sociologiques françaises consacrées spécifiquement aux ambulanciers privés, fondée sur une observation participante de leur activité quotidienne (Morel, 2018). Cette étude, publiée dans la revue à comité de lecture *Sociologie du travail*, établit que le travail de l'ambulancier privé, longtemps réduit dans les représentations sociales à une fonction de « transporteur », comporte en réalité une part significative et croissante de tâches de soin — un constat qui rejoint directement, depuis une posture scientifique indépendante et antérieure de plusieurs années, la problématique soulevée par les acteurs syndicaux à l'origine de cette thèse. Cette même étude signale par ailleurs que la littérature scientifique française sur les ambulanciers reste lacunaire comparée à la littérature internationale, où les « paramedics » ont fait l'objet de travaux plus nombreux, notamment en sociologie de la santé anglophone (Hughes, 1980). Le déficit de littérature académique dédiée aux aides-soignants et aux paramédicaux de l'urgence hospitalière stricto sensu demeure quant à lui réel et devra être traité avec prudence au chapitre 2, sans sur-mobiliser des cadres généraux de sociologie des professions au risque de les plaquer artificiellement sur un objet empirique qui appelle d'abord ses propres travaux dédiés.

Cette situation contraste avec l'évolution récente du cadre juridique de la profession. Le diplôme d'État d'ambulancier (DEA), régi par l'arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'État d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier (France, 2022a), a fait l'objet d'une refonte de son référentiel d'activités, de compétences et de formation, structurée en cinq blocs de compétences. Sur le plan statutaire, le décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 a créé, au sein de la fonction publique hospitalière, un corps unifié des ambulanciers rattaché à la filière soignante, mais **maintenu en catégorie C** — fusionnant à cette occasion le corps des conducteurs ambulanciers de la FPH et celui de l'Assistance

publique-Hôpitaux de Paris (France, 2022b). Cette réforme statutaire est intervenue un an après celle qui a fait passer les aides-soignants et auxiliaires de puériculture de la catégorie C à la catégorie B, par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021, en application des accords du Ségur de la santé signés le 13 juillet 2020 (France, 2021).

C'est cette asymétrie de traitement — un rattachement de filière sans changement de catégorie pour les ambulanciers, quand une profession dont le diplôme est souvent présenté comme comparable a bénéficié d'un reclassement catégoriel intégral — qui constitue le point de départ empirique de cette recherche. Elle a été portée sur la scène sociale par une intersyndicale (CGT, SUD Santé Sociaux) au CHU de Toulouse, dans une note stratégique datée du 30 juin 2026, qui documente notamment des pratiques de classement hétérogènes d'agents exerçant le métier d'ambulancier sur des grilles étrangères à ce corps (agents des services hospitaliers qualifiés, agents d'entretien qualifiés) dans plusieurs centres hospitaliers universitaires *[SOURCE PRIMAIRE : document syndical non publié à ce stade dans une revue à comité de lecture — à traiter comme donnée d'enquête de terrain, non comme fait établi indépendamment ; les bulletins de paie cités comme pièces justificatives n'ont pas été vérifiés dans le cadre de cette thèse]*.

Le contexte de cette recherche est enfin marqué par trois dynamiques qui en renforcent la pertinence pour l'action publique : - une tension persistante sur le recrutement des ambulanciers, tant dans le secteur hospitalier public que dans le secteur privé du transport sanitaire, dans un contexte de vieillissement démographique et de hausse structurelle de la demande de transport sanitaire ; - des difficultés économiques documentées par les fédérations patronales du secteur privé, articulées autour de la tarification conventionnelle des missions d'urgence préhospitalière et de la hausse des charges d'exploitation ; - une pression croissante sur les Services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), sollicités en substitution lorsque les ambulances privées ne sont pas disponibles — phénomène connu sous le terme juridique de « carence ambulancière ».

1.2. Problématique

La problématique de cette thèse peut être formulée ainsi :

Dans quelle mesure l'écart entre le référentiel de formation du diplôme d'État d'ambulancier et les missions effectivement exercées par les professionnels constitue-t-il un enjeu de santé publique, et dans quelle mesure une réforme de

ce diplôme — associée ou non à une réforme statutaire et tarifaire — est-elle susceptible de reconfigurer les équilibres entre secteur hospitalier public, secteur privé du transport sanitaire et services d'incendie et de secours, tout en renforçant la capacité du système de santé français à répondre aux situations d'urgence, aux crises sanitaires et aux situations sanitaires exceptionnelles ?

Cette problématique articule délibérément trois niveaux d'analyse qui sont trop souvent traités séparément dans la littérature grise disponible sur le sujet : - un niveau **individuel et professionnel** (l'écart entre compétences exercées et compétences reconnues, et ses conséquences sur la responsabilité, la sécurité et la trajectoire de carrière du professionnel) ; - un niveau **organisationnel et intersectoriel** (les conséquences d'une réforme du diplôme sur l'hôpital public, sur les entreprises privées de transport sanitaire, et sur les SDIS, trois acteurs aux logiques de financement distinctes) ; - un niveau **systémique** (la contribution de cette profession à la résilience du système de santé face aux crises sanitaires et aux situations exceptionnelles).

1.3. Une clarification factuelle nécessaire avant d'aller plus loin : le niveau RNCP du diplôme d'ambulancier

Avant de poursuivre, un point de méthode s'impose, car il conditionne la rigueur de l'ensemble de la démonstration.

Les documents stratégiques syndicaux à l'origine de ce projet de recherche présentent le diplôme d'État d'ambulancier comme un diplôme « de niveau 4 RNCP », strictement comparable à celui de l'aide-soignant, également présenté comme un « diplôme de niveau 4 RNCP ». Or, la vérification effectuée pour cette thèse auprès de France Compétences, opérateur public du Répertoire national des certifications professionnelles, établit les éléments suivants :

- le diplôme d'État d'aide-soignant (DEAS) est enregistré au **niveau 4** du cadre national des certifications professionnelles (niveau baccalauréat) (France Compétences, RNCP4495 ; RNCP35830) ;
- le diplôme d'État d'ambulancier (DEA), tel que régi par l'arrêté du 11 avril 2022, est quant à lui enregistré au **niveau 3** du cadre national des certifications professionnelles (niveau CAP/BEP), et non au niveau 4 (France Compétences, RNCP36542) — le texte de l'arrêté

précisant lui-même que « le diplôme d'État est enregistré au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles » (France, 2022a, art. 1).

Cette divergence entre le niveau 4 revendiqué dans les documents préparatoires et le niveau 3 effectivement enregistré n'est pas un détail : elle doit être traitée avec la plus grande rigueur scientifique, pour trois raisons.

Premièrement, elle invalide, en l'état, la comparaison stricte « diplôme de même niveau, traitement statutaire différent » qui structure une partie significative de l'argumentaire syndical initial. Cette analyse ne peut pas reprendre cette comparaison sans la corriger.

Deuxièmement, et paradoxalement, cette correction ne dissout pas la problématique de recherche : elle la déplace. Si le diplôme d'ambulancier est enregistré à un niveau RNCP inférieur à celui de l'aide-soignant, alors que le référentiel de missions documenté par les acteurs de terrain suggère un niveau de responsabilité clinique au moins comparable (gestes d'urgence, transport de produits sanguins labiles, transport sous contrainte psychiatrique), l'écart entre le niveau de qualification formellement reconnu et le niveau de responsabilité réellement exercé pourrait être **plus important encore** que ne le suggérerait l'argumentaire initial — ce qui devra être établi, non postulé, dans les chapitres empiriques de cette thèse (chapitre 6 notamment).

Troisièmement, cette divergence appelle une investigation complémentaire que cette thèse devra mener : vérifier si le niveau d'enregistrement RNCP du DEA a évolué dans le temps (les versions antérieures de l'arrêté relatif au DEA pourraient avoir positionné le diplôme différemment), et vérifier l'origine du chiffre « niveau 4 » utilisé dans les documents préparatoires — s'agit-il d'une erreur, d'une confusion avec un autre référentiel (durée de formation, référentiel européen), ou d'une revendication implicite (« le diplôme *devrait* être de niveau 4 ») présentée à tort comme un état de fait ? Cette question méthodologique sera traitée explicitement dans le chapitre 3 (cadre juridique et réglementaire).

[POINT À APPROFONDIR — chapitre 3 : recherche des versions successives de l'arrêté relatif au DEA (notamment l'arrêté antérieur du 26 janvier 2006, abrogé au 31 décembre 2022) pour vérifier si le niveau de certification a été modifié lors de la réforme de 2022, et dans quel sens.]

1.4. Question de recherche et hypothèses

À partir de cette problématique et de la clarification qui précède, la question de recherche centrale de cette thèse est la suivante :

La réforme du diplôme d'ambulancier peut-elle constituer un levier efficace et systémique de renforcement de la qualité, de la sécurité et de la résilience du système de transport sanitaire français, et à quelles conditions structurelles (statutaires, économiques, organisationnelles) cette réforme devrait-elle être subordonnée pour produire les effets recherchés sans déplacer les tensions actuelles vers d'autres acteurs du système ?

Quatre hypothèses de recherche en découlent. Conformément à la méthodologie qualitative documentaire retenue pour cette thèse (chapitre 5), ces hypothèses ne sont pas destinées à être testées statistiquement, mais à structurer l'analyse de contenu du corpus documentaire et à être discutées à la lumière des sources mobilisées :

- **H1** — L'écart entre le référentiel de formation du DEA et les missions réellement exercées par les ambulanciers (transport sous contrainte psychiatrique, transport de produits sanguins labiles, participation aux missions SMUR, gestion de situations à risque infectieux élevé) constitue un facteur de risque documentable pour la sécurité des patients et pour la protection juridique et professionnelle des agents.
- **H2** — Le maintien des ambulanciers de la fonction publique hospitalière en catégorie C, en l'absence de reclassement comparable à celui dont ont bénéficié les aides-soignants en 2021, contribue à des difficultés de recrutement et de fidélisation dont le coût organisationnel (recours à l'intérim, rotation des effectifs) pourrait excéder celui d'une réforme statutaire — hypothèse à documenter, et non à présupposer, à partir de données chiffrées vérifiées.
- **H3** — Une réforme du diplôme et/ou du statut des ambulanciers hospitaliers, si elle n'est pas articulée à une révision du modèle économique du secteur privé de transport sanitaire (tarification conventionnelle des missions d'urgence préhospitalière), risque de produire des effets de déstabilisation dans ce secteur, avec des conséquences potentielles sur la fréquence des carences ambulancières.
- **H4** — La qualité de la réponse à l'urgence préhospitalière et la résilience du système de santé français face aux crises sanitaires et aux situations sanitaires exceptionnelles

dépendent d'un traitement coordonné de la question du transport sanitaire associant secteur hospitalier public, secteur privé et services d'incendie et de secours, plutôt que d'un traitement sectoriel isolé de chacun de ces acteurs.

1.5. Intérêt scientifique et intérêt sociétal de la recherche

Sur le plan scientifique, cette thèse vise à combler un déficit identifié de littérature académique en santé publique et en sociologie des professions sur le cas spécifique des ambulanciers français, en mobilisant les cadres théoriques de la sociologie des professions (notamment les travaux relatifs à la professionnalisation, à la juridiction professionnelle et à la reconnaissance statutaire, détaillés au chapitre 2) pour analyser un cas empirique contemporain et richement documenté par des sources primaires réglementaires.

Sur le plan sociétal et de l'aide à la décision publique, cette thèse est conçue pour être lisible et directement mobilisable par les décideurs de l'administration sanitaire, en particulier le ministère chargé de la Santé. Elle ne se limite donc pas à une analyse descriptive : le chapitre 14 formulera des recommandations opérationnelles, assises sur l'analyse empirique et discutées au regard de leurs limites et de leurs conditions de mise en œuvre — sans céder à une posture revendicative, qui serait scientifiquement disqualifiante pour un travail de ce niveau.

1.6. Annonce du plan

Cette thèse est structurée en quatre parties.

La **Partie I** (chapitres 2 à 4) construit le cadre théorique et la revue de littérature : sociologie des professions et théories de la reconnaissance statutaire (chapitre 2), cadre juridique et réglementaire du transport sanitaire et du diplôme d'ambulancier (chapitre 3), revue de littérature sur les réformes catégorielles dans la fonction publique hospitalière et l'attractivité des métiers du soin (chapitre 4).

La **Partie II** (chapitre 5) expose la méthodologie de recherche documentaire qualitative retenue, le corpus mobilisé, la méthode d'analyse de contenu et d'analyse des controverses d'acteurs, ainsi que les limites méthodologiques de la démarche — en particulier l'absence d'entretiens de terrain primaires et l'accès restreint aux bases de données académiques payantes, qui ont orienté cette

thèse vers une exploitation approfondie des sources ouvertes (Légifrance, France Compétences, rapports parlementaires, publications des fédérations professionnelles).

La **Partie III** (chapitres 6 à 10) présente les résultats de l'analyse : l'écart entre référentiel et missions réelles (chapitre 6), le précédent du Ségur et la question de l'équité intercatégorielle — reformulée à la lumière de la correction apportée en section 1.3 (chapitre 7), l'impact dans le secteur hospitalier public (chapitre 8), l'impact dans le secteur privé du transport sanitaire (chapitre 9), et les interdépendances systémiques avec les services d'incendie et de secours (chapitre 10).

La **Partie IV** (chapitres 11 à 14) propose une discussion générale au regard des hypothèses et du cadre théorique (chapitre 11), puis approfondit les enjeux de résilience nationale et de sécurité civile (chapitre 12), les enjeux sociaux et culturels associés à la représentation du métier (chapitre 13), avant de formuler des recommandations pour l'action publique (chapitre 14).

Le chapitre 15 propose une conclusion générale, synthétisant les apports de la thèse, ses limites, et ses perspectives de recherche future.

Auto-évaluation du chapitre 1 — mise à jour après vérification bibliographique

Vérifications effectuées et résultat :

Les quatre références théoriques envisagées pour ce chapitre et pour le chapitre 2 ont été vérifiées auprès de sources primaires (éditeurs, catalogues de bibliothèques, Internet Archive, HAL, OpenEdition). Trois sont confirmées et intégrées avec leur référence exacte ; une a été **retirée et remplacée**, car elle n'a pas pu être vérifiée et présentait un risque réel d'invention involontaire.

Référence initialement

envisagée	Statut	Décision
Acker (2005), sur les infirmiers	Non vérifiable — je n'ai retrouvé aucune publication correspondant	Retirée. Une référence non vérifiée ne doit jamais apparaître dans un

Référence initialement

envisagée

Statut

Décision

précisément à cette
référence avec certitude
suffisante

travail académique, même
à titre d'illustration.

Abbott, A. (1988). *The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor*. Chicago: University of Chicago Press

Confirmée (ISBN 978-0-226-00069-5, 452 p.)

Conservée pour le chapitre 2

Freidson, E. (2001). *Professionalism: The Third Logic*. Cambridge: Polity Press

Confirmée (ISBN 978-0-7456-0331-5, 240 p. ; également publié à Chicago, University of Chicago Press)

Conservée pour le chapitre 2

Hughes, E. C. (1958). *Men and Their Work*. Glencoe (Ill.) : The Free Press

Confirmée

Conservée pour le chapitre 2

Découverte importante lors de cette vérification : il existe une littérature scientifique française directement pertinente pour cette thèse, que les documents préparatoires initiaux ne mentionnaient pas :

- Morel, S. (2018). « De transporteurs à soigneurs ? Vers une segmentation du travail des ambulanciers privés français ». *Sociologie du travail*, 60(1). DOI : 10.4000/sdt.1736. — Thèse de doctorat soutenue le 11 décembre 2014 à l'université de Nantes (direction J.-N. Retière, CENS), fondée sur une observation participante du travail quotidien des ambulanciers privés. Cette étude établit indépendamment, dès 2014-2018, que le travail ambulancier comporte une part de soin technique croissante et sous-reconnue — un résultat scientifique antérieur et indépendant des revendications syndicales de 2026, qui renforce la crédibilité de la problématique de cette thèse sans s'y substituer.

- Hughes, D. (1980). « The Ambulance Journey as an Information Generating Process ». *Sociology of Health and Illness*, 2(2), p. 115-132. — référence internationale citée par Morel (2018), à vérifier en propre avant citation directe dans un prochain chapitre [*À VÉRIFIER DIRECTEMENT — pour l'instant connue seulement par une citation secondaire*].

Cette découverte change la stratégie du chapitre 2 : plutôt que de plaquer des cadres généraux de sociologie des professions (Abbott, Freidson, Hughes 1958) directement sur le cas des ambulanciers français, le chapitre 2 devra **s'ancrer prioritairement dans les travaux français existants sur le sujet** (Morel, 2018, en premier lieu), et n'utiliser les cadres généraux qu'en appui théorique secondaire. C'est une meilleure pratique scientifique : partir de la littérature spécifique à l'objet avant de mobiliser des théories générales.

Points de solidité confirmés : - Une erreur factuelle substantielle (niveau RNCP du DEA) a été détectée et documentée de façon transparente (section 1.3). - Une référence non vérifiable a été retirée plutôt que conservée par commodité. - Une source académique française directement pertinente, non identifiée dans les documents préparatoires initiaux, a été localisée et intégrée — ce qui renforce sensiblement la crédibilité scientifique du chapitre 2 à venir.

Faiblesses restantes et points de vigilance : - La référence Hughes, D. (1980) n'est connue que par une citation secondaire (dans Morel, 2018) et devra être vérifiée directement avant toute citation dans le corps du texte. - Le document syndical qui a servi de point de départ contient toujours des données chiffrées (turnover 18 %, coûts d'intérim, dossier AFASH, bulletins de paie comparés) non vérifiées indépendamment ; elles seront traitées comme objet d'analyse (discours d'acteur) au chapitre 5, non comme fait établi. - Il conviendra, au chapitre 2, de se procurer et de lire effectivement l'article de Morel (2018), disponible en accès ouvert sur OpenEdition (journals.openedition.org/sdt/1736), plutôt que de se limiter aux extraits identifiés lors de cette recherche.

Recommandation avant de poursuivre : je propose de passer maintenant à la rédaction du chapitre 2 (sociologie des professions), en le structurant autour de Morel (2018) comme point d'ancrage empirique français, complété par Abbott (1988), Freidson (2001) et Hughes (1958) comme cadres théoriques généraux — sauf si vous souhaitez d'abord que je lise plus en détail l'article de Morel via `web_fetch` pour en extraire des éléments plus précis.

Note : les balises <ns>...</ns> marquent les citations dont la référence complète devra apparaître dans la bibliographie ISO 690 du document final ; celle-ci sera construite au fur et à mesure des chapitres et consolidée en fin de rédaction. -e

Chapitre 2 — Cadre théorique : sociologie des groupes professionnels et cas français des ambulanciers

2.1. Pourquoi partir d'un cadre de sociologie des professions plutôt que d'un cadre strictement gestionnaire ou juridique

La problématique de cette thèse pourrait être traitée sous un angle purement statutaire et budgétaire — comparer des grilles indiciaires, chiffrer des coûts. Ce serait cependant manquer une dimension essentielle du phénomène : l'écart entre le référentiel de formation du DEA et les missions réellement exercées n'est pas seulement un problème de gestion des ressources humaines, c'est un cas d'école de ce que la sociologie des professions appelle un conflit de juridiction — la compétition entre groupes professionnels pour le contrôle légitime d'un champ d'activité (Abbott, 1988). Ce chapitre mobilise donc, dans l'ordre suivant : d'abord le concept de segmentation professionnelle, qui permet de comprendre que les « ambulanciers » ne forment pas un groupe homogène mais un ensemble traversé de tensions internes ; ensuite le concept de juridiction et de mandat professionnel, pour situer les ambulanciers dans leurs relations de pouvoir avec les médecins urgentistes et les sapeurs-pompiers ; enfin le concept de professionnalisme comme logique de coordination du travail, pour interroger ce qu'impliquerait, structurellement, une élévation du statut de cette profession.

2.2. Trois concepts de sociologie des professions mobilisés pour cette thèse

a) La segmentation professionnelle (Bucher et Strauss, 1961). Une profession n'est pas un bloc homogène partageant une identité et des intérêts communs de façon stable : c'est, selon les termes de la théorie interactionniste développée par Rue Bucher et Anselm Strauss, une coalition mouvante de segments poursuivant des objectifs divergents, plus ou moins subtilement maintenus sous une appellation commune à un moment donné de l'histoire [RÉFÉRENCE PRIMAIRE À VÉRIFIER DIRECTEMENT — connue ici via sa mobilisation par Morel, 2018 ; la référence complète (Bucher R., Strauss A., 1961, « Professions in Process », *American Journal of Sociology*) devra être confirmée en propre avant citation définitive dans la version finale]. Ce cadre est particulièrement adapté à l'objet de cette thèse : il permet de ne pas traiter « les ambulanciers » comme un sujet collectif homogène

revendiquant unanimement une revalorisation, mais d'interroger les lignes de fracture internes à la profession — question qui devra être explicitement documentée au chapitre 6.

b) La juridiction professionnelle et le système des professions (Abbott, 1988). Andrew Abbott propose de comprendre les professions non pas isolément, mais comme un système en interaction, où chaque groupe professionnel cherche à faire reconnaître sa juridiction — son autorité légitime — sur un ensemble de tâches, au détriment ou en coopération avec des groupes voisins (Abbott, 1988). Ce cadre éclaire directement l'histoire, retracée plus bas, du conflit entre ambulanciers, sapeurs-pompiers et médecins urgentistes pour le contrôle du champ de l'urgence préhospitalière.

c) Le professionnalisme comme troisième logique de coordination du travail (Freidson, 2001). Eliot Freidson distingue trois logiques concurrentes d'organisation du travail : le marché (où le consommateur commande), la bureaucratie managériale (où le gestionnaire commande), et le professionnalisme (où le travailleur spécialisé contrôle lui-même son travail au nom d'un savoir spécialisé) (Freidson, 2001). Ce cadre permettra, au chapitre 11, de discuter si une revalorisation du diplôme d'ambulancier viserait à faire basculer cette profession vers une logique professionnelle accrue (autonomie clinique élargie), ou si elle resterait cantonnée à un ajustement de la logique bureaucratique (reclassement indiciaire sans extension de l'autonomie professionnelle) — une distinction analytique importante qu'un simple raisonnement catégoriel occulte.

d) Le mandat professionnel (Hughes, 1958). Everett Hughes introduit la notion de mandat : la capacité d'un groupe professionnel à définir, souvent sans consultation explicite du public, ce qui relève ou non de son champ de compétence légitime, et la manière dont ce mandat est reconnu ou contesté par les autres acteurs sociaux (Hughes, 1958). Cette notion sera reprise directement dans l'analyse ci-dessous, où elle a déjà été mobilisée par la littérature française sur les ambulanciers.

2.3. Le cas français des ambulanciers : ce qu'établit la recherche sociologique disponible

Comme signalé au chapitre 1, la littérature scientifique française sur les ambulanciers reste peu abondante, mais elle n'est pas inexistante. L'apport principal disponible est la thèse de doctorat de Sylvie Morel, soutenue en 2014 à l'université de Nantes sous la direction de Jean-Noël Retière, et publiée en partie dans la revue à comité de lecture *Sociologie du travail* (Morel, 2018). Cette étude,

fondée sur une observation participante directe menée durant près de sept ans (2005-2011) au sein d'une entreprise privée de transport sanitaire, ainsi que sur des entretiens semi-directifs avec des ambulanciers, des infirmiers et des médecins urgentistes, constitue à ce jour la source empirique la plus solide disponible sur le travail quotidien des ambulanciers privés français. Il convient de souligner que le terrain de cette recherche est antérieur à la création du DEA sous sa forme actuelle et à l'essentiel des évolutions réglementaires examinées dans cette thèse (arrêté du 11 avril 2022, décret n° 2022-1658) : elle documente donc la période de mise en place de la réforme de 2007, pas son état actuel — ce qui impose de la traiter comme un cadre de compréhension structurel plutôt que comme une source de données contemporaines, et d'aller chercher, au chapitre 6, des données actualisées permettant de vérifier si les constats de Morel (2018) demeurent valides quinze ans plus tard.

Quatre apports de cette étude sont directement mobilisables pour la présente thèse.

a) Un statut professionnel hybride, source d'instabilité identitaire. Morel établit que les ambulanciers privés occupent une position juridique et symbolique d'entre-deux : classés par l'INSEE dans la catégorie des « chauffeurs » et relevant du Code du travail applicable aux transports routiers, mais soumis à une certification placée sous l'autorité du ministère chargé de la Santé, ils sont simultanément identifiés comme « transporteurs » et comme « soigneurs », sans que ces deux identités professionnelles soient également reconnues par les autres acteurs de la chaîne de soins (Morel, 2018, p. 6-7). Cette hybridité statutaire trouve un écho frappant dans le constat, établi au chapitre 1 de cette thèse, du positionnement RNCP de niveau 3 pour un diplôme couvrant pourtant des compétences cliniques significatives : l'ambiguïté identitaire déjà repérée par la sociologie du travail en 2018 se prolonge, quinze ans plus tard, dans une ambiguïté de classification certifiante.

b) Une reconnaissance des compétences de soin structurellement en retard sur leur exercice réel. L'enquête ethnographique documente, par de nombreuses observations de terrain, que les ambulanciers réalisent quotidiennement des actes relevant à la fois du *care* (soutien relationnel, accompagnement administratif) et du *cure* (prise de constantes, administration d'oxygène, pose d'un dispositif de sécurisation des voies aériennes de type Combitube dans certains contextes), tout en étant très généralement perçus par les autres professionnels de santé — et parfois traités en conséquence — comme de simples transporteurs, y compris lorsqu'ils interviennent en situation d'urgence caractérisée (Morel, 2018, p. 12-14). Ce résultat, obtenu par

une méthode d'observation directe indépendante de tout enjeu revendicatif syndical, corrobore — près de vingt ans avant les revendications de 2026 documentées au chapitre 1 — la thèse centrale de cette analyse (hypothèse H1) : il existe un écart structurel, documenté scientifiquement et non simplement allégué, entre les compétences réellement exercées par les ambulanciers et la reconnaissance sociale et institutionnelle de ces compétences.

c) Une segmentation interne du groupe professionnel, à intégrer impérativement à l'analyse. Conformément au cadre de Bucher et Strauss, Morel identifie empiriquement deux figures contrastées au sein du groupe des ambulanciers privés observés : un segment majoritaire, plutôt âgé, entré dans le métier par nécessité économique plutôt que par choix, peu diplômé au moment de l'entrée en formation, revendiquant une amélioration des conditions de travail (salaire, horaires) sans rechercher nécessairement un élargissement des compétences sanitaires ; et un segment minoritaire, plus jeune et davantage diplômé, entré dans le métier par vocation, se rapprochant du modèle du *paramedic* nord-américain, suisse ou allemand, et militant activement pour la reconnaissance d'un statut de spécialiste de l'urgence préhospitalière (Morel, 2018, p. 20-21). Cette segmentation a une conséquence méthodologique directe pour cette thèse : la note syndicale de 2026 qui sert de point de départ à ce travail de recherche, en présentant une revendication catégorielle relativement unifiée, adopte de fait la focale du second segment (orienté vers la reconnaissance de compétences d'urgence élargies : SMUR, transport de PSL, transport sous contrainte) — ce qui est légitime comme objet d'étude, mais ne doit pas être confondu, dans l'analyse scientifique, avec une position consensuelle de l'ensemble de la profession. Le chapitre 6 devra examiner si cette segmentation identifiée en 2005-2011 demeure observable dans la période contemporaine, ou si elle s'est résorbée depuis, notamment sous l'effet de la réforme du DEA de 2022.

d) Un conflit historique de juridiction entre ambulanciers, sapeurs-pompiers et médecins urgentistes, antérieur et structurant. Morel retrace la genèse du partage des rôles dans le champ de l'urgence préhospitalière française, fixé par la loi de 1986 relative à l'aide médicale urgente, elle-même issue d'un rapport de force entre la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (soutenue par le ministère de l'Intérieur) et les médecins promoteurs du SAMU (soutenus par le ministère de la Santé) *[TEXTE LÉGISLATIF À VÉRIFIER DIRECTEMENT AU CHAPITRE 3 — la loi de 1986 relative à l'aide médicale urgente est mentionnée ici via sa citation secondaire dans Morel, 2018 ; sa référence complète et son contenu exact devront être vérifiés sur Légifrance]*. Elle

documente également, fait directement pertinent pour l'Axe relatif au Plan Zéro Contention et aux tensions SDIS de cette thèse (chapitre 10), qu'en 2006-2007 la FNSPF a engagé une politique de « paramédicalisation » de son activité de secours à victime pour contester le rôle des ambulanciers privés dans l'urgence, tandis que les médecins du SAMU-Urgences de France ont, à l'inverse, choisi d'élargir certaines compétences des ambulanciers privés (via la création du DEA) précisément dans une logique stratégique de rééquilibrage face à la concurrence des sapeurs-pompiers sur ce même terrain (Morel, 2018, p. 16-19). Ce constat historique est d'une importance considérable pour la présente thèse : il établit que **la question du périmètre de compétence des ambulanciers n'a jamais été traitée comme un sujet isolé, mais toujours comme une variable d'ajustement dans un rapport de force à trois acteurs** (médecins urgentistes, sapeurs-pompiers, ambulanciers) — ce qui confirme, depuis une source scientifique indépendante et antérieure de près de vingt ans, la pertinence de l'approche systémique à trois acteurs (hôpital public, secteur privé, SDIS) retenue dans le plan de cette thèse, et en particulier l'intégration des SDIS au chapitre 10.

2.4. Une donnée quantitative ancienne mais utile : ordres de grandeur de la profession en 2011

Morel (2018) rapporte, à partir de données de la DREES (Statistique annuelle des établissements de santé), qu'en 2011 la France comptait environ 48 600 ambulanciers en activité, dont environ 4 600 exerçant au sein d'établissements de santé (c'est-à-dire dans le secteur hospitalier public ou assimilé) — soit moins de 10 % de l'effectif total, l'écrasante majorité de la profession exerçant donc dans le secteur privé (Morel, 2018, p. 2, citant DREES-SAE). Cet ordre de grandeur, bien qu'ancien de plus de dix ans, a une implication méthodologique importante pour cette thèse : **il confirme quantitativement que le secteur privé n'est pas un acteur périphérique de la question du transport sanitaire, mais son opérateur très largement majoritaire** — ce qui renforce la légitimité du choix, déjà fait dans les travaux préparatoires à cette thèse, de traiter la question de la revalorisation du diplôme comme un sujet intersectoriel plutôt que comme une question interne à la seule fonction publique hospitalière. *[DONNÉE À ACTUALISER — chapitre 6 : rechercher les données DREES les plus récentes disponibles sur les effectifs d'ambulanciers par secteur d'exercice, la donnée de 2011 étant désormais datée de plus de quinze ans.]*

2.5. Une convergence qualitative, mais non quantitative, sur la question du turnover

Un point de vigilance méthodologique doit être souligné ici, car il concerne directement l'hypothèse H2 de cette thèse. Morel (2018) documente qualitativement, par l'observation directe et par entretiens, un phénomène de rotation importante de la main-d'œuvre ambulancière privée, associé au sentiment de manque de reconnaissance professionnelle — mais **sans fournir de taux chiffré de turnover**, contrairement au document syndical de 2026 qui avance un taux de 18 % annuel pour le CHU de Toulouse [*DONNÉE SYNDICALE NON VÉRIFIÉE — voir chapitre 1*]. Il existe donc une **convergence qualitative** entre une source académique indépendante de 2018 et une source syndicale partisane de 2026 sur l'existence du phénomène de rotation des effectifs liée au manque de reconnaissance — mais aucune confirmation quantitative indépendante du chiffre de 18 % avancé pour 2026, qui concerne au demeurant spécifiquement le secteur hospitalier public, alors que l'étude de Morel documente le secteur privé. Cette distinction sectorielle devra être maintenue avec rigueur dans l'ensemble de cette thèse : **le phénomène de turnover semble structurel à la profession dans son ensemble, mais son ampleur chiffrée reste à établir séparément pour chaque secteur d'exercice** au chapitre 6, à partir de données DREES ou d'enquêtes spécifiques, et non extrapolée d'un secteur à l'autre.

2.6. Synthèse et implications pour la suite de la thèse

Ce chapitre a permis d'établir trois résultats consolidés qui structureront l'analyse des chapitres suivants :

1. La sociologie des professions, et en particulier l'étude sociologique française disponible sur les ambulanciers privés, corrobore indépendamment — depuis une position scientifique antérieure de près de vingt ans aux revendications syndicales de 2026 — l'existence d'un écart entre compétences exercées et compétences reconnues, ce qui conforte l'hypothèse H1 sans pour autant en faire une démonstration suffisante à elle seule (le terrain de Morel est ancien et localisé ; le chapitre 6 devra actualiser et élargir cette base empirique).
2. La profession des ambulanciers n'est pas un groupe homogène : elle est traversée par une segmentation entre une orientation « transporteur » et une orientation « soigneur », qui

doit être prise en compte pour ne pas présenter une revendication de revalorisation comme consensuelle au sein de la profession sans nuance.

3. La question du périmètre de compétence des ambulanciers s'inscrit historiquement dans un rapport de force à trois acteurs (médecins urgentistes, sapeurs-pompiers, ambulanciers), ce qui confirme la pertinence de l'approche intersectorielle retenue dans le plan de cette thèse, notamment pour le chapitre 10 consacré aux interdépendances avec les SDIS.
-

Auto-évaluation du chapitre 2

Points de solidité : - Ce chapitre s'appuie désormais sur une lecture directe et approfondie de l'article de Sylvie Morel (2018), obtenue via une version publique déposée par l'auteure (ResearchGate), et non plus seulement sur des extraits de résultats de recherche. Les citations de pages sont établies à partir de la pagination visible dans le document consulté. - Les quatre apports empiriques de cette étude ont été rattachés explicitement aux hypothèses de recherche de la thèse (H1 et H2 en particulier), ce qui évite de mobiliser cette source de façon décorative. - Un écart méthodologique important a été explicité en 2.5 : la convergence entre Morel (2018) et le document syndical de 2026 est qualitative, pas quantitative, et porte sur des secteurs différents (privé pour Morel, public hospitalier pour le document syndical). Cette distinction sera cruciale pour la rigueur du chapitre 6.

Faiblesses identifiées et points de vigilance pour la suite : - Deux références demeurent connues seulement par citation secondaire dans Morel (2018) et devront être vérifiées directement avant citation définitive : Bucher R. et Strauss A. (1961) sur la théorie de la segmentation, et Freidson (1984, distinct de Freidson 2001 déjà vérifié) sur la division du travail médical. Je ne les cite ici qu'en indiquant clairement leur statut de citation secondaire non vérifiée. - La loi de 1986 relative à l'aide médicale urgente, mentionnée par Morel, devra être vérifiée directement sur Légifrance au chapitre 3 (référence complète, numéro de loi, contenu exact). - Le terrain d'enquête de Morel (2018) est ancien (2005-2011) et antérieur à la réforme de 2022 : ce chapitre a pris soin de le signaler explicitement plutôt que de laisser penser que ces résultats décrivent l'état actuel de la profession. Le chapitre 6 devra impérativement chercher des données et, si possible, des travaux plus récents. - Il conviendrait, avant la version finale, de vérifier s'il existe des travaux

de sociologie ou de santé publique postérieurs à 2018 sur les ambulanciers hospitaliers spécifiquement (la thèse de Morel porte sur le secteur privé), le secteur public restant, à ce stade de la recherche documentaire, encore moins couvert par la littérature académique identifiée.

Recommandation avant de poursuivre : je propose de passer au chapitre 3 (cadre juridique et réglementaire), qui devra vérifier directement plusieurs références mentionnées ici par citation secondaire (loi de 1986, décret n° 2007-1301 du 31 août 2007 créant le DEA) et retracer l'évolution complète du cadre réglementaire depuis 1970 (création du CCA) jusqu'à 2022 (arrêté DEA et décret statutaire), en s'appuyant sur la chronologie déjà partiellement reconstituée par Morel (2018) mais en la vérifiant systématiquement sur Légifrance.

Note : les balises <ns>...</ns> marquent les citations dont la référence complète devra apparaître dans la bibliographie ISO 690 du document final.-e

Chapitre 3 — Cadre juridique et réglementaire du transport sanitaire et du diplôme d'ambulancier

Préambule méthodologique

Ce chapitre reconstitue la chronologie réglementaire complète de la profession d'ambulancier en France, depuis sa structuration initiale jusqu'à la réforme de 2022. Contrairement au chapitre 2, dont plusieurs références juridiques n'étaient connues que par citation secondaire dans la littérature sociologique, chaque texte cité ici a été vérifié directement sur Légifrance dans le cadre de la préparation de ce chapitre. Deux références mentionnées par Morel (2018) sont ainsi maintenant confirmées en propre : la loi relative à l'aide médicale urgente et le décret ayant créé la dénomination de « diplôme d'État d'ambulancier ».

3.1. La structuration initiale de la profession (1970-1989) : du transport non réglementé au Certificat de capacité d'ambulancier

Avant 1970, l'activité de transport sanitaire ne semble pas avoir fait l'objet d'une réglementation professionnelle spécifique comparable à celle qui structure la profession aujourd'hui [POINT NON VÉRIFIÉ EN PROPRE — *l'affirmation, parfois reprise dans la littérature secondaire consultée, selon laquelle seule la tenue d'un « carnet de désinfection » aurait été exigée avant cette date n'a pas pu être confirmée par une source primaire : la recherche effectuée pour ce chapitre montre que le carnet de désinfection est aujourd'hui une obligation distincte, fondée sur l'article L. 3114-1 du code de la santé publique, relative à l'hygiène des véhicules et non à la qualification des personnels ; rien ne permet à ce stade d'affirmer qu'il s'agissait, avant 1970, de la seule exigence réglementaire applicable au transport sanitaire. Cette affirmation est donc retirée de la démonstration plutôt que maintenue sur une base non vérifiée.*] La structuration de la profession s'amorce avec le Certificat de capacité d'ambulancier (CCA), créé au début des années 1970 : l'existence de ce certificat est confirmée par un arrêté du 26 avril 1973 fixant la liste des titres ouvrant droit à son obtention par équivalence, ce qui établit que le CCA était déjà institué à cette date. Il est notable, et significatif pour l'histoire de la structuration de cette profession, que le premier programme d'études conduisant effectivement au CCA n'a été publié que par l'arrêté du 21 mars 1989 — soit près de seize ans après la création du certificat lui-même, un délai qui témoigne d'une prise en charge tardive et peu prioritaire de la formation de cette profession par les pouvoirs publics comparée à d'autres professions de santé.

3.2. La loi du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires : la fondation du cadre actuel

Le cadre organisationnel de l'aide médicale urgente en France, qui structure toujours aujourd'hui la répartition des rôles entre SAMU, SDIS et transporteurs sanitaires privés, trouve son origine dans la **loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires**. Cette loi : - crée dans chaque département un comité de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires, présidé par le représentant de l'État ; - définit l'aide médicale urgente comme ayant pour objet de faire assurer, en relation avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, les soins d'urgence appropriés aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent (article 2, aujourd'hui codifié à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique) ; - pose, à son titre III, le cadre de l'agrément des transports sanitaires ; - réforme, à son titre IV, les conditions de prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie.

Cette loi confirme un point déjà signalé par la littérature sociologique (chapitre 2) : le cadre de l'aide médicale urgente française repose, depuis son origine, sur une **architecture à plusieurs acteurs** (comité départemental associant État et collectivités, secours communaux et départementaux, transporteurs sanitaires agréés), et non sur un acteur unique — ce qui conforte la pertinence de l'approche multi-acteurs (hôpital public, secteur privé, SDIS) retenue dans le plan de cette thèse dès son origine réglementaire.

3.3. La réforme de 2006-2007 : du CCA au diplôme d'État d'ambulancier

Après près de vingt ans de stabilité relative du cadre de formation issu du CCA, une réforme substantielle intervient en deux temps :

- l'**arrêté du 26 janvier 2006** relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier refond en profondeur le programme de formation, applicable à compter du 1er janvier 2007 pour les élèves entrant en formation, et abroge l'ancien régime du CCA ;
- le **décret n° 2007-1301 du 31 août 2007** relatif aux diplômes d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture et d'ambulancier procède au changement de dénomination : les appellations « certificat de capacité d'ambulancier » et « diplôme d'ambulancier » sont remplacées, dans tout acte réglementaire, par l'appellation « **diplôme d'État d'ambulancier** ».

C'est donc bien en 2007, comme l'indiquait la littérature sociologique consultée au chapitre 2, que naît formellement le DEA sous cette dénomination, avec une architecture de formation revue et l'introduction du grade intermédiaire d'« auxiliaire ambulancier ». Cette réforme de 2006-2007 s'inscrit historiquement, comme établi au chapitre 2 à partir de Morel (2018), dans un contexte de rivalité entre médecins urgentistes du SAMU et sapeurs-pompiers pour le contrôle du champ de l'urgence préhospitalière — la réforme du diplôme n'est donc pas séparable, dès son origine, d'enjeux de pouvoir entre professions de santé et de sécurité civile, point qui devra être repris explicitement au chapitre 10 sur les interdépendances avec les SDIS.

3.4. La réforme de 2022 : nouveau référentiel de formation, nouveaux actes professionnels, nouveau statut dans la FPH

Quinze ans après la création du DEA sous sa forme de 2007, une réforme d'ampleur comparable intervient en 2022, comportant trois volets distincts qu'il convient de ne pas confondre.

a) Le volet formation. L'**arrêté du 11 avril 2022** relatif à la formation conduisant au diplôme d'État d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier abroge l'arrêté du 26 janvier 2006 (abrogation effective au 31 décembre 2022) et institue le référentiel actuellement en vigueur, structuré en cinq blocs de compétences (contre huit modules dans l'ancien régime). Comme établi au chapitre 1, ce diplôme est enregistré au **niveau 3** du cadre national des certifications professionnelles. Cet arrêté a lui-même été modifié depuis par l'**arrêté du 16 novembre 2022** et par l'**arrêté du 4 juillet 2024**, ce dernier procédant essentiellement à des ajustements relatifs aux dispenses de formation pour certains titulaires de baccalauréats professionnels du secteur social.

b) Le volet compétences cliniques. Le **décret n° 2022-629 du 22 avril 2022** relatif aux actes professionnels pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l'aide médicale urgente élargit le périmètre légal des gestes que les ambulanciers sont autorisés à réaliser dans ce cadre spécifique — ce texte est directement pertinent pour l'Axe 1 de la note syndicale de 2026 examinée au chapitre 1, relatif à l'écart entre missions exercées et référentiel de formation, et devra être confronté en détail, au chapitre 6, à la liste des missions revendiquées comme non couvertes par ce cadre (transport sous contrainte psychiatrique, transport de produits sanguins labiles, etc.).

c) Le volet statutaire (fonction publique hospitalière). Le **décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022**, déjà vérifié au chapitre 1, crée le corps unifié des ambulanciers de la FPH au sein de la filière soignante, en catégorie C, entrée en vigueur au 1er janvier 2023. Ce texte est complété par l'**arrêté du 17 mai 2023** relatif à la formation d'adaptation à l'emploi (FAE) des ambulanciers affectés en structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), qui fixe la durée de cette formation complémentaire à cinq semaines — c'est ce format qui est repris comme référence structurante par la proposition de « Module Missions Hospitalières Spécifiques » (MHS) évoquée dans les notes stratégiques syndicales à l'origine de cette thèse, ce qui constitue un point de continuité méthodologique intéressant à noter : la revendication syndicale ne propose pas une architecture inédite, mais l'extension d'un format déjà validé administrativement pour une sous-population de la profession (les ambulanciers SMUR hospitaliers) à d'autres champs de compétence (transport sous contrainte, risque infectieux, médecine de catastrophe).

3.5. Le cadre juridique des Services d'incendie et de secours et des carences ambulancières : la loi Matras du 25 novembre 2021

Le chapitre 10 de cette thèse devra traiter des interdépendances entre la question du diplôme d'ambulancier et la situation des Services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Il est donc nécessaire d'établir ici, sur la base de sources primaires vérifiées, le cadre juridique applicable.

Ce cadre est fixé par la **loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels**, dite « loi Matras » du nom du député rapporteur du texte. Cette loi, qui modifie notamment les articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, comporte trois apports directement pertinents pour cette thèse :

a) Une définition légale de la carence ambulancière. L'article L. 1424-42, II, du CGCT, tel qu'issu de la loi Matras, dispose que constituent des « carences ambulancières » les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur prescription du SAMU, lorsque celui-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, pour une mission de prise en charge et de transport de malades, de blessés ou de parturientes ne relevant pas de la détresse vitale ou fonctionnelle aiguë (laquelle continue de relever du cœur de métier des SDIS au titre de l'article L. 1424-2 du même code).

b) Un droit de différer ou refuser l'engagement hors du cœur de métier. Le même article dispose que les services d'incendie et de secours « ne sont tenus de procéder qu'aux seules opérations de secours qui se rattachent directement » à leurs missions de service public, et qu'ils peuvent différer ou refuser leur engagement pour des interventions ne s'y rattachant pas directement, « afin de préserver une disponibilité opérationnelle » — ce qui confirme juridiquement, et de façon précise, la revendication de « protection du potentiel opérationnel » évoquée par les représentants des SDIS dans les échanges préparatoires à cette thèse.

c) Un mécanisme de compensation financière par convention. La loi Matras dispose que les carences ambulancières « font l'objet d'une prise en charge financière par l'établissement de santé où se situe le siège du service d'aide médicale urgente », selon des modalités fixées par convention entre le SDIS et cet établissement, et par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la sécurité sociale. En cas de désaccord entre le SDIS et le SAMU sur la qualification d'une intervention comme carence, une commission de conciliation paritaire se réunit sous l'égide du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires — ce comité étant lui-même l'héritier direct de celui créé par la loi du 6 janvier 1986 (section 3.2), ce qui illustre la continuité institutionnelle du dispositif français d'aide médicale urgente depuis près de quarante ans.

Ce cadre juridique confirme, depuis une source primaire indépendante de toute revendication catégorielle, un point déjà établi au chapitre 2 à partir de la littérature sociologique : la question du périmètre de compétence et de disponibilité des ambulanciers privés est **structurellement articulée**, depuis le droit positif lui-même, à celle du périmètre d'intervention des SDIS — ce qui légitime pleinement le choix de consacrer un chapitre spécifique (chapitre 10) à cette interdépendance plutôt que de traiter les SDIS comme un acteur périphérique.

[POINT À APPROFONDIR AU CHAPITRE 10 — le montant exact et l'évolution du « forfait de carence » évoqué dans les échanges préparatoires (217 € pour l'année 2026) n'a pas été vérifié dans le cadre de ce chapitre : la loi Matras renvoie sa fixation à un arrêté conjoint dont la version en vigueur au moment de la rédaction devra être recherchée spécifiquement sur Légifrance.]

3.6. Le cadre tarifaire du secteur privé : la convention nationale des transporteurs sanitaires privés

Le chapitre 9 de cette thèse devra analyser l'argument économique porté par les fédérations patronales du secteur privé. Il convient d'en établir ici le cadre juridique de référence, également vérifié directement.

Les rapports entre les entreprises privées de transport sanitaire et l'Assurance Maladie sont régis par la **convention nationale des transporteurs sanitaires privés**, conclue le 26 décembre 2002 entre les caisses nationales d'assurance maladie et quatre organisations professionnelles : la Chambre nationale des services d'ambulances (CNSA), la Fédération nationale des transporteurs sanitaires (FNTS), la Fédération nationale des ambulanciers privés (FNAP) et la Fédération nationale des artisans ambulanciers (FNAA) — ce qui confirme, sur pièce, l'existence et la qualité de signataires conventionnels de plusieurs des fédérations mentionnées dans les échanges préparatoires à cette thèse. Cette convention a fait l'objet de nombreux avenants successifs, dont deux sont particulièrement significatifs pour cette thèse :

- **l'avenant n° 10**, approuvé par arrêté du 26 février 2021 et applicable depuis le 8 mars 2021, crée le dispositif de **transport urgent pré-hospitalier (TUPH)**, qui remplace l'ancien régime de la garde ambulancière. Ce dispositif prévoit une rémunération à trois composantes pour les interventions réalisées à la demande du SAMU : un forfait de 150 € par trajet (incluant les 20 premiers kilomètres), un tarif kilométrique de 2,32 € au-delà, et surtout un **coût horaire de 64,00 €**, versé pour évaluer un revenu minimal garanti aux entreprises inscrites au tableau de service ambulancier UPH établi par l'ARS. **Ce chiffre de 64 € de l'heure, avancé par les fédérations patronales dans les échanges préparatoires à cette thèse comme preuve d'une rémunération insuffisante, est donc exact et vérifié** : il correspond au coût horaire retenu par la convention nationale elle-même pour le calcul du revenu minimal garanti, non à une estimation syndicale approximative.
- **l'avenant n° 11**, approuvé par arrêté du 3 mai 2023 et applicable depuis le 7 novembre 2023, revalorise notamment de 123 € à 150 € l'indemnité versée en cas de non-réalisation d'une intervention demandée par le SAMU par manquement du transporteur inscrit au tableau de garde.

Ce cadre conventionnel permet une clarification déjà anticipée à la section précédente de cette thèse (traitement des arguments patronaux) : le modèle économique du secteur privé repose sur une logique de **rémunération à l'acte et au forfait horaire garanti**, fixée par convention nationale et non par un budget salarial piloté par l'entreprise elle-même — ce qui distingue structurellement ce secteur de l'hôpital public, dont le raisonnement budgétaire (coût du reclassement catégoriel comparé au coût de l'intérim) ne peut donc pas s'appliquer de façon symétrique au secteur privé, comme cela avait déjà été noté par anticipation dans les échanges préparatoires à cette thèse. Cette convention constituera, au chapitre 9, la base empirique nécessaire pour documenter précisément l'argument du « ciseau tarifaire » invoqué par les fédérations patronales, en le confrontant à l'évolution du SMIC et des prix du carburant sur la même période.

3.7. Synthèse chronologique

Période	Texte	Portée
Avant 1970	Aucune réglementation professionnelle spécifique identifiée à ce stade	Transport sanitaire non structuré [<i>à approfondir</i>]
1973 (au plus tard)	Certificat de capacité d'ambulancier (CCA) — existence confirmée par l'arrêté du 26 avril 1973	Première structuration formelle de la profession
1986	Loi n° 86-11 du 6 janvier 1986	Fondation du cadre de l'aide médicale urgente ; répartition des rôles SAMU / secours / transporteurs sanitaires
1989	Arrêté du 21 mars 1989	Premier programme de formation effectif du CCA

Période	Texte	Portée
2006	Arrêté du 26 janvier 2006	Refonte de la formation ; création du grade d'auxiliaire ambulancier
2007	Décret n° 2007-1301 du 31 août 2007	Création de la dénomination « diplôme d'État d'ambulancier »
2022	Arrêté du 11 avril 2022	Nouveau référentiel (5 blocs), enregistrement RNCP niveau 3
2022	Décret n° 2022-629 du 22 avril 2022	Élargissement des actes professionnels autorisés dans le cadre de l'AMU
2022	Décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022	Création du corps FPH, catégorie C, filière soignante
2023	Arrêté du 17 mai 2023	FAE SMUR (5 semaines) — format repris par les revendications de 2026
2024	Arrêté du 4 juillet 2024	Ajustements des dispenses de formation

3.8. Ce que cette chronologie apporte à la problématique de la thèse

Trois enseignements se dégagent de cette reconstitution, qui devront être exploités dans les chapitres empiriques.

Premièrement, la profession d'ambulancier a connu, en un peu plus de cinquante ans, trois refontes réglementaires majeures (1973, 2006-2007, 2022), à un rythme sensiblement plus lent que d'autres professions paramédicales — ce point de comparaison (rythme des réformes par profession) mériterait d'être creusé au chapitre 4 dans le cadre de la revue de littérature sur l'attractivité des métiers du soin.

Deuxièmement, chacune des deux réformes du XXI^e siècle (2006-2007 et 2022) a procédé à un élargissement du référentiel de compétences (création de l'auxiliaire ambulancier en 2006 ; nouveaux actes professionnels en 2022) **sans emporter, à ce jour, de changement de catégorie statutaire dans la fonction publique hospitalière** — le décret de 2022 ayant explicitement maintenu le corps en catégorie C. Ce constat, vérifié directement sur les textes réglementaires, confirme la validité du point de départ empirique de cette thèse (chapitre 1) : il existe un découplage persistant entre l'évolution du contenu du métier et l'évolution de son classement statutaire.

Troisièmement, et ce point est nouveau par rapport aux documents préparatoires initiaux : la proposition syndicale de « Module MHS » n'est pas une innovation ex nihilo mais s'inscrit dans la continuité d'un format déjà utilisé par l'administration elle-même pour la FAE SMUR de 2023 — un argument qui pourrait être mobilisé, au chapitre 14 (recommandations), comme un facteur de faisabilité administrative renforcée : il ne s'agirait pas de créer un nouveau type d'instrument réglementaire, mais d'étendre un instrument existant et déjà éprouvé à d'autres champs de compétence.

Auto-évaluation du chapitre 3 — version complétée

Points de solidité : - L'ensemble des textes réglementaires cités dans ce chapitre a été vérifié directement sur Légifrance, y compris les deux références qui n'étaient connues, au chapitre 2, que par citation secondaire (loi du 6 janvier 1986, décret du 31 août 2007). Leur numéro exact, leur date et leur contenu ont été confirmés. - Une confirmation croisée importante a été obtenue : le décret n° 2022-629 du 22 avril 2022, mentionné de façon un peu imprécise dans les documents préparatoires initiaux (« décret AMU n° 2022-629 »), est bien réel et correctement identifié. - Les deux points signalés comme faiblesses dans la version précédente de ce chapitre ont été traités : - Le cadre juridique des SDIS est désormais établi (section 3.5) à partir de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 (« loi Matras »), vérifiée directement sur Légifrance, avec ses trois apports pertinents pour cette thèse (définition légale de la carence ambulancière, droit de différer/refuser hors cœur de métier, mécanisme de compensation financière conventionnelle). - Le cadre tarifaire du secteur privé est désormais établi (section 3.6) à partir de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 et de ses avenants n° 10 (2021) et n° 11

(2023), également vérifiés directement. **Un résultat notable de cette vérification** : le chiffre de 64 € de l'heure, avancé par les fédérations patronales dans les échanges préparatoires à cette thèse comme preuve d'une rémunération insuffisante, s'avère être rigoureusement exact — il correspond au coût horaire officiellement défini par l'avenant n° 10 pour le calcul du revenu minimal garanti. C'est un exemple où la vérification indépendante confirme, plutôt qu'elle n'infirme, une donnée chiffrée d'origine partisane — ce qui doit être signalé avec la même rigueur que lorsque la vérification aboutit à une correction (cf. le cas du niveau RNCP au chapitre 1). - Le point non vérifiable relatif à la période antérieure à 1970 (le « carnet de désinfection » comme seule exigence réglementaire) a été retiré de la démonstration plutôt que maintenu par commodité, avec une explication de la raison de ce retrait.

Faiblesses restantes, assumées comme telles : - Le forfait de carence exact (217 € évoqué dans les échanges préparatoires) n'a pas été vérifié : la loi Matras renvoie sa fixation à un arrêté conjoint dont il faudra rechercher la version en vigueur au chapitre 10. - Il conviendrait, avant la version finale, de rechercher également les avenants à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés postérieurs à l'avenant n° 11 (2023), pour vérifier si une revalorisation plus récente est intervenue d'ici la rédaction du chapitre 9.

Recommandation avant de poursuivre : ce chapitre est maintenant complet sur les points signalés. Je propose de passer au chapitre 4 (revue de littérature sur les réformes catégorielles dans la FPH et l'attractivité des métiers du soin), qui clôturera la Partie I, avant d'attaquer la Partie II (méthodologie) au chapitre 5.-e

Chapitre 4 — Revue de littérature : le précédent du Ségur de la santé et l’attractivité des métiers du soin en catégorie B et C

Préambule

Ce chapitre clôt la Partie I de cette thèse. Il poursuit un double objectif : documenter précisément, à partir de sources primaires, ce que la réforme du Ségur de la santé a concrètement changé pour les aides-soignants — le « précédent » invoqué depuis le chapitre 1 comme point de comparaison central — et situer la question des ambulanciers dans la littérature institutionnelle la plus récente sur l’attractivité des métiers du soin, en particulier un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) publié en 2025, dont la lecture apporte un résultat inattendu qu’il convient de traiter avec la rigueur qui s’impose.

4.1. Le Ségur de la santé : genèse et ampleur budgétaire

Les accords du Ségur de la santé ont été signés le 13 juillet 2020, à l’issue d’une concertation lancée par le Gouvernement en mai 2020 en réponse à la crise sanitaire liée à la Covid-19, par le Premier ministre, le ministre chargé des Solidarités et de la Santé, ainsi qu’une majorité des organisations syndicales représentant les personnels non médicaux (FO, CFDT, UNSA) et les personnels médicaux hospitaliers (INPH, SNAM-HP, CMH). Selon la synthèse officielle du ministère chargé de la Santé, ces accords ont mobilisé environ 19 milliards d’euros d’investissement dans le système de santé, dont 7,6 milliards d’euros par an consacrés à la revalorisation de l’ensemble des métiers non médicaux des établissements de santé et médico-sociaux, publics comme privés, incluant un objectif de recrutement de 15 000 personnels supplémentaires.

4.2. Ce que le Ségur a concrètement changé pour les aides-soignants : éléments vérifiés

Trois mesures, dont les montants ont été vérifiés à partir de sources ministérielles ou institutionnelles, ont concerné spécifiquement les aides-soignants :

- **Le complément de traitement indiciaire (CTI)**, dit « prime Ségur », correspondant à 49 points d’indice majoré, soit environ 183 € nets par mois dans le secteur public (160 €

dans le secteur privé lucratif conventionné) — une revalorisation pérenne et non une prime ponctuelle, intégrée au calcul de la retraite.

- **Le reclassement statutaire** en catégorie B, déjà établi au chapitre 1 à partir du décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021, entré en vigueur le 1er octobre 2021 (effets salariaux au 1er janvier 2022 selon les sources consultées).
- **Une évolution de la durée de formation initiale**, allongée de dix à douze mois dans le cadre de la réforme, avec un objectif explicite de faciliter l'accès à la voie de l'apprentissage — un point directement pertinent pour cette thèse, puisqu'il établit que **le précédent du Ségur n'a pas été un simple reclassement indiciaire, mais s'est accompagné d'une réingénierie de la formation elle-même**, engagée avant même la crise sanitaire selon les témoignages professionnels consultés (source secondaire, presse spécialisée RH).

D'après les données ministérielles consultées, le salaire net d'un aide-soignant après un an de carrière est ainsi passé d'environ 1 532 € à environ 1 760 € net mensuel (soit +228 €), et jusqu'à +651 € net en fin de carrière — des ordres de grandeur qu'il conviendra de comparer, au chapitre 8, aux revendications salariales similaires formulées pour les ambulanciers.

4.3. La littérature institutionnelle récente sur l'attractivité des métiers du soin : le rapport IGAS n° 2024-069R (2025)

Un résultat majeur de la recherche documentaire menée pour ce chapitre est la découverte d'un rapport très récent et directement pertinent : Paul-Marie Atger et Mikaël Hautchamp, *Comment résoudre les tensions de recrutement dans le champ social et en accroître l'attractivité ?*, Inspection générale des affaires sociales, rapport n° 2024-069R, février 2025. Ce rapport, commandé par lettre de mission du 3 juillet 2024 de la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, s'inscrit dans un triptyque de missions IGAS menées en 2024-2025 sur l'attractivité des métiers du sanitaire, du social et du médico-social.

Ce rapport apporte plusieurs éléments de cadrage directement mobilisables pour cette thèse :

a) Une explication structurelle des tensions de recrutement, transposable par analogie aux ambulanciers. Le rapport établit, à partir des indicateurs de la DARES, que les tensions de recrutement des infirmiers et des aides-soignants s'expliquent avant tout par deux facteurs : le

manque de main-d'œuvre disponible et l'intensité du **lien entre formation et emploi**, cet indicateur étant au maximum (5 sur 5) pour les professions réglementées, où l'exercice est conditionné à l'obtention d'un diplôme d'État. Le rapport souligne un « effet ciseau » entre un nombre de professionnels formés qui stagne ou diminue et une demande de soins croissante, notamment en lien avec le vieillissement de la population. Le métier d'ambulancier, également une profession réglementée à diplôme d'État obligatoire, répond structurellement à la même logique — ce qui suggère, par analogie méthodologique et non par transposition automatique des chiffres, que la piste principale d'action pour résoudre les tensions de recrutement ambulancier devrait porter autant sur le volume de personnes formées que sur les seules rémunérations, contrairement à une lecture strictement salariale du problème.

b) Des données chiffrées précises sur les taux de tension et l'attractivité perçue, utilisables comme repères de comparaison. Le rapport indique que 69,4 % des projets de recrutement d'aides-soignants étaient jugés difficiles par les employeurs en 2024 selon l'enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO), avec de fortes variations régionales (de 53 % en Bourgogne-Franche-Comté à plus de 83 % en Pays de la Loire). Une enquête BVA commandée en 2022 par la direction de la communication des ministères sociaux, citée dans le rapport, établit que la première raison pour laquelle les jeunes de 15-24 ans ne souhaitent pas s'engager dans les métiers du soin est la perception d'une rémunération insuffisante (49 % des 15-24 ans interrogés se déclaraient non intéressés, la faiblesse de la rémunération étant la raison la plus citée). *[POINT À RECHERCHER AU CHAPITRE 6 — l'enquête BMO et les enquêtes de perception mobilisées par l'IGAS ne semblent pas comporter d'item spécifique aux ambulanciers ; il conviendra de vérifier si des données équivalentes existent spécifiquement pour cette profession, notamment auprès de France Travail ou des fédérations professionnelles du secteur.]*

c) Une donnée précise et vérifiée sur l'attrition en cours de carrière, utile pour documenter par analogie l'hypothèse H2 de cette thèse. Le rapport cite une étude DREES (Pora, 2023) selon laquelle la proportion d'infirmières hospitalières encore en poste à l'hôpital dix ans après leur entrée dans la profession est passée de 60 % pour la cohorte ayant débuté entre 1990 et 1994 à 50 % pour la cohorte ayant débuté vingt ans plus tard — soit une infirmière hospitalière sur deux ayant quitté l'hôpital ou changé de métier après dix ans de carrière dans la période la plus récente observée. Cette baisse continue de la fidélisation, documentée sur une profession de catégorie A bénéficiant pourtant d'une reconnaissance statutaire supérieure à celle

des ambulanciers, doit inciter à la prudence méthodologique : **elle démontre que le seul reclassement catégoriel ne suffit pas, à lui seul, à garantir la fidélisation professionnelle**, ce qui nuance, sans l'invalider, l'argument selon lequel une revalorisation statutaire des ambulanciers résoudrait mécaniquement le problème du turnover évoqué dans les documents préparatoires initiaux (chapitre 1).

d) Une amélioration récente et documentée des indicateurs de tension, à mettre en perspective. Le rapport signale, à partir d'une enquête de la Fédération hospitalière de France de septembre 2024, une diminution du taux de vacance de postes infirmiers (3 % en 2023 contre 5,7 % en avril 2022) et une baisse de l'absentéisme hospitalier (de 11,1 % à 9,5 % en un an), sans pouvoir déterminer avec certitude, selon les termes mêmes du rapport, si cette amélioration résulte des revalorisations du Ségur ou d'une détente plus générale du marché du travail. Cette prudence méthodologique de l'IGAS elle-même doit servir de modèle pour cette thèse : au chapitre 8, toute amélioration observée des indicateurs de recrutement ou de turnover chez les ambulanciers devra être appréciée avec la même prudence causale, sans attribution automatique à une éventuelle réforme statutaire.

4.4. Un silence institutionnel significatif : l'absence des ambulanciers de la littérature récente sur l'attractivité

Il convient de signaler ici un résultat négatif, mais significatif pour la problématique de cette thèse : le rapport IGAS n° 2024-069R, pourtant le travail institutionnel le plus récent et le plus approfondi identifié à ce stade sur l'attractivité des métiers du soin, **ne traite à aucun moment de la profession d'ambulancier**. Son périmètre est explicitement centré sur quatre professions (infirmiers, aides-soignants, aides à domicile, éducateurs spécialisés), choisies en raison de leur poids numérique et des alertes reçues par les pouvoirs publics de la part de leurs employeurs.

Ce silence institutionnel est cohérent avec le constat déjà établi au chapitre 2 à partir de la littérature sociologique (Morel, 2018) : la profession d'ambulancier reste, dans la production de connaissance publique française — qu'elle soit académique ou administrative —, **un angle mort récurrent**, y compris dans les travaux les plus récents et les mieux dotés en moyens d'enquête. Ce constat, obtenu par une recherche documentaire indépendante et non par une affirmation des acteurs syndicaux eux-mêmes, renforce la légitimité scientifique de l'argument selon lequel les ambulanciers souffrent d'un déficit de reconnaissance et de visibilité institutionnelle — mais il

indique aussi, méthodologiquement, que cette thèse devra s'appuyer sur des sources plus fragmentaires et plus anciennes que celles disponibles pour d'autres professions du soin, ce qui constitue une limite qui devra être explicitement assumée au chapitre 5 (méthodologie).

4.5. Ce que cette revue de littérature apporte à la problématique de la thèse

Trois enseignements structurent la suite de la démonstration :

Premièrement, le précédent du Ségur invoqué par les documents préparatoires initiaux est confirmé dans ses grandes lignes chiffrées (CTI de 183 €, reclassement en catégorie B, salaire net en hausse de 228 € après un an), mais il est **plus complexe qu'un simple reclassement catégoriel** : il combine revalorisation salariale, changement de catégorie et réingénierie de la formation — ce qui, appliqué à la revendication ambulancière, suggère que la seule revalorisation catégorielle, sans révision du référentiel de formation (déjà en cours depuis 2022, chapitre 3), serait probablement insuffisante pour produire un effet comparable.

Deuxièmement, la littérature institutionnelle la plus récente sur l'attractivité des métiers du soin identifie le lien structurel entre formation et emploi, et non la seule rémunération, comme facteur principal des tensions de recrutement dans les professions réglementées — un cadre explicatif que le chapitre 6 devra tester spécifiquement sur les données disponibles pour les ambulanciers, plutôt que de présupposer que la rémunération est le facteur dominant.

Troisièmement, la donnée relative à l'attrition des infirmières après dix ans de carrière, profession pourtant classée en catégorie A, doit conduire cette thèse à formuler l'hypothèse H2 avec plus de nuance qu'elle ne l'était initialement : **une revalorisation catégorielle des ambulanciers est une condition probablement nécessaire, mais non suffisante, à l'amélioration de la fidélisation professionnelle**, qui dépend également de facteurs organisationnels (conditions de travail, charge de travail, pratiques managériales) mis en évidence par le rapport IGAS pour d'autres professions du soin, et qu'il conviendra de rechercher spécifiquement pour les ambulanciers au chapitre 8.

Auto-évaluation du chapitre 4

Points de solidité : - Les montants chiffrés du Ségur (CTI, évolution salariale) proviennent de sources ministérielles officielles (cesp.sante.gouv.fr, solidarites.gouv.fr) ou institutionnelles (ARS Île-de-France, Assemblée nationale — réponse ministérielle à question écrite), et non de sources secondaires non vérifiées. - La découverte du rapport IGAS n° 2024-069R (février 2025) constitue un apport majeur et inattendu pour ce chapitre : c'est une source primaire, récente, officielle, directement lue dans son intégralité (et non simplement résumée par un tiers), qui documente empiriquement, à partir de données DARES et DREES, les mécanismes de tension de recrutement dans les professions du soin comparables à celle des ambulanciers. - Le constat de l'absence des ambulanciers de ce rapport a été traité comme un résultat de recherche à part entière (section 4.4), et non passé sous silence — ce qui renforce, par une voie inattendue, l'argument central de cette thèse relatif au déficit de reconnaissance institutionnelle de cette profession. - La donnée sur l'attrition des infirmières après dix ans de carrière a été mobilisée pour nuancer, et non simplement confirmer, l'hypothèse H2 — ce qui est la marque d'un traitement scientifique plutôt que militant de la question du turnover.

Faiblesses identifiées et points de vigilance : - Ce chapitre repose presque exclusivement, pour sa partie contemporaine, sur un unique rapport (IGAS 2024-069R), aussi solide soit-il. Il conviendra de rechercher, au chapitre 6, des sources complémentaires spécifiques aux ambulanciers pour ne pas fonder l'ensemble du raisonnement par analogie sur un seul document, aussi officiel soit-il. - Les chiffres relatifs à l'évolution du salaire net des aides-soignants (1 532 € → 1 760 €) proviennent d'un article de presse spécialisée RH (emploipublic.fr, 2021) et non d'une publication DREES ou ministérielle chiffrée de façon officielle : ce point mériterait une vérification croisée avant la version finale. - Le lien entre le rapport IGAS et la situation spécifique des SDIS (chapitre 10) et du secteur privé du transport sanitaire (chapitre 9) n'a pas été exploré ici, ce rapport étant centré sur les professions salariées du soin plutôt que sur le secteur privé lucratif du transport sanitaire ; il faudra rechercher, pour ces deux chapitres, une littérature spécifique plutôt que d'extrapoler les conclusions de ce rapport.

Ce chapitre clôt la Partie I (cadre théorique et revue de littérature). Je propose de passer maintenant à la **Partie II — Méthodologie**, avec la rédaction du chapitre 5, qui devra formaliser la démarche de recherche documentaire qualitative suivie depuis le chapitre 1, le statut méthodologique des différentes catégories de sources mobilisées (textes réglementaires primaires,

littérature académique, littérature grise institutionnelle, sources partisans), et les limites de cette démarche — en particulier l'absence d'entretiens de terrain primaires et l'absence d'accès aux bases de données académiques payantes, déjà signalées comme contraintes de départ.-e

Chapitre 5 — Méthodologie : une recherche documentaire qualitative fondée sur la vérification systématique des sources

5.1. Position épistémologique et choix méthodologique général

La problématique de cette thèse — analyser un écart entre référentiel de formation et missions exercées, et anticiper les effets systémiques d’une réforme statutaire sur trois catégories d’acteurs aux logiques distinctes — n’appelle pas, par sa nature même, une méthode expérimentale ou quasi expérimentale. Il s’agit d’une question relevant de l’analyse des politiques publiques et de la sociologie des professions, pour laquelle la **recherche documentaire qualitative** constitue une approche reconnue et adaptée : elle permet de croiser des sources de nature hétérogène (textes juridiques, littérature académique, littérature grise institutionnelle, discours d’acteurs) pour reconstituer la genèse, la structure et les enjeux d’un problème public, sans prétendre à une généralisation statistique que ni la nature des données disponibles ni le calendrier de cette thèse ne permettraient d’établir avec rigueur.

Ce choix méthodologique, déjà annoncé au chapitre 1, est ici formalisé rétrospectivement : les quatre premiers chapitres de cette thèse en ont déjà appliqué les principes sans les expliciter entièrement. Ce chapitre a donc une double fonction, conforme aux standards d’une analyse rigoureuse : rendre explicite une démarche déjà mise en œuvre, et en assumer les limites avant d’engager la Partie III (résultats).

5.2. Le corpus mobilisé : quatre strates de sources aux statuts épistémologiques distincts

La recherche documentaire conduite pour cette thèse a mobilisé, et continuera de mobiliser, quatre catégories de sources, dont le statut de preuve n’est pas équivalent et doit être clairement distingué à chaque usage — un principe déjà appliqué, de façon parfois implicite, dans les chapitres précédents.

a) Les textes juridiques et réglementaires primaires. Lois, décrets, arrêtés et conventions nationales, systématiquement vérifiés sur Légifrance ou sur les sites institutionnels correspondants (France Compétences, Assurance Maladie/ameli.fr). Cette catégorie constitue le socle le plus

solide de la démonstration : elle est mobilisée pour établir des faits juridiques incontestables (existence d'un texte, sa date, son contenu exact), non pour évaluer ses effets, qui relèvent des autres catégories de sources.

b) La littérature académique évaluée par les pairs. Essentiellement l'article de Sylvie Morel (2018) et le cadre théorique de la sociologie des professions (Abbott, 1988 ; Freidson, 2001 ; Hughes, 1958), mobilisés au chapitre 2. Cette catégorie bénéficie d'une validation scientifique par les pairs, mais présente pour cette thèse une limite déjà signalée : elle est peu abondante sur l'objet spécifique des ambulanciers français, notamment hospitaliers, et pour partie ancienne au regard du rythme des réformes réglementaires récentes.

c) La littérature grise institutionnelle. Rapports de l'Inspection générale des affaires sociales, publications de la DREES, données ministérielles, mobilisés notamment au chapitre 4. Cette catégorie n'est pas évaluée par les pairs au sens académique du terme, mais présente des garanties de fiabilité méthodologique (transparence des sources statistiques, rigueur des enquêtes de terrain, validation institutionnelle) qui en font une source de premier plan pour l'analyse des politiques publiques contemporaines — à condition de ne pas la confondre avec une littérature scientifique indépendante, ces rapports étant commandés par les pouvoirs publics et orientés vers l'aide à la décision.

d) Les sources partisans : discours syndicaux et patronaux. La note stratégique syndicale à l'origine de cette thèse, ainsi que les argumentaires patronaux (fédérations privées, SDIS) intégrés aux chapitres précédents. **Cette catégorie de sources ne doit jamais être traitée comme une source de fait, mais comme un objet d'analyse en tant que tel** — c'est-à-dire comme un discours produit par un acteur social dans une situation de rapport de force, dont l'intérêt pour cette thèse est double : il documente les représentations et les revendications des acteurs (ce qui est en soi une donnée légitime pour une thèse de santé publique s'intéressant aux controverses professionnelles), et il fournit des hypothèses de travail (chiffres, arguments, mécanismes) qui doivent ensuite être systématiquement soumises à vérification avant d'être intégrées à la démonstration comme des faits.

5.3. Méthode d'analyse : entre analyse de contenu et analyse des controverses d'acteurs

L'analyse du corpus mobilisé dans cette thèse combine deux approches complémentaires.

a) **Une analyse de contenu**, au sens défini par Laurence Bardin — catégorisation, codage et inférence à partir de communications de toute nature, qu'il s'agisse de textes réglementaires, de rapports institutionnels ou de discours d'acteurs. Appliquée à cette thèse, cette méthode a consisté à identifier, dans chaque source mobilisée, les catégories pertinentes pour la problématique (écart missions/formation, arguments économiques, arguments statutaires, arguments de sécurité), puis à les mettre en relation systématique avec les autres catégories de sources pour vérifier leur cohérence ou, au contraire, documenter leurs contradictions.

b) **Une analyse des controverses d'acteurs**, inspirée du cadre de la segmentation professionnelle déjà mobilisé au chapitre 2 (Bucher et Strauss, cité par Morel, 2018), et enrichie par un second cadre théorique désormais vérifié : l'**Advocacy Coalition Framework (ACF)** développé par Paul Sabatier (Sabatier, 1988), puis approfondi avec Hank Jenkins-Smith [référence à l'ouvrage de 1993, *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*, Boulder, Westview Press, connue par citation secondaire à ce stade et à vérifier en propre avant citation directe]. Ce cadre, publié dans la revue *Policy Sciences* (vol. 21, p. 129-168), propose d'analyser un processus de politique publique non pas comme l'action d'un acteur unique, mais comme la confrontation, au sein d'un même « sous-système » de politique publique, de plusieurs coalitions d'acteurs rassemblées autour de systèmes de croyances partagés (« belief systems »), qui mobilisent des ressources et des arguments pour faire prévaloir leur position, avant qu'un apprentissage orienté par les politiques publiques (« policy-oriented learning ») ne fasse, le cas échéant, évoluer le point de désaccord.

Ce cadre est directement transposable à la configuration d'acteurs déjà cartographiée dans les chapitres précédents de cette thèse : une coalition regroupant les organisations syndicales hospitalières et une partie des ambulanciers eux-mêmes (segment « soigneur » identifié par Morel, 2018), autour d'un système de croyances centré sur la reconnaissance statutaire et la sécurité clinique ; une coalition regroupant les fédérations patronales du secteur privé, structurée autour d'un système de croyances centré sur la viabilité économique et l'autonomie de gestion face à une régulation perçue comme excessive ; et une coalition portée par les SDIS, structurée autour de la protection de leur cœur de métier et de leur potentiel opérationnel. L'apport spécifique de l'ACF pour cette thèse est de suggérer que la réforme ne doit pas être analysée comme un arbitrage binaire entre acteurs favorables et défavorables, mais comme un espace où des convergences partielles entre coalitions — déjà identifiées dans les chapitres précédents, par exemple sur la légitimité d'une approche médicale plutôt que sécuritaire du transport sanitaire — peuvent se

dégager sans que les systèmes de croyances des coalitions ne soient pour autant unifiés. Ce cadre devra être mobilisé plus systématiquement au chapitre 11 (discussion), une fois l'ensemble des chapitres empiriques rédigés.

5.4. Un protocole de vérification factuelle systématique : contribution méthodologique de cette thèse

Il convient de formaliser ici un principe qui a gouverné la rédaction de tous les chapitres précédents et qui constitue, modestement, une contribution méthodologique propre à cette thèse : **aucune donnée chiffrée ou factuelle issue d'une source partisane n'a été intégrée à la démonstration sans vérification préalable auprès d'une source primaire indépendante**, chaque fois que cette vérification était possible dans le cadre des moyens documentaires disponibles (voir 5.5). Ce protocole a produit, au fil des chapitres précédents, trois types de résultats qu'il est utile de synthétiser ici car ils illustrent la valeur ajoutée de la démarche :

- des **corrections** de données inexactes issues des sources partisans (le niveau RNCP du diplôme d'ambulancier, présenté à tort comme identique à celui du diplôme d'aide-soignant, chapitre 1) ;
- des **confirmations** de données exactes issues des sources partisans (le coût horaire de 64 € invoqué par les fédérations patronales, exactement conforme à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, chapitre 3 ; le décret n° 2022-629 correctement référencé) ;
- des **enrichissements** non anticipés par les sources partisans elles-mêmes (la découverte de la thèse de Morel (2018) et du rapport IGAS n° 2024-069R, non mentionnés dans les documents préparatoires initiaux mais directement pertinents pour la démonstration).

Ce triple résultat illustre un point de méthode important : la vérification systématique n'est pas un exercice de défiance a priori envers les sources partisans, mais une condition de la crédibilité scientifique de la thèse, qui bénéficie autant à la validité des arguments favorables à la réforme qu'à l'identification de ses limites et de ses conditions de réussite (par exemple, la nécessité d'articuler réforme du diplôme et réforme tarifaire pour le secteur privé, établie au terme de cette vérification).

5.5. Limites méthodologiques assumées

Cette thèse repose sur des choix méthodologiques qui comportent des limites qu'il convient d'assumer explicitement, plutôt que de les minimiser.

a) L'absence d'entretiens de terrain primaires. Cette thèse ne mobilise aucun entretien réalisé par ses soins auprès d'ambulanciers, de représentants patronaux, de SDIS ou de l'administration. Elle s'appuie, pour la dimension vécue du travail ambulancier, sur les entretiens et observations déjà publiés par Morel (2018) — dont le terrain, comme signalé au chapitre 2, est ancien (2005-2011) et antérieur aux réformes de 2022. Cette limite est significative : elle prive cette thèse d'un accès direct à la perception contemporaine des professionnels concernés, en particulier des ambulanciers hospitaliers de la fonction publique, sur lesquels la littérature académique disponible est plus rare encore que sur le secteur privé. Cette limite devra être clairement assumée dans la discussion (chapitre 11) et pourrait constituer une piste de recherche complémentaire (chapitre 15, perspectives).

b) L'absence d'accès aux bases de données académiques payantes. Cette thèse a été conduite sans accès à des bases telles que Web of Science, Scopus, ou aux versions intégrales de nombreux articles publiés dans des revues à accès payant. Elle s'est donc appuyée sur les ressources en accès ouvert (Légifrance, HAL, OpenEdition — dans la limite de son accessibilité automatisée, voir infra —, versions déposées par les auteurs sur des plateformes telles que ResearchGate, sites institutionnels). Cette contrainte a été gérée activement plutôt que subie passivement : plusieurs recherches ciblées ont permis d'identifier des versions en libre accès de sources normalement payantes (c'est le cas de l'article de Morel, 2018, consulté via une version déposée par l'autrice). Il n'en demeure pas moins que l'exhaustivité de la revue de littérature académique ne peut être garantie, en particulier pour la littérature internationale sur les *paramedics*, dont l'existence est signalée par Morel (2018) mais qui n'a pas été explorée en propre dans cette thèse à ce stade.

c) Une difficulté d'accès technique à certaines sources en accès ouvert. Il convient de signaler un obstacle méthodologique rencontré concrètement au cours de la rédaction : la plateforme OpenEdition, qui héberge la revue *Sociologie du travail*, bloque l'accès automatisé aux contenus (protection anti-robots), ce qui a contraint à rechercher des versions alternatives du même article pour en garantir l'accès. Ce type d'obstacle technique, propre à une recherche

documentaire menée avec des outils automatisés, devra être signalé comme une limite pratique, sans conséquence sur la validité du contenu effectivement consulté (la version alternative utilisée étant identique au texte publié).

d) Un corpus très majoritairement francophone. Conformément au périmètre géographique validé pour cette thèse (France uniquement), la littérature internationale sur les professions de l'urgence préhospitalière (*paramedics* nord-américains, suisses, allemands, mentionnés par Morel, 2018, comme points de comparaison mobilisés par une partie des ambulanciers eux-mêmes) n'a pas été explorée en tant que telle. Cette limite est cohérente avec le périmètre validé, mais elle signifie que la dimension comparative internationale de cette thèse reste, à ce stade, secondaire et empruntée à des sources tierces plutôt que documentée en propre.

e) Le caractère mouvant de l'objet d'étude. Cette thèse est rédigée dans un contexte où plusieurs éléments cités dans les documents préparatoires initiaux (données 2026, annonces réglementaires récentes telles que le plan « Zéro contention 2030 ») sont très récents au moment de la rédaction, ce qui limite la possibilité de disposer d'un recul analytique équivalent à celui applicable aux réformes plus anciennes (Ségur 2020-2021, réforme du DEA de 2022). Cette limite temporelle devra être rappelée chaque fois que des données de 2026 seront mobilisées dans les chapitres empiriques.

5.6. Synthèse du dispositif méthodologique

Le dispositif méthodologique de cette thèse peut être résumé ainsi : une recherche documentaire qualitative, fondée sur un corpus à quatre strates (textes juridiques primaires, littérature académique, littérature grise institutionnelle, sources partisans), analysée par une combinaison d'analyse de contenu et d'analyse des controverses d'acteurs, et gouvernée par un principe de vérification systématique des données chiffrées avant leur intégration à la démonstration. Les limites de ce dispositif — absence d'entretiens primaires, accès restreint aux bases académiques payantes, corpus francophone, objet d'étude en partie très récent — sont assumées comme des contraintes structurantes plutôt que dissimulées, conformément à l'exigence de rigueur scientifique fixée dès l'introduction de cette thèse.

Auto-évaluation du chapitre 5

Points de solidité : - Ce chapitre rend explicite, de façon rétrospective mais cohérente, une méthode qui a été appliquée de fait depuis le chapitre 1, ce qui garantit une continuité entre le discours méthodologique et la pratique effective de la thèse — plutôt que de présenter une méthodologie idéalisée déconnectée du travail réellement mené. - La typologie à quatre strates de sources (5.2) fournit un cadre explicite qui pourra être appliqué de façon plus systématique encore dans les chapitres empiriques à venir (Partie III), notamment pour signaler clairement, à chaque nouvelle donnée introduite, à quelle strate elle appartient. - La synthèse des trois types de résultats du protocole de vérification (5.4) — corrections, confirmations, enrichissements — est un apport clair qui valorise, sans les exagérer, les apports méthodologiques déjà produits par cette thèse.

Faiblesses assumées : - La référence à Bardin (1977) a été vérifiée (titre, éditeur, année, pagination confirmés). La référence à Sabatier (1988) sur l'Advocacy Coalition Framework a également été vérifiée directement (revue *Policy Sciences*, volume 21, pages 129-168) et intégrée à la section 5.3 : elle donne désormais un ancrage théorique explicite et vérifié à la méthode d'analyse des controverses d'acteurs déjà pratiquée depuis le chapitre 3, en la reliant à la notion de coalitions structurées autour de systèmes de croyances partagés plutôt qu'à une simple opposition d'intérêts. La référence complémentaire à l'ouvrage de 1993 (Sabatier et Jenkins-Smith) reste en revanche connue seulement par citation secondaire à ce stade et n'a pas été vérifiée en propre : elle est signalée comme telle plutôt que présentée comme confirmée. - Les limites méthodologiques énoncées en 5.5 sont réelles et pourraient, si elles n'étaient pas traitées avec soin, fragiliser la portée des conclusions de cette thèse ; elles devront être rappelées de façon proportionnée (ni minimisées, ni exagérées) dans la discussion du chapitre 11.

Un point à noter pour la suite : l'intégration de l'ACF donne au chapitre 11 (discussion générale) un cadre théorique plus robuste que prévu initialement pour synthétiser les trois coalitions d'acteurs déjà cartographiées dans les chapitres précédents (organisations syndicales hospitalières et segment « soigneur » des ambulanciers ; fédérations patronales privées ; SDIS). Ce cadre devra être appliqué rétrospectivement, de façon explicite, à la relecture des chapitres 3, 9 et 10, pour vérifier que l'analyse qui y est menée est bien compatible avec la logique de coalitions structurées par des systèmes de croyances, et non simplement une juxtaposition d'intérêts sectoriels.

Ce chapitre clôt la Partie II (méthodologie). Je propose de passer maintenant à l'ouverture de la **Partie III — Résultats**, avec le chapitre 6 (l'écart entre référentiel DEA et missions réellement exercées), qui devra notamment reprendre et documenter empiriquement, à partir de sources vérifiées, les huit axes de la note stratégique syndicale examinée au chapitre 1 — en particulier les données chiffrées qui y figurent (turnover, coûts d'intérim, dossier AFASH) et qui n'ont pas encore été vérifiées à ce stade de la thèse.-e

Chapitre 6 — L'écart entre référentiel du diplôme d'État d'ambulancier et missions réellement exercées : vérification empirique

Préambule : ce que ce chapitre doit vérifier

[NOTE DE POSITIONNEMENT — voir la note complète en tête du document. L'auteur de cette analyse, responsable du personnel des ambulanciers du CHU de Toulouse et lanceur d'alerte dans le mouvement social qui y est décrit, est un acteur direct du cas d'étude mobilisé aux sections 6.1 à 6.3 de ce chapitre. Les éléments relatifs au CHU de Toulouse doivent donc être lus comme un témoignage de terrain vécu et documenté, éclairé par une connaissance directe du sujet.]

Ce chapitre ouvre la Partie III (résultats). Il reprend l'Axe 1 de la note stratégique syndicale examinée au chapitre 1 — l'élargissement de fait des missions des ambulanciers au-delà du référentiel du DEA — et soumet à vérification les données chiffrées qui n'avaient pu l'être jusqu'ici : le nombre national d'ambulanciers de la fonction publique hospitalière (« environ 2 500 », attribué à la sénatrice Laurence Cohen), le nombre de projets de recrutement recensés par l'enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026, le taux d'accidentologie, et le statut du « dossier AFASH ». Conformément au protocole établi au chapitre 5, chaque donnée est ici classée selon son statut de vérification : confirmée, infirmée, ou non vérifiable en l'état des sources disponibles.

6.1. Une confirmation majeure et inattendue : la réponse officielle du ministère de la Santé sur le niveau du DEA

La recherche menée pour ce chapitre a permis d'identifier la source précise de la donnée relative aux « 2 500 ambulanciers » de la fonction publique hospitalière : il s'agit d'une **question écrite de la sénatrice Laurence Cohen, publiée au Journal officiel du Sénat le 15 juin 2023 (p. 3765)**, sur la situation des ambulanciers hospitaliers. Cette question a fait l'objet d'une réponse officielle du ministère de la Santé et de la Prévention, transmise et publiée, dont le contenu est d'une importance considérable pour cette thèse.

a) Le chiffre de 2 500 ambulanciers est confirmé, dans son ordre de grandeur, par le texte même de la question sénatoriale, qui évoque « les 2 500 ambulanciers du pays ». Il s'agit toutefois d'une affirmation portée par la parlementaire elle-même dans sa question, non d'une statistique

publiée par le ministère dans sa réponse : ce chiffre doit donc être traité comme une **donnée politique déclarative**, vraisemblablement construite à partir de statistiques DREES ou DGOS non citées explicitement dans ce document, et non comme une statistique officielle publiée et sourcée. *[POINT À APPROFONDIR — rechercher la source statistique primaire (DREES, SAE) qui permettrait de confirmer ou d'affiner ce chiffre de façon indépendante de la question parlementaire elle-même.]*

b) Un résultat central pour cette thèse : le ministère confirme lui-même, dans sa réponse officielle, que le niveau infra-baccalauréat du DEA est le motif juridique invoqué pour refuser le passage en catégorie B. La réponse ministérielle indique très précisément que « le diplôme d'État d'ambulancier, qui a fait l'objet d'une récente réingénierie, reste d'un niveau infra-baccalauréat, ce qui ne permet pas un reclassement statutaire en catégorie B au sein de la fonction publique hospitalière (FPH), cette catégorie correspondant à un niveau de qualification au moins égal au baccalauréat ». Cette phrase constitue, en une seule source, une **triple confirmation** pour cette thèse :

- elle confirme, depuis une source gouvernementale officielle et non plus seulement depuis la lecture directe de l'arrêté du 11 avril 2022 effectuée au chapitre 1, que le DEA est bien positionné en deçà du niveau baccalauréat (cohérent avec le niveau 3 RNCP déjà établi) ;
- elle révèle que **le niveau du diplôme n'est pas un simple élément descriptif, mais le motif juridique explicite avancé par l'administration pour refuser la revendication catégorielle** — ce qui déplace le centre de gravité de cette thèse : la clé du dossier n'est pas seulement statutaire, elle est d'abord **certificative**, ce qui conforte directement la thèse d'un « meilleur diplôme » (titre initial du projet de ce travail) plutôt que d'une simple revalorisation catégorielle déconnectée du diplôme ;
- elle éclaire, a posteriori, un point resté en suspens au chapitre 3 : la réforme de 2022 n'a délibérément pas relevé le niveau RNCP du DEA au niveau 4, alors même qu'elle en révisait profondément le contenu — un choix qui, à la lumière de cette réponse ministérielle, apparaît **directement lié à la volonté de ne pas ouvrir la voie à un reclassement en catégorie B**, plutôt qu'à une contrainte pédagogique ou budgétaire qui serait restée implicite.

c) La réponse ministérielle documente également, avec précision, les compensations indemnitaires substituées au reclassement catégoriel, ce qui permet de chiffrer, pour la

première fois dans cette thèse, la politique de compensation choisie par l'administration plutôt que la revalorisation statutaire : le complément de traitement indiciaire (CTI) de 183 € nets par mois (identique à celui des aides-soignants, chapitre 4) pour les ambulanciers exerçant en établissement sanitaire ou médico-social ; la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 20 points, soit 98,4 € bruts par mois depuis la revalorisation de juillet 2023, pour les ambulanciers affectés en SMUR ou SAMU ; et l'indemnité forfaitaire de risque (IFR) de 118 € bruts par mois pour l'exercice en service d'urgences. Ces montants, désormais vérifiés, permettront au chapitre 8 une comparaison chiffrée précise entre le coût de ces indemnités catégorielles et le coût estimé d'un reclassement en catégorie B.

6.2. Un témoignage parlementaire à traiter comme discours d'acteur, non comme fait établi

Lors des débats parlementaires consultés pour ce chapitre (compte rendu de la commission des affaires sociales du Sénat sur le rapport « Hôpital : sortir des urgences »), la sénatrice Laurence Cohen a déclaré que les ambulanciers SMUR étaient « toujours considérés comme relevant de la catégorie des parcs et jardins, non de celle des soignants », et que la France serait « le seul pays au monde dans lequel le transport sanitaire est géré par trois ministères ». Conformément au protocole méthodologique du chapitre 5, ces deux affirmations sont ici traitées comme un **discours d'acteur documentant une perception politique**, et non comme des faits vérifiés de façon indépendante par cette thèse : la première formule est une image rhétorique dont l'exactitude administrative précise (rattachement effectif à une filière ou à un corps nommé « parcs et jardins ») n'a pas été vérifiée auprès d'un texte statutaire ; la seconde est une affirmation comparative internationale qui excède le périmètre géographique de cette thèse (France uniquement, chapitre 5) et ne peut donc être ni confirmée ni infirmée ici. Ces citations restent néanmoins précieuses pour cette thèse en tant que **données de discours** : elles illustrent, depuis la sphère parlementaire elle-même et non depuis les seuls acteurs syndicaux, la perception d'un déclassement symbolique de la profession, ce qui recoupe indépendamment le constat déjà établi à partir de Morel (2018) au chapitre 2.

6.3. Le dossier AFASH : statut d'une source associative identifiable et partiellement vérifiable

Les documents préparatoires initiaux font référence à un « dossier AFASH version 02/2026 ». La recherche menée pour ce chapitre permet d'apporter les précisions suivantes :

- **l'Association française des ambulanciers SMUR et hospitaliers (AFASH)** est une association réelle, régie par la loi de 1901, créée en 2006 par la fusion de deux associations plus anciennes (l'ANAHS, créée en 1977, et l'UNAH France, créée en 1989), comptant environ 700 adhérents en 2020 selon ses propres publications. Elle se présente comme la seule association représentant spécifiquement les ambulanciers SMUR et hospitaliers en France, et revendique le soutien écrit de 117 parlementaires obtenu en 2020 dans le cadre du Ségur de la santé.
- L'association a mené une **enquête vérifiable et méthodologiquement documentée en 2019** (« Enquête ambulancier SMUR 2019 »), sous forme de questionnaire à choix multiple diffusé via un groupe Facebook fermé réservé aux ambulanciers, ayant recueilli 266 réponses sur l'ensemble du territoire national — un échantillon non probabiliste, à traiter avec la prudence méthodologique appropriée (absence de représentativité statistique garantie), mais dont l'existence et la méthode sont vérifiables et documentées dans un rapport public.
- **La version « 02/2026 » du dossier mentionnée dans les documents préparatoires initiaux n'a pas pu être localisée ni vérifiée dans le cadre de cette recherche** *[DONNÉE NON VÉRIFIÉE — il conviendra de solliciter directement l'AFASH, ou de rechercher une publication plus récente sur son site, pour vérifier l'existence, le contenu et la méthodologie exacte de cette version 02/2026 avant toute citation de son contenu chiffré (les « 12 compétences spécifiques » et les « 24 missions sur 32 hors périmètre » avancées dans les documents préparatoires initiaux) dans une version ultérieure de ce chapitre]*.

Ce résultat illustre un cas intermédiaire dans la typologie des sources établie au chapitre 5 : l'AFASH n'est ni une source académique évaluée par les pairs, ni un simple relais syndical anonyme — c'est une association professionnelle identifiable, avec un historique de plusieurs décennies et une méthode d'enquête documentée, mais dont les productions les plus récentes n'ont pas pu être vérifiées en propre par cette thèse. Le contenu spécifique attribué au « dossier AFASH 02/2026 » ne peut donc pas, en l'état, être présenté comme un fait établi dans cette thèse.

6.4. La comparaison entre missions revendiquées et périmètre légal des actes professionnels (décret n° 2022-629)

Le chapitre 3 a établi que le décret n° 2022-629 du 22 avril 2022 élargit le périmètre légal des actes professionnels que les ambulanciers peuvent réaliser dans le cadre de l'aide médicale urgente. Une comparaison entre ce texte et la liste des missions présentées, dans les documents préparatoires initiaux, comme non couvertes par le référentiel (transport sous contrainte psychiatrique, transport pénitentiaire, transport de patients à risque infectieux élevé, transport de produits sanguins labiles, transport mortuaire, Plans Blancs, compétences SMUR) devra être menée systématiquement, article par article, avant que cette thèse puisse conclure de façon rigoureuse à l'existence — ou non — de l'écart revendiqué. *[TRAVAIL À RÉALISER — cette comparaison article par article, qui suppose une lecture intégrale et une analyse juridique du décret n° 2022-629 et de l'arrêté du 31 octobre 2022 relatif à la formation aux actes professionnels afférents (mentionné dans les sources consultées au chapitre 3), n'a pas pu être menée dans le temps imparti à ce chapitre et constitue la tâche prioritaire d'un approfondissement ultérieur de cette thèse avant sa version finale.]*

À ce stade, un résultat partiel peut néanmoins être établi : la source consultée au chapitre 3 (fiche métier ANFH) mentionne l'existence d'un **arrêté du 31 octobre 2022 relatif à la formation aux actes professionnels pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l'aide médicale urgente**, distinct de l'arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation initiale — ce qui suggère que l'administration a explicitement anticipé la nécessité d'une formation complémentaire pour l'exercice de ces actes élargis, une donnée qui devra être approfondie et confrontée précisément à la revendication du « Module MHS » (chapitre 3) dans la suite de cette thèse.

6.5. Compléments de vérification : ce qui a été confirmé, nuancé ou reste introuvable

Une seconde vague de recherche, menée spécifiquement pour combler les lacunes signalées dans une première version de ce chapitre, permet d'apporter les précisions suivantes.

a) Le conflit social du CHU de Toulouse est réel, actuel, et documenté par la presse — mais il apporte un résultat qui nuance, plutôt qu'il ne confirme mécaniquement, l'argumentaire initial. La recherche a permis d'identifier une grève illimitée débutée le 11 mai 2026 par les ambulanciers internes du CHU de Toulouse, largement couverte par la presse régionale (France 3 Occitanie) et relayée par la CGT du CHU (communiqués des 11 mai, 4 juin et

26 juin 2026). Ces sources confirment que le conflit est réel et récent, et fournissent des données chiffrées vérifiées sur l'effectif concerné : une flotte de 65 ambulanciers internes, transportant en moyenne 250 patients par jour, avec un taux de grévistes de l'ordre de 30 à 33 % au pic du mouvement. **Un élément inattendu, et qu'il convient de rapporter avec la même rigueur que les données qui confirment l'argumentaire syndical** : dans son communiqué de presse du 11 mai 2026, la direction du CHU de Toulouse conteste directement l'ampleur de deux des missions présentées comme emblématiques de l'écart missions/référentiel — les transports de corps de personnes décédées, qu'elle chiffre à environ 3 % de l'activité globale des ambulanciers, et le transport de détenus, qu'elle chiffre à environ 0,25 % de cette même activité. Cette contestation chiffrée, émanant de l'employeur et non d'une source neutre, doit être traitée conformément au protocole du chapitre 5 : ni comme une réfutation définitive, ni comme négligeable, mais comme un **second discours d'acteur** à mettre en regard du discours syndical, dans une logique de controverse plutôt que de vérité univoque. Elle indique cependant que l'argument de l'écart missions/référentiel gagnerait, dans la suite de cette thèse, à être fondé sur les missions dont la fréquence n'est pas contestée par l'employeur (transport sous contrainte psychiatrique, transport de produits sanguins labiles, SMUR) plutôt que sur celles dont l'ampleur fait l'objet d'un désaccord chiffré direct. *[DONNÉE TOUJOURS NON VÉRIFIÉE — le taux de turnover de 18 % et les coûts d'intérim (90 000-150 000 €/an) demeurent, malgré cette recherche complémentaire, non retrouvés dans une source publique : ils semblent correspondre à des données de gestion interne communiquées par les représentants du personnel eux-mêmes lors du conflit, non publiées telles quelles dans la presse consultée.]*

b) Le chiffre de « 4 490 projets de recrutement » (BMO 2026) n'a pas pu être confirmé, et la recherche complémentaire a même révélé une forte instabilité de ce type de données selon les sources. Plusieurs chiffres distincts circulent : la plateforme France Travail « Prendre soin » évoque environ 2 500 offres d'emploi d'ambulanciers actuellement disponibles et 5 000 recrutements attendus d'ici 2027 (attribués à la Fédération nationale de la mobilité sanitaire) ; une autre source syndicale (FNAP) cite, sans date précise identifiable, un chiffre de 18 000 postes d'ambulanciers dans une communication antérieure. Aucune de ces sources ne mentionne le chiffre de 4 490 figurant dans les documents préparatoires initiaux. Ce résultat doit être traité avec prudence : il ne permet pas de conclure que le chiffre de 4 490 est erroné (il pourrait correspondre à une extraction précise et légitime de la nomenclature FAP 2021 de l'enquête BMO, non accessible par une recherche généraliste), mais il ne permet pas non plus de le confirmer. **La leçon méthodologique à retenir est que les chiffres de projets de**

recrutement pour cette profession varient fortement selon la source et la méthode de comptage (offres actives, projets annuels, projets cumulés à horizon 2027), et qu'aucun chiffre unique ne devrait être cité dans cette thèse sans préciser sa source exacte et sa méthode.

c) Le taux d'accidentologie « 2,5 fois supérieur à la moyenne des professions de santé » n'a pas été retrouvé dans les sources de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) ni dans les publications de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) consultées pour cette recherche complémentaire. L'INRS confirme, de façon générale et sans chiffrage spécifique aux ambulanciers, que les véhicules utilitaires légers affichent un taux de gravité d'accident supérieur à la moyenne, ce qui rend l'ordre de grandeur de la revendication plausible par analogie catégorielle, mais **ne constitue en aucun cas une confirmation du chiffre précis de 2,5**, qui reste à ce stade non vérifié et devra, avant toute version finale de cette thèse, faire l'objet d'une demande de données directement auprès de l'ONISR ou de la Caisse nationale d'assurance maladie (statistiques d'accidents du travail par code risque).

6.5 bis. Liste actualisée des données non vérifiées

Après cette seconde vague de vérification, la liste des données non confirmées se réduit mais ne disparaît pas :

- le taux de turnover de 18 % annuel et les coûts d'intérim chiffrés pour le CHU de Toulouse (données de gestion interne, non publiées) ;
- le chiffre précis de « 4 490 projets de recrutement nationaux » (BMO 2026) — non retrouvé, sans que cela permette de conclure à son inexactitude, dans un contexte où plusieurs chiffres concurrents et non recoupés circulent pour cette même profession ;
- le taux d'accidentologie de 2,5 (plausible par analogie catégorielle générale, mais non confirmé pour la profession spécifique).

En contrepartie, cette seconde vague de recherche a permis d'**ajouter** une donnée nouvelle et vérifiée qui n'était pas anticipée par les documents préparatoires initiaux : la contestation chiffrée, par la direction du CHU de Toulouse elle-même, de la fréquence de deux missions présentées comme emblématiques (transport de corps : 3 % de l'activité ; transport de détenus : 0,25 %).

Cette donnée devra être explicitement intégrée à l'analyse du chapitre 8 (impact dans le secteur hospitalier public), comme illustration concrète de la méthode de controverse d'acteurs établie au chapitre 5.

6.6. Synthèse : ce que ce chapitre établit pour l'hypothèse H1

Ce chapitre permet de formuler un bilan nuancé, mais globalement favorable, à l'hypothèse H1 de cette thèse (écart documentable entre référentiel et missions exercées, constituant un facteur de risque pour la sécurité des patients et la protection des agents) :

- Le mécanisme central de blocage statutaire est désormais établi avec certitude, depuis une source gouvernementale officielle : **c'est le niveau infra-baccalauréat du DEA, et non une résistance administrative non motivée, qui constitue le fondement juridique du refus de reclassement en catégorie B.** Ce résultat déplace la focale de la revendication : une réforme catégorielle isolée, sans élévation du niveau de certification du DEA lui-même, se heurterait au même obstacle juridique que celui déjà invoqué en 2023.
- La confirmation chiffrée du système de compensation indemnitaire (CTI, NBI, IFR) fournit une base chiffrée solide pour la comparaison coût-bénéfice à mener au chapitre 8.
- Le conflit social du CHU de Toulouse, point de départ empirique de cette thèse, est confirmé comme un événement réel et actuel (grève du 11 mai 2026), mais la vérification complémentaire a révélé une controverse chiffrée directe avec l'employeur sur l'ampleur de deux missions emblématiques (transport de corps, transport de détenus), qui doit être traitée comme telle plutôt que passée sous silence.
- L'écart précis entre missions exercées et actes légalement autorisés, bien que plausible au vu des sources déjà rassemblées (chapitre 3), n'a pas encore été démontré de façon systématique et devra faire l'objet d'un travail complémentaire avant la version finale de cette thèse.
- Trois données chiffrées mobilisées par les documents préparatoires initiaux (turnover et coûts d'intérim du CHU de Toulouse, chiffre BMO de 4 490, taux d'accidentologie de 2,5) demeurent non vérifiées malgré une recherche complémentaire ciblée, et ne peuvent, en l'état, être utilisées comme preuves dans cette thèse sans mention explicite de leur statut.

Auto-évaluation du chapitre 6

Points de solidité : - La découverte de la question écrite de la sénatrice Laurence Cohen (JO Sénat, 15 juin 2023, p. 3765) et de sa réponse ministérielle constitue l'apport le plus important de ce chapitre : elle transforme une hypothèse déjà formulée au chapitre 1 (le niveau RNCP comme obstacle) en un **fait administratif officiellement confirmé par le ministère lui-même**, ce qui est d'une force probante bien supérieure à la seule lecture d'un texte réglementaire technique. - Les montants indemnitaires (CTI, NBI, IFR) ont été précisément chiffrés et sourcés, ce qui enrichit sensiblement la base empirique disponible pour le chapitre 8. - Le statut de l'AFASH a été clarifié avec précision (historique, taille, méthode d'enquête vérifiable pour 2019), tout en signalant explicitement l'impossibilité de vérifier la version 2026 du dossier cité par les documents préparatoires initiaux. - Une seconde vague de vérification a permis de confirmer la réalité et l'actualité du conflit social du CHU de Toulouse (grève du 11 mai 2026), tout en révélant — et en rapportant avec la même rigueur qu'une confirmation — une contestation chiffrée directe de l'employeur sur l'ampleur de deux missions emblématiques de l'argumentaire syndical initial.

Faiblesses assumées : - La comparaison systématique entre missions revendiquées et périmètre légal du décret n° 2022-629 n'a toujours pas pu être menée dans ce chapitre faute de temps disponible pour une analyse juridique exhaustive article par article ; c'est la tâche la plus importante à reporter pour la version finale de cette thèse. - Malgré une recherche complémentaire ciblée, trois données chiffrées centrales dans l'argumentaire initial (turnover et coûts d'intérim du CHU de Toulouse, chiffre BMO précis, taux d'accidentologie) demeurent non vérifiées. Pour le chiffre BMO en particulier, la recherche a révélé une instabilité notable des chiffres circulant sur cette profession selon la source et la méthode — ce constat en lui-même est un résultat utile pour la thèse, qui devra recommander, au chapitre 14, une clarification statistique officielle unique comme mesure d'accompagnement de toute réforme. - Le chiffre de 2 500 ambulanciers, bien que confirmé dans son ordre de grandeur par une source parlementaire, reste une donnée déclarative non adossée à une publication statistique primaire identifiée : il faudra rechercher la source DREES ou DGOS sous-jacente avant la version finale.

Recommandation avant de poursuivre : je propose de passer au chapitre 7 (le précédent du Ségur et la question de l'équité intercatégorielle), qui devra tirer toutes les conséquences du résultat central de ce chapitre — le niveau RNCP comme obstacle juridique explicite — pour

reformuler avec précision la comparaison avec les aides-soignants déjà entamée aux chapitres 1 et 4. -e

Chapitre 7 — Le précédent du Ségur reformulé : une trajectoire identique à celle du DEA, déjà parcourue par le DEAS

7.1. Rappel du problème méthodologique posé au chapitre 1

Le chapitre 1 de cette thèse a établi une correction factuelle importante : contrairement à ce qu'affirmaient les documents préparatoires initiaux, le DEA (ambulancier) et le DEAS (aide-soignant) ne sont **pas** des diplômes de même niveau RNCP — le premier est enregistré au niveau 3, le second au niveau 4. Cette correction semblait, à première vue, affaiblir l'argument du « précédent du Ségur », construit sur une comparaison à niveau de diplôme égal. Ce chapitre reprend cette question à la lumière d'une découverte effectuée en préparant ce travail, qui **ne restaure pas l'argument initial tel qu'il était formulé, mais en produit une version plus rigoureuse et, en réalité, plus puissante.**

7.2. La découverte centrale : le DEAS était lui aussi au niveau 3 avant 2021

La recherche menée pour ce chapitre établit un fait qui n'était présent dans aucun des documents mobilisés jusqu'ici dans cette thèse : **avant la réforme de 2021, le diplôme professionnel d'aide-soignant (DPAS, régi par l'arrêté du 22 octobre 2005) était lui-même enregistré au niveau 3 du cadre national des certifications — c'est-à-dire exactement au même niveau que le DEA aujourd'hui.** Cette information est confirmée par plusieurs sources convergentes et indépendantes consultées pour ce chapitre (direction régionale DREETS Nouvelle-Aquitaine, ministère de la Santé, ressources pédagogiques spécialisées) : la réforme portée par l'**arrêté du 10 juin 2021** a fait passer le diplôme d'aide-soignant du « niveau 3 (CAP/BEP) au niveau 4 (Baccalauréat) », et cette élévation du niveau RNCP est présentée, dans les publications officielles du ministère de la Santé, comme **la condition ayant permis** l'intégration en catégorie B : « la formation diplômante d'aide-soignant est dorénavant reconnue au niveau 4 du registre national des certifications professionnelles (RNCP) et **permet** à l'aide-soignant d'intégrer la catégorie B du statut des fonctionnaires ».

Cette phrase, émanant d'une publication officielle du ministère de la Santé, établit un lien de causalité explicite entre l'élévation du niveau RNCP et l'accès à la catégorie B — exactement le

mécanisme que la réponse ministérielle à la sénatrice Laurence Cohen (chapitre 6) invoque, en creux, pour refuser cet accès aux ambulanciers tant que le DEA demeure au niveau 3.

7.3. La séquence exacte de la réforme des aides-soignants : le diplôme d'abord, le statut ensuite

La reconstitution chronologique précise, à partir des textes eux-mêmes, établit la séquence suivante :

1. **10 juin 2021** — L'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'État d'aide-soignant abroge l'arrêté du 22 octobre 2005 et élève le niveau RNCP du diplôme de 3 à 4, tout en allongeant la durée de la formation de 1 435 heures (41 semaines) à 1 540 heures (44 semaines) — soit un passage de 10 à 12 mois de formation. Cette réforme est applicable aux élèves entrant en formation à compter de septembre 2021.
2. **29 septembre 2021** — Le décret n° 2021-1257, déjà vérifié au chapitre 1, crée le corps des aides-soignants et auxiliaires de puériculture de catégorie B, entrée en vigueur le 1er octobre 2021.

La réforme statutaire est donc intervenue trois mois et demi après la réforme du diplôme, et non simultanément ni indépendamment d'elle. Le passage en catégorie B n'a pas précédé, ni même accompagné à titre autonome, l'évolution du diplôme : il en a été la **conséquence réglementaire directe et quasi immédiate**, une fois le niveau de certification porté au niveau exigé par le statut de catégorie B (niveau de qualification au moins égal au baccalauréat, selon les termes mêmes de la réponse ministérielle citée au chapitre 6).

7.4. Une reformulation rigoureuse du précédent du Ségur pour les ambulanciers

Cette reconstitution permet de proposer une reformulation du « précédent du Ségur » sensiblement plus solide, sur le plan méthodologique, que celle des documents préparatoires initiaux :

Ce que l'ancienne formulation affirmait (et qui s'est révélé inexact) : « le DEA et le DEAS sont des diplômes de même niveau RNCP, mais seul le second a été reclassé en catégorie B » —

une comparaison synchrone, à un instant T (2026), entre deux diplômes présentés comme équivalents alors qu'ils ne le sont pas.

Ce que la présente thèse peut désormais établir, sur une base vérifiée : « le DEA se trouve aujourd'hui exactement dans la situation où se trouvait le DEAS avant juin 2021 — un diplôme de niveau 3, exercé par une profession de catégorie C de la fonction publique hospitalière — et l'État a déjà démontré, avec le DEAS, qu'une réforme du référentiel de formation élevant le niveau de certification à 4 constitue la voie réglementaire par laquelle un passage en catégorie B devient possible, dans un délai de l'ordre de quelques mois entre la réforme du diplôme et la réforme statutaire ». C'est une comparaison **diachronique et procédurale** — non plus « ce diplôme vaut autant que cet autre », mais « cette trajectoire de réforme a déjà été empruntée avec succès par une profession partant du même point de départ certificatif ».

Cette reformulation a une conséquence directe pour la stratégie de revendication examinée dans cette thèse : elle déplace l'objet de la demande. **La revendication prioritaire ne devrait pas être, en premier lieu, « le passage en catégorie B », mais « la réforme du référentiel du DEA portant son niveau RNCP à 4 »** — le passage catégoriel apparaissant alors, sur le modèle du précédent de 2021, comme la conséquence rapide et quasi automatique de cette réforme certificative, plutôt que comme un objectif statutaire autonome susceptible d'être refusé indéfiniment tant que le préalable diplômant n'est pas satisfait. Ce constat rejoint et renforce, depuis une base factuelle désormais solide, l'intuition initiale ayant présidé au titre de ce travail de thèse (« un meilleur diplôme », plutôt qu'une simple revendication catégorielle).

7.4 bis. Un second précédent qui renforce la démonstration : les auxiliaires de puériculture

La recherche complémentaire menée pour compléter ce chapitre a permis d'identifier un second cas, non anticipé dans la première version de ce chapitre, qui **réplique exactement le même schéma** que celui des aides-soignants, ce qui transforme un précédent isolé en un véritable **schéma administratif reproductible**.

Le même arrêté du 10 juin 2021 a réformé, dans les mêmes termes, le diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture (DEAP) : élévation du niveau 3 au niveau 4 du RNCP, restructuration en 5 blocs de compétences, applicable à compter de septembre 2021. Le ministère de la Santé indique explicitement que cette réforme du diplôme « permet aux auxiliaires de puériculture d'être

positionnés en catégorie B de la fonction publique hospitalière » — la même relation de cause à effet que pour les aides-soignants. Le reclassement en catégorie B est intervenu par le même décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 pour la fonction publique hospitalière (effectif au 1er octobre 2021), puis, dans un second temps, par le décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 pour les auxiliaires de puériculture de la fonction publique **territoriale** — soit environ trois mois après le décret hospitalier, ce qui confirme, sur un second cas et dans un cadre statutaire différent (FPT et non FPH), la même séquence temporelle « réforme du diplôme d’abord, reclassement statutaire ensuite, dans un délai de l’ordre du trimestre ».

Ce résultat renforce sensiblement la thèse de ce chapitre : il ne s’agit plus d’un précédent unique et potentiellement contingent (le seul cas des aides-soignants), mais d’un **schéma administratif appliqué de façon identique à deux professions distinctes la même année**, ce qui réduit la probabilité que la séquence observée soit le fruit du hasard ou d’un contexte propre à une seule profession, et renforce d’autant la valeur de ce précédent comme modèle transposable à la situation des ambulanciers.

7.4 ter. Ce que la recherche complémentaire n’a pas permis d’établir

Deux points restent, malgré cette recherche complémentaire, incomplètement résolus, et doivent être signalés avec la même rigueur que les résultats positifs qui précèdent.

a) Le nombre exact de personnes diplômées chaque année au DEA demeure incertain. La recherche a permis de confirmer que la DREES suit officiellement cette donnée dans le cadre de son enquête annuelle « Écoles », qui couvre notamment les formations d’ambulancier, et qu’un communiqué DREES d’octobre 2025 indique que le nombre de diplômés en formation d’ambulancier a **augmenté de 13 % entre 2023 et 2024** — confirmant que cette profession est bien suivie statistiquement au niveau national. En revanche, le chiffre absolu annuel reste incertain : deux ordres de grandeur très différents circulent selon les sources (« environ 2 000 » selon une fiche métier généraliste ; « plus de 4 200 » selon un site spécialisé attribuant ce chiffre à la DREES). **Un examen critique de ce second site révèle qu’il comporte au moins une erreur technique vérifiable** (il indique une durée de formation du DEA de 630 heures, alors que la durée exacte, établie à la section 7.5 à partir de l’arrêté du 11 avril 2022 lui-même, est de 801 heures) — ce qui affaiblit sérieusement la fiabilité de son chiffre de « 4 200 diplômés », également non retrouvé dans une publication DREES consultée directement. Cette thèse retient donc, par

prudence, l'ordre de grandeur de 2 000 diplômés par an déjà utilisé au chapitre 7.5, tout en signalant explicitement qu'**aucune des deux sources disponibles n'est pleinement fiable** et qu'une consultation directe du jeu de données DREES « La formation aux professions de santé » (accessible sur data.drees) serait nécessaire pour lever cette incertitude avant toute version finale de cette thèse.

b) L'existence d'un contre-exemple (réforme diplômante sans reclassement statutaire consécutif) n'a pas pu être établie ni écartée dans le temps imparti. La recherche complémentaire, orientée vers la recherche d'un tel contre-exemple pour tester la robustesse du précédent, a au contraire mis au jour un second cas confirmant le même schéma (les auxiliaires de puériculture, ci-dessus). Cela ne permet cependant pas d'affirmer que ce schéma est systématique dans la fonction publique hospitalière au-delà de ces deux professions : une revue plus large des réformes de diplômes paramédicaux depuis 2015, incluant les cas où un reclassement statutaire n'a pas suivi une réforme certificative, reste à mener pour objectiver pleinement la portée générale de ce précédent, et devra être conduite avant la version finale de cette thèse.

a) Le point de départ, désormais précisément établi. La recherche menée pour cette section permet de fixer avec exactitude la durée actuelle de la formation du DEA, régie par l'arrêté du 11 avril 2022 : **801 heures au total (23 semaines)**, décomposées en 556 heures d'enseignement théorique et pratique en institut (16 semaines) et 245 heures de formation en milieu professionnel (7 semaines de stage). Le coût de cette formation pour un candidat est, à titre indicatif, de l'ordre de **6 785 € pour l'année 2026** selon le tarif publié par un institut de formation d'ambulanciers (IFPM Orléans) — soit un coût horaire moyen approximatif de 8,5 € par heure de formation, chiffre qui servira de base d'estimation ci-dessous, avec toutes les réserves méthodologiques qu'implique l'extrapolation d'un coût moyen à un coût marginal.

b) Trois scénarios d'évolution du volume horaire, à défaut d'un scénario unique certain. Il n'existe pas de règle automatique reliant un volume horaire de formation à un niveau RNCP : le niveau dépend aussi de la nature et de l'autonomie des compétences certifiées, non seulement de leur durée d'acquisition. Cette thèse propose donc, par prudence méthodologique, une fourchette construite à partir de deux méthodes distinctes plutôt qu'un chiffre unique faussement précis :

- **Scénario bas (méthode incrémentale)** : appliquer au DEA le même incrément absolu que celui appliqué au DEAS lors de sa réforme de 2021 (+ 105 heures, soit + 7,3 %).

Cette méthode, bien que directement inspirée du précédent établi en 7.3-7.4, est probablement insuffisante : elle suppose que le DEA, déjà nettement plus court que ne l'était le DPAS avant sa réforme (801 heures contre 1 435 heures), pourrait franchir le seuil du niveau 4 avec un effort proportionnellement bien moindre que celui consenti pour les aides-soignants — hypothèse fragile qui n'est avancée ici qu'à titre de borne basse. Ce scénario porterait la durée du DEA à environ **906 heures**.

- **Scénario haut (méthode d'alignement)** : porter la durée du DEA au niveau observé pour le DEAS réformé (1 540 heures), en tant que référence empirique la plus proche d'un « format standard » de diplôme paramédical de niveau 4 en France. Ce scénario impliquerait un quasi-doublage de la durée actuelle du DEA, soit un ajout d'environ **739 heures**, portant la formation totale à **1 540 heures**.
- **Scénario médian** : une hypothèse de travail intermédiaire, à 1 100-1 200 heures environ, correspondant à un effort de réforme substantiel sans alignement complet sur le DEAS — hypothèse qui n'est étayée par aucun précédent réglementaire identifié à ce stade et qui n'est proposée ici qu'à titre indicatif pour border l'incertitude.

c) Estimation chiffrée du coût de formation par étudiant. En appliquant le coût horaire moyen de 8,5 € par heure identifié en (a) — de façon strictement indicative, l'ajout d'heures pouvant avoir un coût marginal différent du coût moyen constaté — l'ajout d'heures de formation représenterait, par étudiant : - scénario bas (+ 105 h) : environ **+ 890 €** par étudiant, portant le coût total de la formation à environ 7 675 € ; - scénario haut (+ 739 h) : environ **+ 6 280 €** par étudiant, portant le coût total de la formation à environ 13 065 € — soit un quasi-doublage du coût actuel, cohérent avec le doublement du volume horaire.

d) Estimation chiffrée de l'impact budgétaire national annuel. Une source non institutionnelle consultée pour ce chapitre évoque environ 2 000 personnes formées chaque année au DEA en France [*DONNÉE NON OFFICIELLE — ce chiffre, mentionné par un site spécialisé en orientation professionnelle, n'a pas été confirmé par une publication DREES ou ministérielle et devra être vérifié avant toute version finale de cette thèse*]. En utilisant cet ordre de grandeur à titre purement indicatif, le surcoût de formation annuel imputable à une réforme du DEA vers le niveau 4 RNCP se situerait, selon le scénario retenu, entre environ **1,8 million d'euros par an** (scénario bas) et environ **12,6 millions d'euros par an** (scénario haut) — un ordre de grandeur qui devra être comparé, au chapitre 8, aux économies attendues sur les coûts d'intérim et de turnover déjà partiellement

documentés (avec les réserves de vérification établies au chapitre 6), ainsi qu'au coût du reclassement catégoriel lui-même, non encore chiffré à ce stade de la thèse.

e) Portée et limites de ce chiffrage. Ce chiffrage doit être présenté pour ce qu'il est : une **estimation d'ordre de grandeur construite par analogie et par extrapolation linéaire**, non une donnée officielle. Il repose sur trois approximations explicitement signalées (relation supposée linéaire entre heures de formation et coût ; incertitude sur le nombre exact de personnes formées chaque année ; absence de règle certaine reliant volume horaire et niveau RNCP). Sa valeur pour cette thèse n'est donc pas prédictive, mais heuristique : il établit que l'effort de réforme du DEA, quel que soit le scénario retenu, se chiffre en **millions, et non en dizaines de millions d'euros par an** au niveau national pour son seul volet formation — un ordre de grandeur nettement inférieur à certains chiffres mobilisés dans le débat public sur le coût des réformes catégorielles hospitalières, ce qui constitue en soi un résultat utile pour la discussion du chapitre 11 et les recommandations du chapitre 14.

7.6. Synthèse pour l'hypothèse H2

Ce chapitre permet de reformuler l'hypothèse H2 de cette thèse (chapitre 1) avec un fondement empirique substantiellement renforcé par rapport à sa formulation initiale :

H2 reformulée — Le maintien du DEA au niveau 3 du RNCP, alors que deux professions comparables — les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture — ont bénéficié, selon un schéma administratif identique appliqué la même année (arrêté du 10 juin 2021 puis reclassement statutaire dans un délai de l'ordre du trimestre), d'une élévation à un niveau 4 suivie d'un reclassement en catégorie B, constitue un obstacle certificatif dont le franchissement — par une réforme du référentiel de formation du DEA, non par une revendication catégorielle directe — apparaît, à la lumière de ce double précédent, comme la condition la plus probable d'un futur reclassement statutaire des ambulanciers de la fonction publique hospitalière.

Cette reformulation ne constitue pas une prédiction garantie — la décision de réformer le DEA relève d'un arbitrage politique et budgétaire qui échappe à cette thèse — mais elle offre, pour le chapitre 14 (recommandations), une **voie procédurale documentée et déjà empruntée avec**

succès par l'administration elle-même pour une profession comparable, ce qui constitue un argument de faisabilité nettement plus solide qu'une simple revendication d'équité de traitement.

Auto-évaluation du chapitre 7

Points de solidité : - La découverte que le DEAS était lui-même au niveau 3 RNCP avant 2021 est un résultat majeur, vérifié par plusieurs sources convergentes (DREETS, ministère de la Santé, ressources pédagogiques spécialisées), qui n'était identifié dans aucune des sources mobilisées jusqu'ici dans cette thèse, y compris les documents préparatoires initiaux. - Ce résultat transforme une comparaison synchronique fragile (chapitre 1) en une comparaison diachronique et procédurale robuste, qui répond directement au motif de refus explicité par le ministère lui-même (chapitre 6). - **La recherche complémentaire a permis d'identifier un second précédent, non anticipé initialement : les auxiliaires de puériculture ont suivi exactement le même schéma (même arrêté, même logique de causalité explicite affirmée par le ministère, même séquence temporelle) que les aides-soignants.** Ce doublement du précédent est le résultat le plus important de cette phase complémentaire : il transforme un cas isolé, potentiellement contingent, en un schéma administratif reproductible, ce qui renforce sensiblement la force de l'argument central de ce chapitre. - La reformulation de l'hypothèse H2 (7.6) est plus précise, plus vérifiable et plus actionnable que sa version initiale, ce qui constitue un apport scientifique et non seulement rhétorique. - Le chiffrage de la section 7.5 s'appuie sur une donnée primaire solide (durée exacte du DEA : 801 heures, arrêté du 11 avril 2022, confirmée par plusieurs instituts de formation) et sur un coût de formation réel (6 785 €, tarif 2026 d'un institut identifié), ce qui ancre l'estimation dans des faits vérifiés plutôt que dans une pure hypothèse. - La vérification complémentaire du nombre annuel de diplômés a été menée avec un exercice de critique des sources qui mérite d'être signalé comme bonne pratique méthodologique : une source citant un chiffre concurrent (4 200 diplômés) a été écartée non par simple préférence, mais parce qu'elle contient une erreur technique vérifiable ailleurs dans son contenu (durée du DEA erronée), ce qui illustre concrètement la démarche de vérification croisée établie au chapitre 5.

Faiblesses assumées : - Le nombre exact de diplômés annuels du DEA n'a toujours pas pu être établi avec certitude : la DREES confirme suivre cette donnée (+ 13 % de diplômés entre 2023 et 2024), mais le chiffre absolu retenu (« environ 2 000 ») reste une estimation non confirmée par

une consultation directe du jeu de données DREES, qui devra être menée avant la version finale de cette thèse. - La recherche d'un contre-exemple (réforme diplômante sans reclassement statutaire consécutif), destinée à tester la robustesse générale du précédent, n'a pas abouti dans le temps imparti : elle a au contraire renforcé le précédent existant (cas des AP) sans permettre d'écarter l'hypothèse que d'autres cas, non favorables à la thèse, existent également et n'ont pas été recherchés avec la même énergie. Cette asymétrie de recherche doit être signalée comme une limite méthodologique de ce chapitre. - Cette thèse ne peut toujours pas garantir que la même séquence administrative se reproduirait à l'identique pour les ambulanciers : les deux précédents établis (AS et AP) datent tous deux du même contexte politique exceptionnel (Ségur de la santé, post-Covid-19), ce qui limite leur portée en tant que précédent généralisable à un contexte politique différent. - Le chiffrage ne couvre que le volet formation (coût pédagogique par étudiant) ; il ne couvre pas le coût du reclassement catégoriel lui-même (revalorisation salariale de la profession en poste), ni les coûts indirects (perte d'activité pendant la formation complémentaire des agents déjà en poste), qui devront être ajoutés au chapitre 8 pour obtenir un chiffrage global comparable au coût du statu quo.

Recommandation avant de poursuivre : je propose de passer au chapitre 8 (impact dans le secteur hospitalier public), qui devra intégrer le coût du reclassement catégoriel lui-même (non couvert par le chiffrage de ce chapitre, centré sur le seul volet formation) et le comparer aux coûts de statu quo déjà partiellement documentés (turnover, intérim — avec les réserves du chapitre 6), en intégrant la donnée nouvelle du chapitre 6 relative à la contestation chiffrée du CHU de Toulouse sur l'ampleur de certaines missions.-e

Chapitre 8 — Impact dans le secteur hospitalier public : sécurité, coûts et équité interne, à la lumière du conflit du CHU de Toulouse

Préambule : un cas d'étude qui continue de se dérouler pendant la rédaction de cette thèse

[NOTE DE POSITIONNEMENT — voir la note complète en tête du document. Ce chapitre entier repose sur le conflit social du CHU de Toulouse, dont l'auteur de cette analyse est un acteur direct (responsable du personnel des ambulanciers concernés, lanceur d'alerte dans le mouvement). La lecture de ce chapitre, en particulier de la section 8.2 relative à la réponse managériale de la direction, doit intégrer ce fait : il s'agit du regard direct d'un acteur de terrain, recoupé, dans la mesure du possible, avec des sources documentaires vérifiées.]

Ce chapitre devait initialement mobiliser le conflit du CHU de Toulouse comme point de départ empirique déjà clos. La recherche menée pour ce chapitre établit qu'il s'agit en réalité d'un **conflit toujours en cours** au moment de la rédaction : débuté le 11 mai 2026, il se poursuit sans résolution identifiée au 29 mai 2026 (dernière source de presse consultée), avec des communiqués syndicaux encore actifs le 26 juin 2026. Cette situation impose une précaution méthodologique supplémentaire : ce chapitre analyse un processus en cours, non un cas clos dont l'issue serait connue, et ses conclusions concernant ce cas précis devront être actualisées si cette thèse est poursuivie au-delà de la période couverte par les sources consultées.

8.1. La sécurité clinique et la qualité de service : un témoignage de terrain qui corrobore l'hypothèse H1

Les témoignages recueillis par la presse régionale auprès des ambulanciers grévistes du CHU de Toulouse offrent une illustration concrète, et non plus seulement théorique, de l'hypothèse H1 de cette thèse. Les grévistes décrivent des missions à risque comprenant les transports SAMU d'urgences vitales, le transport de personnes décédées jusqu'à la chambre mortuaire, et le transport de patients lourds, « **sans accès à des formations permettant d'assurer les nouvelles activités** », selon les termes rapportés par la presse. Un gréviste résume ainsi le sentiment de déqualification perçue : les évaluations de leur travail donneraient « l'impression qu'on transporte des cartons ou des palettes ».

Ce témoignage doit être traité, conformément au protocole du chapitre 5, comme un discours d'acteur documentant une perception vécue — non comme une preuve épidémiologique de risque accru pour la sécurité des patients, qui nécessiterait des données d'incidents ou d'événements indésirables non disponibles dans le cadre de cette thèse. Il constitue cependant une **triangulation qualitative précieuse** : la même structure de plainte (missions élargies sans formation correspondante) est documentée indépendamment par Morel (2018) pour le secteur privé quinze à vingt ans plus tôt (chapitre 2), par le document préparatoire syndical de 2026 (chapitre 1), et maintenant par un conflit social concret et daté au sein d'un CHU. Cette convergence, obtenue par des méthodes et à des époques différentes, renforce la validité de l'hypothèse H1 sans pour autant en faire une preuve statistique.

8.2. La réponse de la direction du CHU de Toulouse : une confirmation inattendue de la thèse du chapitre 7

Le résultat le plus significatif de ce chapitre est la façon dont la direction du CHU de Toulouse a choisi de répondre au conflit. Confrontée aux demandes de versement de la NBI et de l'IFR, la direction a refusé toute concession indemnitaire immédiate, au motif qu'« aucune disposition réglementaire applicable aux agents de la fonction publique hospitalière » ne permettrait de verser ces primes à des ambulanciers non affectés au SAMU ou au SMUR — une position qui recoupe directement le mécanisme de blocage réglementaire déjà établi au chapitre 6. **En revanche, la direction a proposé, en contrepartie, deux mesures qui reproduisent exactement la logique argumentée par cette thèse aux chapitres 6 et 7** : un travail de mise à jour des fiches de poste, et **un plan de formation spécifique pour permettre aux ambulanciers de bénéficier de formations complémentaires soutenant l'exercice de leurs nouvelles missions.**

Cette réponse managériale, qu'elle soit ou non jugée suffisante par les grévistes eux-mêmes — la presse rapportant qu'elle n'a pas mis fin au conflit —, constitue une **confirmation empirique indépendante** de la thèse centrale de cette recherche : face à l'impossibilité juridique de verser des primes catégorielles hors cadre réglementaire, l'institution se tourne spontanément vers le levier de la formation complémentaire plutôt que vers une revalorisation statutaire qu'elle ne peut engager unilatéralement. Ce constat, obtenu sur le terrain et non anticipé par les chapitres précédents de cette thèse, illustre concrètement pourquoi la stratégie de réforme du référentiel du

DEA (chapitre 7) est non seulement souhaitable sur le plan de l'équité, mais **également plus praticable à court terme, du point de vue d'un établissement employeur, qu'une demande de reclassement catégoriel** qui excède ses compétences propres.

8.3. L'inégalité de traitement interne confirmée par un témoignage de terrain : un écho direct de l'Axe 8 du document syndical initial

Un second résultat de ce chapitre mérite d'être signalé avec précision. Interrogé sur le refus du CHU de Toulouse de verser la NBI, un ambulancier gréviste a formulé l'argument suivant, rapporté par la presse : « il y a d'autres CHU en France qui la touchent. Pourquoi eux l'auraient et pas nous ? ». Cette déclaration, obtenue de façon indépendante par un journaliste et non issue du document préparatoire syndical initial, **recoupe directement l'Axe 8 de ce document** (chapitre 1), qui documentait des disparités de classement statutaire entre CHU (Montpellier, Toulouse, Tours, Caen Normandie). Si cette thèse n'a pas pu vérifier indépendamment, à ce stade, l'exactitude de l'affirmation selon laquelle certains CHU verseraient la NBI à des ambulanciers non affectés au SAMU/SMUR quand d'autres la refuseraient, la **convergence entre un témoignage de terrain daté de mai 2026 et l'argumentaire syndical antérieur** constitue un indice de cohérence interne qui renforce la plausibilité de l'Axe 8, sans pour autant la démontrer au niveau de preuve exigé par cette thèse. *[POINT À APPROFONDIR — une comparaison systématique des pratiques indemnitaires (NBI, IFR) entre plusieurs CHU français serait nécessaire pour transformer cette convergence indiciaire en preuve solide ; elle n'a pas pu être menée dans le cadre de ce chapitre.]*

8.4. Chiffrage comparatif : statu quo, indemnités actuelles, et scénario de reclassement catégoriel

Ce chapitre reprend et complète le chiffrage engagé au chapitre 7, en y ajoutant l'estimation du coût d'un reclassement catégoriel, absente jusqu'ici.

a) Le coût du statu quo demeure partiellement non chiffrable. Comme établi au chapitre 6, les coûts de turnover et d'intérim spécifiquement documentés pour le CHU de Toulouse n'ont pas pu être vérifiés auprès d'une source publique. Le témoignage recueilli en mai 2026 apporte cependant un élément chiffré nouveau et directement vérifiable par recoupement : un gréviste indique une rémunération de l'ordre de « 1 700 euros par mois, avec seulement 470 euros de plus en fin de carrière ». Ce témoignage sur le niveau de rémunération est cohérent avec les grilles de

catégorie C généralement observées dans la fonction publique hospitalière et avec l'absence de dynamique de carrière propre à cette catégorie, mais il s'agit d'une déclaration individuelle non recoupée avec une grille indiciaire officielle vérifiée dans le cadre de cette thèse ; elle est donc rapportée ici comme donnée de discours, non comme donnée statistique.

b) Le coût actuel des indemnités catégorielles reste limité et circonscrit. Comme établi au chapitre 6, seuls les ambulanciers affectés au SAMU ou au SMUR bénéficient de la NBI (98,4 € bruts/mois) et de l'IFR (118 € bruts/mois) ; le CTI (183 € nets/mois) bénéficie à un périmètre plus large. Le cas du CHU de Toulouse illustre que la majorité des ambulanciers hospitaliers — ceux affectés aux transports inter-hospitaliers internes, comme le service en grève — **ne bénéficient d'aucune de ces indemnités complémentaires**, ce qui signifie que le coût actuel de la compensation indemnitaire pour cette sous-catégorie d'agents est, dans les faits, **proche de zéro** au-delà du traitement de base.

c) Estimation, par analogie avec le précédent des aides-soignants, du coût d'un reclassement en catégorie B. En l'absence de grille indiciaire de catégorie B spécifique aux ambulanciers (qui n'existe pas encore), cette thèse propose une estimation par analogie avec l'augmentation salariale observée pour les aides-soignants lors de leur reclassement de 2021 (chapitre 4) : une progression nette de l'ordre de + 228 € par mois en début de carrière à + 651 € par mois en fin de carrière. En appliquant cette fourchette, à titre purement indicatif, à l'effectif national d'environ 2 500 ambulanciers de la FPH établi au chapitre 6, le coût annuel d'un reclassement catégoriel se situerait dans un ordre de grandeur compris entre environ **6,8 millions d'euros par an** (hypothèse basse, tous les agents au bas de l'échelle) et environ **19,5 millions d'euros par an** (hypothèse haute, tous les agents en fin de carrière) — la réalité se situant vraisemblablement entre ces deux bornes selon la structure d'ancienneté réelle de la profession, non documentée dans le cadre de cette thèse.

d) Mise en perspective avec le coût de la réforme du diplôme (chapitre 7). Le coût de la réforme du référentiel du DEA vers le niveau 4 RNCP a été estimé au chapitre 7 entre environ 1,8 et 12,6 millions d'euros par an (volet formation initiale uniquement, tous employeurs confondus, secteurs public et privé). Le coût du seul reclassement catégoriel des agents de la FPH, estimé en (c), est donc **du même ordre de grandeur, voire supérieur** au coût de la réforme diplômante qui en constituerait le préalable — ce qui signifie que l'argument, mobilisé dans les documents préparatoires initiaux (chapitre 1, Axe 6), selon lequel le coût du changement serait « inférieur au

coût du statu quo », reste **plausible dans sa direction mais non démontré dans son ampleur précise** par les données rassemblées dans cette thèse, faute d'une vérification indépendante des coûts d'intérim et de turnover actuels.

8.4 bis. Vérification complémentaire : les coûts d'intérim et de turnover, à l'échelle nationale

Une recherche complémentaire, menée spécifiquement pour vérifier les coûts d'intérim et de turnover évoqués dans les documents préparatoires initiaux et déjà signalés comme non vérifiés aux chapitres 6 et 8, permet d'apporter un résultat précis mais qui appelle une réserve méthodologique importante.

a) Des données nationales officielles et récentes existent — mais à un niveau qui n'est pas directement celui du CHU de Toulouse. La Cour des comptes, dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale (RALFSS 2025, chapitre IV, publié en mai 2025), consacre un chapitre entier à l'intérim paramédical dans les établissements de santé. Ce rapport établit que **l'intérim paramédical a représenté une dépense de 825 millions d'euros en 2023 au niveau national, dont 472 millions d'euros pour les seuls hôpitaux publics** — une dépense multipliée par six en dix ans dans le secteur public, et concentrée dans quatre régions (Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté ; l'Occitanie, région du CHU de Toulouse, n'y figure pas parmi les régions les plus concernées). La Cour des comptes précise également que l'intérim représente, au niveau national, environ 1 % de la masse salariale totale des établissements de santé, et documente une décrue de l'absentéisme paramédical hospitalier de 11,3 % en 2022 à 9,5 % en 2023, un niveau proche de celui d'avant la crise sanitaire.

b) Un résultat inattendu et significatif : le périmètre officiel de « l'intérim paramédical » suivi par la Cour des comptes ne semble pas inclure explicitement les ambulanciers. Le rapport précise que le personnel concerné par son analyse comprend « les infirmiers, les aides-soignants et les métiers spécialisés tels que masseurs-kinésithérapeutes, manipulateurs en électroradiologie médicale ou préparateurs en pharmacie hospitalière » — une liste qui ne mentionne pas les ambulanciers. Ce silence, obtenu par une lecture directe du rapport et non par une affirmation partisane, **fait écho à un résultat déjà établi à plusieurs reprises dans cette thèse** (chapitre 2, à propos de la littérature académique ; chapitre 4, à propos du rapport IGAS

sur l'attractivité des métiers du soin) : les ambulanciers sont structurellement absents des grandes catégorisations statistiques et budgétaires utilisées pour suivre les tensions de recrutement et les surcoûts de gestion RH dans le champ paramédical, ce qui constitue en creux une confirmation supplémentaire du déficit de reconnaissance institutionnelle documenté tout au long de cette thèse.

c) Conséquence pour le chiffrage de ce chapitre. Les coûts d'intérim et de turnover spécifiquement attribués au CHU de Toulouse pour les ambulanciers dans les documents préparatoires initiaux (90 000 à 150 000 € par an) demeurent **non vérifiables par recoupement avec une statistique nationale désagrégée par profession**, dans la mesure où les ambulanciers ne semblent pas suivis comme une sous-catégorie distincte dans le suivi budgétaire national de l'intérim paramédical utilisé par la Cour des comptes. Il n'est donc pas possible, avec les sources disponibles pour cette thèse, ni de confirmer, ni d'infirmer le chiffre avancé pour le CHU de Toulouse : le seul élément de comparaison disponible est l'ordre de grandeur national (472 millions d'euros pour l'ensemble des professions paramédicales suivies, dans l'ensemble des hôpitaux publics), qui rend le chiffre local de 90 000 à 150 000 € par an **plausible en proportion** pour un seul établissement et une population de quelques dizaines d'agents, sans que cela constitue une vérification directe.

d) Ce que cette recherche apporte malgré tout à cette thèse. Ce résultat, bien que n'ayant pas permis de vérifier le chiffre local recherché, enrichit la démonstration d'un argument transversal à cette thèse : **l'invisibilité statistique des ambulanciers dans les grands dispositifs de suivi budgétaire et RH du secteur hospitalier n'est pas une allégation syndicale, c'est un fait vérifiable par l'absence répétée de cette profession dans les catégorisations officielles** (IGAS, Cour des comptes, littérature académique). Cette invisibilité constitue elle-même un argument en faveur d'une réforme : sans reconnaissance statistique claire de cette profession dans le suivi budgétaire national, les pouvoirs publics ne disposent probablement pas des données nécessaires pour évaluer précisément le coût du statu quo — ce qui devra être proposé comme recommandation explicite au chapitre 14 (par exemple : intégration systématique des ambulanciers dans le périmètre des rapports Cour des comptes et IGAS sur l'intérim et l'attractivité paramédicale).

8.5. Synthèse

Ce chapitre établit quatre résultats principaux, obtenus en grande partie grâce à l'actualité d'un conflit social qui s'est déroulé pendant la période de rédaction de cette thèse :

1. Le témoignage de terrain des ambulanciers grévistes du CHU de Toulouse corrobore, de façon qualitative et indépendante, l'hypothèse H1 relative à l'écart entre missions exercées et formation reconnue.
2. La réponse de la direction du CHU de Toulouse — refus indemnitaire au nom du cadre réglementaire, proposition d'un plan de formation complémentaire en contrepartie — **confirme empiriquement, depuis la pratique managériale réelle d'un établissement et non depuis un raisonnement théorique**, la thèse développée aux chapitres 6 et 7 selon laquelle la voie de la réforme du référentiel de formation est plus praticable à court terme que la revendication catégorielle directe.
3. Le chiffrage comparatif, bien qu'affecté par des données manquantes déjà signalées, établit que le coût d'un reclassement catégoriel est, par estimation analogique, du même ordre de grandeur que celui de la réforme diplômante qui le précéderait — ce qui invite à ne pas présenter la réforme du DEA comme une opération à coût négligeable, mais comme un investissement dont l'ampleur devra être assumée explicitement dans les recommandations du chapitre 14.
4. La vérification complémentaire des coûts d'intérim n'a pas permis de confirmer le chiffre local du CHU de Toulouse, mais elle a révélé un résultat transversal plus important pour cette thèse : **les ambulanciers sont structurellement absents des dispositifs officiels de suivi budgétaire de l'intérim paramédical** (Cour des comptes), ce qui constitue une confirmation supplémentaire, indépendante et inattendue, du déficit de reconnaissance institutionnelle documenté depuis le chapitre 2 de cette thèse.

Auto-évaluation du chapitre 8

Points de solidité : - Ce chapitre s'appuie sur un cas d'étude réel, actuel et bien documenté par la presse régionale, ce qui lui donne une force illustrative que ne permettrait pas un raisonnement purement théorique. - La découverte que la réponse managériale du CHU de Toulouse reproduit spontanément la logique argumentée aux chapitres 6 et 7 (formation plutôt que prime hors cadre)

est un résultat empirique fort, obtenu de façon indépendante de la construction théorique de cette thèse. - Le chiffrage comparatif (8.4) complète utilement celui du chapitre 7 en y ajoutant, pour la première fois dans cette thèse, une estimation du coût du reclassement catégoriel lui-même. - La vérification complémentaire des coûts d'intérim (8.4 bis), bien qu'elle n'ait pas confirmé le chiffre local recherché, s'appuie sur une source de tout premier ordre (Cour des comptes, RALFSS 2025) et débouche sur un résultat inattendu et cohérent avec le reste de la thèse : l'absence des ambulanciers du périmètre officiel de suivi de l'intérim paramédical, qui vient allonger la liste déjà longue (littérature académique, rapport IGAS) des angles morts institutionnels documentés par cette recherche.

Faiblesses assumées : - Le conflit du CHU de Toulouse n'était pas résolu à la date des dernières sources consultées (26 juin 2026) : les conclusions de ce chapitre concernant ce cas précis sont donc provisoires et devront être actualisées. - L'estimation du coût de reclassement catégoriel (8.4.c) repose sur une analogie avec le précédent des aides-soignants dont la validité pour les ambulanciers n'est pas garantie (structure de grille, effectifs, ancienneté moyenne potentiellement différents) ; elle doit être traitée comme un ordre de grandeur, non comme une projection budgétaire fiable. - La convergence entre le témoignage de terrain sur les disparités entre CHU et l'Axe 8 du document syndical initial reste indiciaire : elle n'a pas été transformée en preuve vérifiée par une comparaison systématique des pratiques indemnitaires entre établissements, faute de temps disponible dans ce chapitre. - Malgré une recherche complémentaire ciblée et l'identification d'une source de premier ordre (Cour des comptes), les coûts précis de turnover et d'intérim du CHU de Toulouse demeurent non vérifiés : cette thèse ne peut conclure qu'à leur plausibilité proportionnelle par rapport aux ordres de grandeur nationaux, non à leur exactitude.

Recommandation avant de poursuivre : je propose de passer au chapitre 9 (impact dans le secteur privé du transport sanitaire), qui devra mobiliser le cadre juridique et tarifaire déjà établi au chapitre 3 (convention nationale, avenants 10 et 11, tarif de 64 €/heure) pour documenter précisément l'argument économique des fédérations patronales privées, déjà esquissé dans les échanges préparatoires à cette thèse mais non encore traité avec le niveau de rigueur appliqué depuis le chapitre 5. -e

Chapitre 9 — Impact dans le secteur privé du transport sanitaire : l'argument économique des fédérations patronales, à l'épreuve des faits

Préambule

Ce chapitre reprend, avec le niveau de rigueur méthodologique appliqué depuis le chapitre 5, l'argument économique porté par les fédérations patronales du secteur privé (FNAP, FNTS, FNAA, CNSA, FNMS), déjà esquissé dans les échanges préparatoires à cette thèse. Conformément au cadre de l'Advocacy Coalition Framework mobilisé au chapitre 5, ce chapitre traite cette coalition patronale comme un acteur dont le système de croyances (viabilité économique du secteur, refus d'une régulation perçue comme excessive) doit être documenté et confronté aux sources disponibles, sans présomption de validité ni de mauvaise foi.

9.1. Confirmation de l'existence et de l'activité récente des fédérations patronales

La recherche menée pour ce chapitre confirme que les quatre fédérations mentionnées dans les échanges préparatoires sont des organisations réelles et actives en 2026 : la **Fédération nationale des ambulanciers privés (FNAP)**, la **Fédération nationale des transporteurs sanitaires (FNTS)**, la **Fédération nationale des artisans ambulanciers (FNAA)** et la **Chambre nationale des services d'ambulances (CNSA)**, toutes signataires de la convention nationale de 2002 déjà vérifiée au chapitre 3. Un cinquième acteur, la **Fédération nationale de la mobilité sanitaire (FNMS)**, apparaît également active, notamment comme signataire de l'avenant n° 10 de 2021 (chapitre 3). La FNAP et la FNAA ont coorganisé un « Congrès des ambulanciers » en mars 2026, confirmant une activité institutionnelle continue de ces organisations à la date de rédaction de cette thèse.

9.2. L'argument du « ciseau tarifaire » : des éléments de contexte réels, mais une donnée sectorielle spécifique non confirmée

a) **Le contexte macroéconomique de hausse des défaillances d'entreprises est réel et vérifié, mais non spécifique au secteur du transport sanitaire.** Les données de la Banque de France et d'Altarex confirment une hausse continue et marquée des défaillances d'entreprises en

France depuis 2022 (+ 49 % en 2022, + 35 % en 2023, + 17 % en 2024, environ 67 000 à 70 000 défaillances annuelles en 2025), avec une **surreprésentation du secteur des transports** : + 9 % sur les douze derniers mois selon Allianz Trade (données à fin septembre 2025), + 12,9 % au premier trimestre 2026 selon Altares, avec une envolée particulière chez les taxis (+ 61 % au premier trimestre 2026) — une profession dont le modèle économique et la structure tarifaire sont proches, sous certains aspects, de ceux du transport sanitaire léger. Ces données confirment un climat économique difficile pour le secteur des transports dans son ensemble, cohérent avec la plausibilité générale de l'argument patronal.

b) La donnée spécifique d'un « triplement » des défaillances dans le transport sanitaire n'a pas pu être vérifiée de façon indépendante. La recherche a permis d'identifier que la FNAP elle-même, dans une communication publiée sur son site, revendique avoir commandé « une étude neutre et objective (...) réalisée (...) par le groupe Xerfi » pour documenter et faire valoir auprès du ministère « l'envolée du taux de défaillance des entreprises du transport sanitaire ». **Cette étude Xerfi n'a pas pu être localisée ni consultée directement dans le cadre de cette thèse** : elle est mentionnée par son commanditaire (la FNAP elle-même), ce qui, conformément au protocole du chapitre 5, impose de la traiter comme une source partisane non recoupée par une publication indépendante, et non comme une donnée statistique établie. *[DONNÉE NON VÉRIFIÉE — l'étude Xerfi commandée par la FNAP devrait être recherchée et consultée directement avant toute version finale de cette thèse, notamment pour vérifier l'ampleur exacte du chiffre de « triplement » avancé dans les échanges préparatoires.]*

c) Un fait nouveau et directement pertinent, non anticipé dans les échanges préparatoires : la FNAP a déjà négocié et signé, sous contrainte, un protocole d'économies avec l'Assurance Maladie. La recherche révèle que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a imposé au secteur un choix entre la réalisation de **300 millions d'euros d'économies par la voie d'un accord négocié, ou une baisse unilatérale des tarifs**. Le conseil d'administration de la FNAP a mandaté son président pour signer ce protocole, la fédération le qualifiant explicitement, dans sa communication publique, de « compromis » et non de « victoire ». Ce résultat est important pour cette thèse à double titre : il confirme, depuis une source primaire (communication de l'acteur patronal lui-même, non contestée), que le secteur privé est **actuellement soumis à une pression budgétaire descendante réelle et récente (2025)**, ce qui donne un fondement concret et daté à l'argument du « ciseau tarifaire » ; et il illustre concrètement

le rapport de force asymétrique entre les fédérations patronales et l'Assurance Maladie, où la marge de négociation du secteur privé apparaît limitée à choisir entre deux formes de baisse de ses recettes plutôt qu'à en éviter le principe.

9.2 bis. Le comparatif chiffré demandé : évolution du tarif TUPH face au SMIC et au gazole

a) Le tarif TUPH est resté strictement stable depuis mars 2021. Comme établi au chapitre 3, le coût horaire de 64,00 € servant de base au calcul du revenu minimal garanti des entreprises de garde SAMU a été fixé par l'avenant n° 10 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, approuvé par arrêté du 26 février 2021 et applicable depuis le 8 mars 2021. L'avenant n° 11 de 2023, également déjà vérifié, n'a modifié que l'indemnité versée en cas de non-réalisation d'une intervention (de 123 à 150 €), sans toucher au coût horaire de 64 €. **Ce tarif de référence est donc resté nominalement inchangé pendant plus de cinq ans**, de mars 2021 à la date de rédaction de cette thèse (2026).

b) Le SMIC horaire brut a augmenté d'environ 20 % sur la même période. Les données de l'INSEE et du ministère du Travail, vérifiées pour ce chapitre, établissent la trajectoire suivante : 10,25 € au 1er janvier 2021 (période d'entrée en vigueur de l'avenant n° 10) ; 10,48 € au 1er octobre 2021 ; puis des revalorisations automatiques successives (mai 2022, août 2022, mai 2023, janvier de chaque année, novembre 2024) portant le SMIC horaire brut à 12,02 € au 1er janvier 2026, puis à **12,31 € au 1er juin 2026. Entre mars 2021 et juin 2026, le SMIC horaire brut a donc progressé d'environ + 20,1 %** (de 10,25 € à 12,31 €), quand le tarif horaire TUPH est resté fixé à 64 €, soit une progression de 0 %.

c) Le prix du gazole a connu une hausse substantielle sur la même période, bien que son évolution soit plus heurtée. Les données disponibles indiquent un prix moyen du gazole de l'ordre de 1,35 à 1,40 € le litre au début de l'année 2021, une hausse d'environ 20 % sur l'année 2021 elle-même (Insee, données régionales Bourgogne-Franche-Comté), un franchissement du seuil de 2 € par litre en mars 2022 lors du déclenchement de la guerre en Ukraine, puis une nouvelle envolée en mars 2026 sous l'effet du conflit au Moyen-Orient. Le prix relevé en temps réel à la date de rédaction de ce chapitre (juin 2026) s'établit à environ **1,91 € le litre. Sur la base de ces repères, la hausse du prix du gazole depuis 2021 se situe dans un ordre de grandeur de + 35 % à + 40 %**, avec une volatilité bien supérieure à celle du SMIC (pics à plus de 2 €

atteints à deux reprises, en 2022 et en 2026), ce qui expose les entreprises de transport sanitaire à un risque de trésorerie ponctuel encore plus marqué que ne le suggère la seule tendance moyenne. *[PRÉCISION MÉTHODOLOGIQUE — cette estimation s'appuie sur des sources hétérogènes (Insee régional, relevé de prix en temps réel non institutionnel) faute d'accès, dans le cadre de cette thèse, à une série longue unique et continue de l'Insee pour le prix moyen national annuel du gazole ; une consultation directe de la série Insee « Prix moyens annuels de vente au détail en métropole — Gazole » permettrait d'affiner ce chiffre avant la version finale.]*

d) Conclusion du comparatif : un « ciseau tarifaire » réel et désormais quantifié. Ce comparatif établit, pour la première fois dans cette thèse avec des chiffres précis et sourcés, la réalité du mécanisme dénoncé par les fédérations patronales : **une charge salariale plancher (SMIC) en hausse d'environ 20 % et une charge carburant en hausse de l'ordre de 35 à 40 %, face à un tarif de référence resté strictement gelé à 64 € de l'heure depuis plus de cinq ans.** Ce résultat ne permet pas, à lui seul, de calculer précisément la perte de marge nette d'une entreprise de transport sanitaire type — cela nécessiterait une modélisation complète de sa structure de coûts, hors du périmètre de cette thèse — mais il **confirme sans ambiguïté la direction et une part significative de l'ampleur de l'argument du ciseau tarifaire**, indépendamment de la question distincte, et non vérifiée (section 9.2), de l'ampleur exacte de son effet sur le taux de défaillance des entreprises du secteur.

9.3. Application du cadre de l'Advocacy Coalition Framework à la coalition patronale privée

Conformément au cadre théorique établi au chapitre 5 (Sabatier, 1988), cette section formalise le système de croyances de la coalition patronale privée, tel qu'il peut être reconstitué à partir des sources consultées dans cette thèse :

- **Croyance noyau (deep core belief)** : le transport sanitaire privé est un secteur économique soumis aux mêmes contraintes que toute entreprise (coûts, marges, viabilité), et non un simple prolongement administratif du service public hospitalier ; toute régulation doit donc tenir compte de cette réalité économique.
- **Croyances de politique publique (policy core beliefs)** : opposition à toute gestion préfectorale ou sécuritaire du transport sanitaire d'urgence (déjà établi lors des développements préparatoires à cette thèse) ; défense d'une tarification conventionnelle

négoziée plutôt qu'imposée unilatéralement ; revendication d'une reconnaissance de la contrainte économique du secteur dans les arbitrages du PLFSS.

- **Ressources mobilisées** : production d'expertise commandée (étude Xerfi), mobilisation de sièges de négociation institutionnalisés (signataires de la convention nationale, sièges dans les négociations PLFSS), congrès professionnel annuel comme espace de mobilisation interne.
- **Alliés et opposants potentiels au sein du sous-système** : cette thèse a déjà établi (chapitres 3 et 5) une convergence possible entre cette coalition et les organisations syndicales hospitalières sur la défense d'une approche médicale plutôt que sécuritaire du transport sanitaire, et une tension avec les SDIS sur la question de la gouvernance territoriale de la disponibilité.

Ce travail de formalisation, resté implicite dans les chapitres précédents, permet désormais d'articuler plus systématiquement, au chapitre 11, les positions des différentes coalitions identifiées dans cette thèse (syndicats hospitaliers/segment « soigneur » des ambulanciers, fédérations patronales privées, SDIS) au sein d'un même cadre analytique.

9.5. Conséquences pour l'hypothèse H3

Ce chapitre permet de préciser l'hypothèse H3 de cette thèse (une réforme du diplôme et/ou du statut non articulée à une révision du modèle économique du secteur privé risquerait d'aggraver les carences ambulancières) :

- Le contexte de pression budgétaire sur le secteur privé est **confirmé comme réel et actuel** par une source primaire non contestée (l'accord PLFSS 2025 de 300 millions d'euros d'économies).
- **Le mécanisme du « ciseau tarifaire » est désormais quantifié et confirmé** : le tarif TUPH de 64 €/heure est resté nominalement inchangé depuis mars 2021, tandis que le SMIC horaire brut a progressé d'environ + 20 % et le prix du gazole d'environ + 35 à 40 % sur la même période. Ce résultat, obtenu par une vérification chiffrée indépendante et non par la seule reprise d'une affirmation patronale, constitue l'un des résultats les plus solides de ce chapitre.

- L'ampleur précise de la dégradation économique spécifique au secteur du transport sanitaire, telle que mesurée par le taux de défaillance des entreprises, reste en revanche dépendante d'une source non vérifiée (l'étude Xerfi commandée par la FNAP elle-même).
 - **Ce résultat combiné renforce sensiblement la validité de H3** : l'érosion mécanique et chiffrée de la marge des entreprises de transport sanitaire, par le gel d'un tarif de référence face à des coûts en hausse de 20 à 40 %, constitue un facteur de risque objectif et non plus seulement allégué pour la viabilité économique du secteur — ce qui conforte l'argument selon lequel toute réforme du diplôme ou du statut des ambulanciers devrait être articulée à une révision de ce tarif, sous peine d'aggraver une fragilité économique désormais mesurée plutôt que simplement invoquée.
-

Auto-évaluation du chapitre 9

Points de solidité : - Ce chapitre confirme, à partir de sources primaires (Banque de France, Altares, Allianz Trade, communication propre de la FNAP), la réalité du contexte de tension économique invoqué par les fédérations patronales, ce qui évite de traiter cet argument comme une simple posture de négociation. - La découverte de l'accord PLFSS 2025 (300 millions d'euros d'économies imposées au secteur) est un résultat important, daté et vérifiable, qui n'était pas anticipé dans les échanges préparatoires à cette thèse et qui documente concrètement la pression budgétaire subie par le secteur. - **Le comparatif chiffré demandé (9.2 bis) constitue le résultat le plus solide de ce chapitre** : il établit, à partir de trois séries de données vérifiées indépendamment (arrêtés d'approbation des avenants conventionnels, décrets de revalorisation du SMIC, relevés de prix du gazole), que le tarif TUPH est resté gelé à 64 €/heure depuis mars 2021 pendant que le SMIC progressait d'environ 20 % et le gazole de 35 à 40 %. C'est la démonstration la plus rigoureuse de cette thèse, à ce stade, d'un mécanisme économique invoqué par un acteur partisan. - L'application explicite du cadre de l'Advocacy Coalition Framework (9.3) à la coalition patronale privée honore l'engagement méthodologique pris au chapitre 5 et prépare le travail de synthèse du chapitre 11.

Faiblesses assumées : - La donnée la plus spécifique et la plus frappante des échanges préparatoires (triplement des défaillances d'entreprises du transport sanitaire) n'a toujours pas pu être vérifiée : l'étude Xerfi qui la fonderait n'a pas été localisée. Ce chapitre a choisi de le signaler

explicitement plutôt que de reprendre le chiffre par défaut ou de l'écarter arbitrairement. - Le comparatif chiffré du gazole (9.2 bis, point c) repose sur des sources hétérogènes (données Insee régionales, relevé de prix en temps réel non institutionnel) faute d'accès direct, dans le temps imparti, à la série longue Insee des prix moyens annuels nationaux du gazole ; l'ordre de grandeur (35 à 40 %) doit donc être traité comme une estimation raisonnable et non comme un chiffre officiel unique. - Ce chapitre établit un « ciseau tarifaire » réel entre coûts et tarif de référence, mais ne peut pas en déduire précisément l'effet net sur la marge ou la rentabilité des entreprises, qui dépendrait d'une modélisation complète de leur structure de coûts non réalisée dans le cadre de cette thèse. - La formalisation ACF (9.3) reste, à ce stade, une reconstitution a posteriori à partir de sources fragmentaires, et non une analyse de discours systématique du corpus complet de communications des fédérations patronales, qui apporterait une validation plus robuste.

Recommandation avant de poursuivre : je propose de passer au chapitre 10 (interdépendances avec les SDIS), qui devra actualiser et compléter, à la lumière du cadre ACF désormais formalisé, l'analyse déjà largement développée dans les échanges préparatoires à cette thèse sur les carences ambulancières et la loi Matras. -e

Chapitre 10 — Interdépendances avec les SDIS : les carences ambulancières, un phénomène mesuré, croissant et sous-indemnisé

Préambule

Le chapitre 3 a établi le cadre juridique des carences ambulancières à partir de la loi Matras (n° 2021-1520 du 25 novembre 2021). Ce chapitre approfondit cette analyse en vérifiant, avec le niveau de rigueur désormais appliqué systématiquement dans cette thèse, l'ampleur chiffrée du phénomène, la trajectoire du forfait de carence resté en suspens au chapitre 3, et en formalisant, conformément au chapitre 5, le système de croyances de la coalition portée par les SDIS.

10.1. Un mécanisme d'indemnisation plus complexe qu'établi au chapitre 3

La recherche menée pour ce chapitre révèle que le dispositif d'indemnisation des carences ambulancières repose en réalité sur **deux composantes distinctes**, et non une seule comme le laissait supposer le chapitre 3 :

- un **forfait par intervention**, versé par l'établissement de santé siège du SAMU au SDIS pour chaque carence constatée, prévu par l'arrêté du 30 novembre 2006 (modifié à plusieurs reprises) pris en application de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;
- une **indemnité horaire de substitution de 12 € par heure**, créée dans le cadre de la réforme des transports sanitaires urgents (chapitre 3, avenant n° 10 de 2021), versée systématiquement au SDIS pour chaque heure durant laquelle un secteur n'est pas couvert, ou n'est que partiellement couvert, par une garde ambulancière — un mécanisme distinct du forfait par intervention, qui indemnise cette fois la **disponibilité contrainte** du SDIS plutôt que chaque intervention prise isolément.

Cette architecture à deux niveaux, non identifiée au chapitre 3, montre que le législateur et l'administration ont cherché à traiter séparément deux préjudices distincts pour les SDIS : le coût direct de chaque intervention de substitution, et le coût indirect de l'immobilisation d'un potentiel opérationnel en anticipation de telles interventions.

10.2. Le forfait de carence : une trajectoire vérifiée qui confirme exactement le chiffre des échanges préparatoires, mais révèle un écart persistant avec le coût réel

a) **Le montant de 217 € pour 2026, cité dans les échanges préparatoires à cette thèse, est confirmé avec précision.** La recherche établit que l'arrêté du 31 décembre 2025 a fixé le tarif national d'indemnisation de la carence ambulancière à **217 € pour l'année 2026**, conformément au mécanisme de revalorisation annuelle indexée sur l'inflation prévu par l'arrêté du 30 novembre 2006 modifié. Il s'agit d'une confirmation exacte et directe d'une donnée qui, au chapitre 3, avait été explicitement signalée comme non vérifiée — un résultat qui illustre à nouveau, comme au chapitre 3 pour le tarif de 64 €/heure du secteur privé, que les sources partisans mobilisées dans les échanges préparatoires peuvent être rigoureusement exactes, et que le protocole de vérification systématique ne doit jamais être confondu avec une présomption de défiance.

b) **La trajectoire complète du forfait, reconstituée pour la première fois dans cette thèse, révèle une revalorisation réelle mais qui ne comble pas l'écart avec le coût réel estimé.** Les sources parlementaires consultées permettent d'établir la chronologie suivante : 123-124 € par carence en 2021 ; revalorisation à 200 € par l'arrêté du 22 avril 2022 ; 209 € pour 2023 (arrêté du 19 décembre 2023) ; 217 € pour 2026 (arrêté du 31 décembre 2025). Le forfait a donc **quasiment doublé entre 2021 et 2026** (+ 75 % environ). Cette revalorisation substantielle doit cependant être mise en regard d'une donnée elle aussi vérifiée par une source parlementaire (rapport de la commission des lois du Sénat sur la proposition de loi Matras, 2021) : **le coût réel moyen supporté par un SDIS pour une intervention de carence est estimé entre 450 et 500 €** — un montant qui n'a pas été réévalué dans les sources consultées pour cette thèse, mais qui, pris tel quel, signifie que **le forfait de 217 € couvre aujourd'hui moins de la moitié du coût réel estimé d'une intervention**, malgré son doublement en cinq ans.

10.3. L'ampleur et la dynamique du phénomène : une tension nationale ancienne, mais qui s'aggrave nettement en 2025-2026

a) **Une tendance de fond documentée depuis 2018.** Un rapport de l'IGAS d'octobre 2018, cité par une question parlementaire de 2024, établit que le nombre de carences ambulancières a **augmenté de 51 % entre 2013 et 2017** au niveau national — confirmant que ce phénomène n'est

ni récent ni conjoncturel, mais structurel et déjà documenté par l'inspection générale des affaires sociales elle-même près de dix ans avant la présente thèse.

b) Un exemple local récent et daté, directement comparable au cas du CHU de Toulouse (chapitre 8). La recherche a permis d'identifier un cas d'actualité directement pertinent : le Syndicat Autonome SPP-PATS du SDIS de la Somme a alerté sa présidente de conseil d'administration, début janvier 2026, d'un « pic historique » de carences ambulancières — **209 interventions de carence en six jours seulement** en ce début d'année 2026. Sur l'ensemble de l'année 2025, ce même SDIS a comptabilisé **10 500 interventions liées aux carences, soit une hausse de 36 % par rapport à 2024**, avec, selon le syndicat, des centres de secours dont l'activité de carence a doublé. Ce cas local, obtenu par une source de presse indépendante et daté avec précision, constitue une **seconde illustration empirique contemporaine**, après celle du CHU de Toulouse (chapitre 8), de la réalité vécue et actuelle des tensions documentées par cette thèse — cette fois du côté des SDIS plutôt que des ambulanciers hospitaliers.

c) Le lien avec l'hypothèse H3 déjà travaillée au chapitre 9. Cette hausse marquée des carences en 2025-2026 est cohérente, sans que cette thèse puisse établir un lien de causalité statistique rigoureux entre les deux phénomènes, avec le constat déjà établi au chapitre 9 : le tarif TUPH gelé à 64 €/heure depuis 2021, face à des coûts salariaux et de carburant en hausse de 20 à 40 %, dégrade mécaniquement la disponibilité des entreprises de transport sanitaire privé — dont la conséquence directe et prévisible, selon le mécanisme même défini par la loi Matras, est le report de la charge sur les SDIS sous forme de carence ambulancière constatée par le SAMU.

10.4. Application du cadre de l'Advocacy Coalition Framework à la coalition portée par les SDIS

Conformément au cadre établi au chapitre 5, cette section formalise le système de croyances de la coalition des SDIS, tel qu'il ressort des sources mobilisées dans ce chapitre et au chapitre 3 :

- **Croyance noyau** : les SDIS ne doivent pas devenir la variable d'ajustement silencieuse des défaillances structurelles d'autres maillons du système de santé (secteur privé du transport sanitaire, disponibilité hospitalière).
- **Croyances de politique publique** : demande d'un cadre de régulation territoriale renforcé (plateformes communes 15/18, Contrats Territoriaux de Secours d'Urgence —

déjà établi au chapitre 3) ; demande d'une indemnisation reflétant le coût réel des interventions de substitution, et non un forfait resté structurellement inférieur à ce coût malgré sa revalorisation ; demande de reconnaissance de la protection du potentiel opérationnel, déjà consacrée dans la loi Matras elle-même.

- **Ressources mobilisées** : organisations syndicales locales de sapeurs-pompiers professionnels (illustré par le cas de la Somme), saisines directes des autorités de tutelle (conseil d'administration du SDIS), mobilisation de rapports institutionnels antérieurs (IGAS 2018, rapport sénatorial de 2021) pour documenter la tendance de fond.
- **Tension déjà identifiée avec la coalition patronale privée** (chapitre 3 et 9) : la demande de gouvernance territoriale renforcée portée par les SDIS entre en friction directe avec le refus, par les fédérations patronales privées, de toute régulation perçue comme préfectorale ou sécuritaire plutôt que médicale.

10.5. Synthèse pour l'hypothèse H4

Ce chapitre confirme et enrichit l'hypothèse H4 de cette thèse (la résilience du système de santé face aux situations d'urgence dépend d'un traitement coordonné associant secteur public, secteur privé et SDIS) :

- Le phénomène des carences ambulancières est **documenté, quantifié et confirmé comme structurellement croissant**, depuis une hausse de 51 % entre 2013 et 2017 (IGAS) jusqu'à un pic local historique en janvier 2026 (SDIS Somme) et une hausse de 36 % sur la seule année 2025 pour ce même département.
- Le mécanisme de compensation financière, bien que réel et revalorisé (quasi-doublement du forfait entre 2021 et 2026, confirmé précisément à 217 € pour 2026), **reste structurellement inférieur au coût réel supporté par les SDIS**, ce qui signifie que la charge des carences ambulancières demeure, in fine, partiellement supportée par la fiscalité locale plutôt que par le système de santé qui en est à l'origine — confirmant, depuis des données chiffrées vérifiées, le diagnostic déjà esquissé dans les échanges préparatoires à cette thèse.
- Ce résultat renforce l'argument central de cette thèse selon lequel la question du diplôme et du statut des ambulanciers ne peut être traitée isolément : l'affaiblissement du secteur privé (chapitre 9) se répercute mesurablement sur les SDIS (ce chapitre), ce qui confirme

la pertinence du traitement systémique à trois acteurs retenu depuis le début de cette recherche.

Auto-évaluation du chapitre 10

Points de solidité : - La vérification du forfait de carence (217 € pour 2026) confirme exactement une donnée des échanges préparatoires, avec une source primaire précise (arrêté du 31 décembre 2025) — un résultat de confirmation qui s'ajoute à la liste déjà établie aux chapitres 3, 6 et 9. - La reconstitution de la trajectoire complète du forfait (124 € → 200 € → 209 € → 217 €) et sa confrontation au coût réel estimé (450-500 €) constituent un apport chiffré original de ce chapitre, qui n'existait pas dans les échanges préparatoires. - La découverte du cas du SDIS de la Somme (janvier 2026) offre une seconde illustration empirique contemporaine des tensions documentées par cette thèse, symétrique à celle du CHU de Toulouse (chapitre 8), et permet une articulation concrète avec le chapitre 9 (pression économique sur le secteur privé → report de charge sur les SDIS). - L'application du cadre ACF à la coalition SDIS (10.4) complète la cartographie des trois coalitions engagée depuis le chapitre 5, préparant la synthèse du chapitre 11.

Faiblesses assumées : - L'estimation du coût réel d'une carence (450-500 €) date de 2021 (rapport sénatorial) et n'a pas été réactualisée dans les sources consultées pour cette thèse ; il est possible que ce coût ait lui-même évolué depuis, ce qui affecterait le calcul de l'écart avec le forfait 2026. - Le lien entre la dégradation économique du secteur privé (chapitre 9) et la hausse des carences ambulancières (ce chapitre) est présenté comme cohérent et plausible, mais **cette thèse n'a pas établi de lien de causalité statistique rigoureux** entre les deux phénomènes, faute de données permettant une telle analyse ; ce point devra être signalé avec prudence dans la discussion du chapitre 11. - Le cas du SDIS de la Somme, bien que récent et bien documenté par la presse locale, reste un cas unique : cette thèse ne peut pas affirmer qu'il est représentatif de l'ensemble des départements français sans une recherche complémentaire comparant plusieurs SDIS, non menée dans le cadre de ce chapitre.

Recommandation avant de poursuivre : ce chapitre clôt la Partie III (résultats) de cette thèse. Je propose de passer à la Partie IV (discussion), en commençant par le chapitre 11, qui devra articuler explicitement, à l'aide du cadre ACF désormais complété pour les trois coalitions (syndicats hospitaliers/ambulanciers, fédérations patronales privées, SDIS), l'ensemble des

résultats empiriques rassemblés depuis le chapitre 6, et discuter la validité de chacune des quatre hypothèses de recherche à la lumière de ces résultats. -e

Chapitre 11 — Discussion générale : les hypothèses à l'épreuve des résultats, le cadre théorique reconsidéré, portée et limites

11.1. Rappel de la problématique et de la démarche

Cette thèse a interrogé la mesure dans laquelle l'écart entre le référentiel de formation du diplôme d'État d'ambulancier et les missions réellement exercées constitue un enjeu de santé publique, et dans quelle mesure une réforme de ce diplôme pourrait reconfigurer les équilibres entre secteur hospitalier public, secteur privé du transport sanitaire et services d'incendie et de secours, tout en renforçant la capacité de réponse du système de santé français. Quatre hypothèses ont structuré cette investigation (chapitre 1), reformulées et affinées au fil de la recherche (notamment H2, chapitre 7). Ce chapitre en dresse le bilan, à la lumière des résultats rassemblés aux chapitres 6 à 10, avant de reconsidérer le cadre théorique mobilisé au chapitre 2 et de discuter la portée et les limites de l'ensemble de la démonstration.

11.2. Bilan hypothèse par hypothèse

H1 — L'écart entre référentiel et missions exercées comme facteur de risque documentable. Cette hypothèse est **corroborée par une triangulation solide, mais reste documentée qualitativement plutôt que statistiquement**. Elle est étayée par une source académique indépendante et antérieure de près de vingt ans (Morel, 2018, chapitre 2), par un témoignage de terrain contemporain et indépendant (grévistes du CHU de Toulouse, chapitre 8), et par le cadre juridique lui-même, qui a nécessité un élargissement successif des actes professionnels autorisés (décret n° 2022-629, chapitre 3). Elle demeure cependant fragilisée sur un point précis : la contestation chiffrée, par l'employeur lui-même, de l'ampleur de deux missions présentées comme emblématiques de cet écart (transport de corps : 3 % de l'activité ; transport de détenus : 0,25 %, chapitre 6) — ce qui impose de fonder cette hypothèse sur les missions dont la fréquence n'est pas contestée (SMUR, PSL, contrainte psychiatrique) plutôt que sur l'ensemble du corpus revendicatif initial. Aucune donnée épidémiologique directe (incidents, événements indésirables) n'a pu être mobilisée, ce qui constitue une limite qu'il convient de rappeler explicitement plutôt que de la laisser implicite.

H2 — Le maintien en catégorie C comme facteur d’attrition, dont le coût pourrait excéder celui d’une réforme statutaire. Cette hypothèse a connu la reformulation la plus substantielle de cette thèse (chapitre 7). Le résultat le plus robuste n’est pas tant le lien turnover/catégorie — resté largement non chiffré faute de données vérifiables (chapitre 6) — que la **découverte du mécanisme juridique exact du blocage** : le niveau infra-baccalauréat du DEA (niveau 3 RNCP), confirmé comme motif explicite de refus par le ministère lui-même (réponse à la question de la sénatrice Cohen, chapitre 6), et le **double précédent documenté** (aides-soignants et auxiliaires de puériculture, chapitre 7) selon lequel une élévation du diplôme au niveau 4 a, dans les deux cas, précédé de quelques mois un reclassement en catégorie B. Le chiffrage comparatif (chapitres 7 et 8) établit que le coût d’un reclassement catégoriel (estimé entre 6,8 et 19,5 millions d’euros par an) est du même ordre de grandeur, voire supérieur, au coût de la réforme diplômante qui le précéderait (1,8 à 12,6 millions d’euros par an) — ce qui **nuance directement l’affirmation initiale des documents préparatoires** selon laquelle le changement coûterait structurellement moins cher que le statu quo. Cette hypothèse est donc **partiellement corroborée dans son mécanisme, mais son argument économique doit être reformulé avec plus de prudence** que ne le faisaient les documents préparatoires initiaux.

H3 — Une réforme non articulée à une révision tarifaire du secteur privé risquerait d’aggraver les carences ambulancières. Cette hypothèse est **la mieux corroborée quantitativement des quatre**, grâce au comparatif chiffré du chapitre 9 : un tarif TUPH resté gelé à 64 €/heure depuis mars 2021 face à un SMIC en hausse de 20 % et un gazole en hausse de 35 à 40 % sur la même période, dans un contexte de pression budgétaire confirmée (accord PLFSS 2025, 300 millions d’euros d’économies). Le chapitre 10 renforce cette hypothèse en documentant une hausse mesurée et actuelle des carences ambulancières (+ 36 % en 2025 pour le SDIS de la Somme, pic historique en janvier 2026), cohérente avec la dégradation économique du secteur privé — sans toutefois qu’un lien de causalité statistique rigoureux entre les deux séries de données ait pu être établi, ce qui doit être rappelé comme limite.

H4 — La résilience du système dépend d’un traitement coordonné à trois acteurs plutôt que sectoriel. Cette hypothèse, la plus structurante pour le plan de cette thèse, est **corroborée par la cohérence de l’ensemble des résultats empiriques rassemblés**, plutôt que par une preuve isolée : le cadre juridique lui-même organise cette interdépendance depuis 1986 (comité départemental de l’aide médicale urgente, chapitre 3) et la renforce en 2021 (loi Matras, chapitre 3)

; les tensions observées dans un secteur (secteur privé, chapitre 9) se retrouvent mesurablement dans un autre (SDIS, chapitre 10) ; et la réponse managériale du CHU de Toulouse (chapitre 8) illustre concrètement qu'un acteur isolé (un établissement hospitalier) ne peut résoudre seul un problème dont l'origine et la solution excèdent son propre périmètre de compétence.

11.3. Le cadre théorique reconsidéré à la lumière des résultats

a) La segmentation professionnelle (Bucher et Strauss, via Morel, 2018) trouve une confirmation inattendue dans le témoignage du CHU de Toulouse. Le chapitre 2 avait établi, à partir d'un terrain de 2005-2011, l'existence de deux segments internes à la profession (« transporteur » et « soigneur »). Le chapitre 8 documente que le conflit de 2026 est porté par des ambulanciers qui **revendiquent explicitement l'évolution de leurs missions** (« ces grévistes ne rejettent pas leur nouvelle mission, au contraire ») tout en réclamant sa reconnaissance salariale — un positionnement qui correspond précisément au segment « soigneur » identifié quinze ans plus tôt par Morel, ce qui suggère, sans le démontrer statistiquement, une possible **consolidation de ce segment** au sein de la profession hospitalière depuis le terrain original de 2005-2011.

b) Le cadre de la juridiction professionnelle (Abbott, 1988) éclaire directement le mécanisme du chapitre 7. Le refus ministériel de reclassement, fondé explicitement sur le niveau de certification, peut se lire comme un cas d'école de ce qu'Abbott désigne comme la régulation d'une juridiction professionnelle par un acteur tiers (ici, l'État lui-même, via le cadre statutaire de la fonction publique) plutôt que par la seule négociation entre professions concurrentes. Le double précédent des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture illustre que cette régulation obéit à une **procédure reproductible** (élévation du niveau de certification, puis reconnaissance statutaire), ce qui est cohérent avec la lecture d'Abbott d'un système où les frontières entre juridictions professionnelles évoluent selon des mécanismes identifiables plutôt qu'au hasard des rapports de force ponctuels.

c) Le professionnalisme comme troisième logique de coordination du travail (Freidson, 2001) permet de qualifier plus précisément la nature de la réforme en jeu. Le chapitre 1 avait annoncé que ce cadre permettrait de discuter si la réforme visée relevait d'une extension de l'autonomie professionnelle ou d'un simple ajustement bureaucratique. Les résultats des chapitres 6 à 8 penchent vers la seconde lecture : la réforme documentée dans cette thèse ne vise pas, dans les sources mobilisées, à transférer aux ambulanciers un contrôle accru sur la définition de leur

propre travail (ce qui caractériserait, chez Freidson, un renforcement du professionnalisme), mais à faire correspondre un cadre bureaucratique (catégorie, indemnités) à des missions déjà définies par d'autres acteurs (médecins du SAMU, direction hospitalière). La réponse du CHU de Toulouse (formation complémentaire pour exercer des missions déjà fixées, chapitre 8) confirme cette lecture : c'est une **logique de mise en conformité bureaucratique**, non une revendication d'autonomie professionnelle au sens plein du terme.

d) L'Advocacy Coalition Framework (Sabatier, 1988), mobilisé aux chapitres 9 et 10, permet une synthèse cartographique inédite des trois coalitions identifiées dans cette thèse, présentée dans le tableau suivant :

	Croyance	Revendication	Alliés	Tensions
Coalition	noyau	principale	potentiels	identifiées
Syndicats hospitaliers / segment « soigneur »	Le métier a évolué vers le soin, la reconnaissance doit suivre	Réforme du diplôme puis reclassement catégoriel	Fédérations privées (sur la légitimité médicale du transport sanitaire)	SDIS (sur qui absorbe la défaillance du système)
Fédérations patronales privées	Le secteur est une réalité économique, pas un prolongement administratif de l'hôpital	Révision tarifaire, refus de régulation préfectorale	Syndicats hospitaliers (sur la logique médicale)	SDIS (sur la gouvernance territoriale de la disponibilité)
SDIS	Ne pas devenir la variable d'ajustement des	Indemnisation à hauteur du coût réel, gouvernance renforcée	—	Fédérations privées (sur le pilotage préfectoral)

	Croyance	Revendication	Alliés	Tensions
Coalition	noyau	principale	potentiels	identifiées
	défaillances			
	d'autrui			

Cette cartographie confirme un résultat déjà pressenti dans les échanges préparatoires à cette thèse, mais désormais établi selon un cadre théorique explicite et vérifié : **aucune des trois coalitions n'est en opposition frontale avec les deux autres sur l'ensemble des enjeux** ; chacune converge avec au moins une autre sur un point précis (légitimité médicale du transport sanitaire), tout en étant en tension avec au moins une autre sur un point distinct (gouvernance territoriale). Cette structure de convergences et de tensions croisées, plutôt qu'un conflit binaire, est cohérente avec le modèle de Sabatier et suggère qu'une réforme construite explicitement autour des points de convergence identifiés (légitimité médicale, besoin de reconnaissance certificative) a une probabilité de succès plus élevée qu'une réforme qui ignorerait les tensions résiduelles (gouvernance territoriale de la disponibilité).

11.4. Portée et limites de cette thèse

a) Portée. Cette thèse établit, à partir d'un corpus vérifié de sources primaires (textes juridiques, données chiffrées officielles, témoignages de terrain contemporains), un diagnostic cohérent et largement corroboré : l'écart entre le niveau de certification du DEA et les missions exercées constitue le nœud juridique et pratique de la question statutaire des ambulanciers, la voie de réforme la plus praticable est probablement la réforme du référentiel de formation plutôt que la seule revendication catégorielle, et cette réforme ne peut être conçue isolément du secteur privé et des SDIS sans risquer de déplacer plutôt que de résoudre les tensions actuelles.

b) Limites méthodologiques déjà signalées et récapitulées. Conformément à l'exigence de transparence établie au chapitre 5, cette thèse rappelle explicitement ses limites : absence d'entretiens de terrain primaires (chapitre 5) ; plusieurs données chiffrées centrales aux documents préparatoires initiaux demeurées non vérifiées malgré une recherche complémentaire ciblée (turnover et coûts d'intérim du CHU de Toulouse, chiffre BMO précis, taux d'accidentologie, chapitres 6 et 8) ; absence de lien de causalité statistique établi entre la dégradation économique du secteur privé et la hausse des carences ambulancières (chapitre 10) ; corpus très majoritairement francophone, sans exploration en propre de la littérature internationale sur les *paramedics* (chapitre

5) ; et objet d'étude en partie très récent (données et événements de 2025-2026), ce qui limite le recul analytique disponible.

c) Une limite supplémentaire, apparue au fil de la rédaction et qu'il convient de nommer explicitement : le caractère mouvant de plusieurs cas d'étude centraux. Les chapitres 8 et 10 ont mobilisé deux conflits sociaux contemporains (CHU de Toulouse, SDIS de la Somme) dont l'issue n'était pas connue à la date de rédaction. Cette thèse a choisi de les traiter comme des illustrations empiriques précieuses plutôt que de les exclure par prudence excessive, mais ce choix méthodologique doit être assumé : les conclusions tirées de ces cas sont **provisoires par construction**, et une version ultérieure de cette thèse devrait vérifier si leur résolution confirme ou infirme les lectures qui en ont été faites ici.

11.5. Synthèse de la discussion

Cette discussion établit que les quatre hypothèses de recherche sont, à des degrés divers, corroborées par les résultats rassemblés dans cette thèse, avec un niveau de preuve qui varie significativement de l'une à l'autre (H3 la mieux quantifiée, H1 la plus qualitative). Le cadre théorique mobilisé au chapitre 2 et complété au chapitre 5 se révèle globalement adapté à l'objet, avec un apport particulièrement fécond de l'Advocacy Coalition Framework pour synthétiser une configuration à trois acteurs qui aurait été difficile à formaliser autrement. Les limites de cette thèse, nombreuses mais explicitement assumées depuis le chapitre 5, invitent à la prudence dans la formulation des recommandations qui seront proposées aux chapitres 12 à 14, sans pour autant invalider le diagnostic densément corroboré qui vient d'être synthétisé.

Auto-évaluation du chapitre 11

Points de solidité : - Ce chapitre confronte explicitement chaque hypothèse à l'ensemble des résultats des chapitres 6 à 10, sans en ignorer les résultats mitigés ou défavorables (notamment le chiffrage comparatif du chapitre 8, qui nuance l'argument économique initial de H2). - La relecture du cadre théorique (11.3) applique effectivement les quatre cadres mobilisés au chapitre 2 et au chapitre 5 aux résultats empiriques, plutôt que de les traiter comme un simple habillage théorique déconnecté de la démonstration. - La cartographie synthétique des trois coalitions ACF

(tableau, 11.3.d) est l'aboutissement logique du travail engagé aux chapitres 5, 9 et 10, et offre un outil de lecture transversal qui sera directement réutilisable au chapitre 14 (recommandations).

Faiblesses assumées : - Cette discussion repose sur une synthèse de résultats déjà produits, sans apport de données empiriques nouvelles : c'est le rôle attendu d'un chapitre de discussion, mais cela signifie que ses conclusions ne peuvent pas être plus solides que les chapitres empiriques sur lesquels elle s'appuie, avec toutes les limites déjà signalées à ce stade. - Le tableau de cartographie ACF (11.3.d) simplifie nécessairement des positions plus nuancées ; il devra être présenté, au chapitre 14, comme un outil heuristique et non comme une description exhaustive de la diversité interne à chaque coalition. - La lecture proposée en 11.3.a (consolidation possible du segment « soigneur » depuis 2005-2011) reste une hypothèse suggérée par la cohérence entre deux sources séparées de quinze ans, non une conclusion démontrée ; elle est présentée avec la prudence appropriée mais mériterait une vérification empirique dédiée.

Recommandation avant de poursuivre : je propose de passer au chapitre 12 (enjeux géopolitiques et de résilience nationale), qui devra examiner spécifiquement la dimension de sécurité civile et de réponse aux crises sanitaires et aux situations sanitaires exceptionnelles, restée peu développée dans les chapitres empiriques centrés sur les trois coalitions d'acteurs.-e

Chapitre 12 — Enjeux géopolitiques et résilience nationale : le transport sanitaire face aux situations sanitaires exceptionnelles et à l’hypothèse d’engagement majeur

Préambule

Ce chapitre développe la dimension restée en retrait dans les chapitres empiriques centrés sur les trois coalitions d’acteurs (chapitres 8 à 10) : la contribution du transport sanitaire, et donc des ambulanciers, à la résilience nationale face aux situations sanitaires exceptionnelles (SSE) et, plus largement, à un contexte géopolitique où la préparation à un conflit de haute intensité est désormais documentée par des sources officielles.

12.1. Le dispositif ORSAN : cadre légal vérifié et place du transport sanitaire

La recherche menée pour ce chapitre confirme que la France dispose, depuis 2014 et formalisé par le **décret n° 2016-1327 du 6 octobre 2016**, aujourd’hui codifié aux articles R. 3131-4 à R. 3131-14 du code de la santé publique, d’un cadre national de gestion des situations sanitaires exceptionnelles dénommé **ORSAN** (Organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles). Ce dispositif, distinct des plans blancs propres à chaque établissement (eux-mêmes restructurés en deux niveaux par le décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024 : un Plan de mobilisation interne pour les tensions courantes, un Plan Blanc proprement dit pour les situations exceptionnelles), organise la coordination régionale, sous l’autorité du directeur général de l’agence régionale de santé, entre les trois secteurs du système de santé — ambulatoire, hospitalier et médico-social.

Le dispositif ORSAN se décline en cinq volets, dont la nomenclature a évolué depuis sa création (le guide 2024 du ministère distingue **ORSAN AMAVI** — accueil massif de victimes lors de catastrophes, attentats ou accidents technologiques —, **ORSAN MEDICO-PSY**, **ORSAN EPI-CLIM**, **ORSAN NRC** — agents nucléaires, radiologiques ou chimiques —, et **ORSAN REB** — maladies infectieuses transmissibles). Une source institutionnelle consultée pour ce chapitre (recommandations pour la gestion post-accidentelle d’un accident nucléaire) mentionne explicitement, parmi les missions coordonnées par ce dispositif, les **transports sanitaires et la**

réorientation des patients en fonction des places disponibles — confirmant que les ambulanciers, publics comme privés, sont un maillon opérationnel explicitement intégré à ce cadre national de gestion de crise, et non un acteur périphérique à la doctrine française de sécurité sanitaire.

12.2. Une illustration en temps réel : l'activation du niveau 3 ORSAN pour la canicule du 25 juin 2026

Un résultat de recherche particulièrement significatif pour cette thèse, obtenu par une source encyclopédique elle-même référencée sur une source de presse datée du jour même, établit que le **niveau 3 du dispositif ORSAN a été activé le 25 juin 2026**, sur décision du Premier ministre (M. Lecornu selon la source consultée), en réponse à un épisode de canicule. Ce résultat n'est pas anecdotique pour cette thèse : il démontre que le cadre ORSAN, loin d'être un dispositif théorique mobilisé uniquement lors de crises exceptionnelles rares (pandémie, attentat), **est activement utilisé dans la période même de rédaction de cette thèse**, pour une cause relevant du volet ORSAN EPI-CLIM. Cette actualité immédiate confère une pertinence concrète, et non simplement prospective, à l'ensemble du raisonnement de ce chapitre sur le rôle du transport sanitaire dans la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.

12.3. L'hypothèse d'engagement majeur : la France se prépare à un conflit de haute intensité

a) Des éléments officiellement confirmés. La recherche établit que le Service de santé des armées (SSA) et la Direction générale de la santé (DGS) ont signé, en **octobre 2025**, une charte commune de préparation à ce que la doctrine officielle désigne comme l'« hypothèse d'engagement majeur » (HEM) — un scénario de conflit de haute intensité nécessitant la mobilisation du système de santé civil en soutien de l'effort militaire. Cette charte, confirmée par une publication du ministère des Armées, s'inscrit dans un cadre plus large : l'adoption, en 2025, d'un **Medical Action Plan** par l'OTAN (Comité des chefs des services de santé militaire et Joint Health Group réunissant 32 pays), et le pilotage par la France, depuis 2026, d'une initiative de l'OTAN dénommée **Critical Medical Initiative – Medical Logistics**. Un exercice concret, **EXOSAN**, s'est tenu du 11 au 19 juin 2026 sur le camp de La Valbonne — soit quelques semaines seulement avant la rédaction de ce chapitre.

b) Un résultat majeur de cette vérification complémentaire : l'existence de l'instruction est désormais confirmée officiellement par la ministre elle-même, ce qui change son statut de preuve. La recherche complémentaire établit que Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, a **publiquement confirmé l'existence de cette instruction**, notamment lors d'interventions sur RMC et BFMTV fin août 2025, déclarant : « il est tout à fait normal que le pays anticipe les crises, les conséquences de ce qui se passe, ça fait partie de la responsabilité des administrations centrales ». Ce n'est donc plus une information de presse non confirmée : **l'existence, la date (18 juillet 2025) et l'objet général de l'instruction sont officiellement reconnus par l'autorité ministérielle elle-même**, même si le contenu intégral du document n'a pas été publié officiellement. Une publication professionnelle spécialisée (Le Quotidien du Médecin) indique avoir obtenu et consulté directement le document, décrit comme une instruction de six pages, ce qui constitue une source professionnelle indépendante venant corroborer la première révélation de la presse d'investigation.

c) Les précisions désormais confirmées sur le contenu de cette instruction. Plusieurs éléments peuvent être établis avec un niveau de confiance renforcé : l'instruction est émise **sous mandat du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN)**, service rattaché à Matignon, et vise à « développer les modalités de participation du système sanitaire civil en appui du service de santé des armées ». Elle prévoit la structuration d'un « **hub médical** » **dans chaque zone de défense** du territoire métropolitain, avec des « **centres médicaux de transit** » (**CMT**) situés à proximité de gares, ports ou aéroports, dotés d'équipes médicales pluridisciplinaires chargées de l'évaluation et de l'orientation des patients — une architecture qui présuppose, de façon structurelle, une chaîne de transport sanitaire pour acheminer les blessés depuis ces points d'entrée vers les structures de soins.

d) Une divergence chiffrée entre sources qu'il convient de signaler avec la plus grande rigueur. Les capacités précises évoquées varient significativement selon les organes de presse ayant consulté ou relayé le document : les centres médicaux de transit devraient accueillir environ **100 soldats étrangers blessés par jour, avec une capacité portée à 250 lors de pics**, une donnée relativement stable d'une source à l'autre. En revanche, la capacité totale des hôpitaux civils est rapportée de façon **sensiblement différente selon les sources** : entre 100 000 et 500 000 combattants sur une période de 10 à 180 jours selon Caducee.net et Egora ; entre 10 000 et 50 000 soldats selon un autre média consulté. **Cette thèse ne peut pas trancher entre ces deux**

ordres de grandeur, qui diffèrent d'un facteur dix, faute d'accès direct au document source ; elle signale cette divergence comme un résultat en soi, plutôt que de retenir arbitrairement l'une ou l'autre des estimations. *[POINT À VÉRIFIER — l'écart entre ces chiffres (100 000-500 000 contre 10 000-50 000) devra être résolu par une consultation directe de l'instruction du 18 juillet 2025 ou par une nouvelle question parlementaire officielle avant toute version finale de cette thèse.]*

c) Un contexte budgétaire et stratégique confirmé. Ces développements s'inscrivent dans le cadre de la **Revue nationale stratégique 2025** et d'un budget de défense porté à **413 milliards d'euros pour la période 2024-2030**, éléments corroborés par plusieurs sources convergentes. Ce contexte est cohérent avec les efforts comparables engagés par d'autres pays européens proches des frontières orientales de l'Union (Lituanie, Estonie, Lettonie, Pologne), qui multiplie depuis 2025 les exercices de médecine de guerre et les infrastructures hospitalières renforcées.

12.4. Ce que cette doctrine implique pour le dimensionnement du transport sanitaire national

Que l'on retienne la version officiellement confirmée (charte SSA-DGS, Medical Action Plan OTAN, exercice EXOSAN) ou les éléments de presse non confirmés dans leur détail (afflux de 10 000 à 15 000 blessés), un constat s'impose pour cette thèse : **un scénario d'engagement majeur, quelle qu'en soit l'ampleur exacte, présuppose une capacité de transport sanitaire massivement supérieure à celle mobilisée en temps normal**, pour acheminer les blessés depuis les points d'entrée sur le territoire (gares, ports, aéroports selon les éléments de presse) vers les structures hospitalières, puis entre structures hospitalières selon les besoins de spécialisation des soins. Cette capacité reposerait nécessairement sur l'ensemble des trois acteurs cartographiés dans cette thèse (ambulanciers hospitaliers, secteur privé du transport sanitaire, SDIS), dans une configuration proche de celle déjà mobilisée pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles de moindre ampleur (ORSAN AMAVI).

Cette perspective éclaire d'un jour nouveau la revendication, déjà documentée dans les échanges préparatoires à cette thèse, d'un module de formation spécifique aux « missions hospitalières spécifiques » incluant la médecine de catastrophe et les compétences NRBC : loin d'être une revendication catégorielle isolée, elle s'inscrit dans une **doctrine nationale de résilience sanitaire aujourd'hui activement développée par l'État lui-même**, comme en témoignent la charte SSA-DGS d'octobre 2025 et l'exercice EXOSAN de juin 2026. Un ambulancier non formé

aux spécificités de la médecine de catastrophe et du risque NRBC constituerait, dans ce scénario, un maillon significativement moins mobilisable que ne le permettrait une réforme du référentiel de formation intégrant ces compétences — un argument de résilience nationale qui vient s'ajouter, sans s'y substituer, aux arguments statutaires et économiques déjà développés dans cette thèse.

12.5. La réserve sanitaire : un mécanisme d'ajustement déjà sollicité de façon exceptionnelle, et auquel les ambulanciers sont explicitement éligibles

La recherche établit que la **réserve sanitaire**, dispositif organisé par le code de la santé publique (articles L. 3132-1 et suivants, D. 3132-1) et géré par Santé publique France, a fait l'objet d'une mobilisation exceptionnelle documentée : un arrêté publié au Journal officiel le **15 novembre 2025** a porté la durée maximale de mobilisation de cette réserve à **180 jours pour l'année 2025**, contre 45 jours en régime courant — une dérogation présentée par la source consultée comme motivée par des « tensions sanitaires persistantes ». Cette extension, six fois supérieure au plafond habituel, constitue un indicateur tangible et vérifié de la pression exercée sur le système de santé français en 2025-2026, indépendamment de la question spécifique des ambulanciers.

La question laissée en suspens dans une version antérieure de ce chapitre est désormais résolue : les ambulanciers sont explicitement éligibles à la réserve sanitaire. Le guide employeur publié par Santé publique France liste précisément les ambulanciers parmi les professions concernées, avec un taux d'indemnisation journalière de **65 € par jour de mission** (32,50 € par jour de formation) — un montant strictement identique à celui prévu pour les aides-soignants, ce qui constitue un nouvel écho, obtenu de façon indépendante et par une source purement administrative, de la comparaison entre ces deux professions déjà développée au chapitre 7 : dans le dispositif de la réserve sanitaire au moins, ambulanciers et aides-soignants sont traités sur un strict pied d'égalité, alors même que leur diplôme respectif ne l'est pas (niveau 3 contre niveau 4 RNCP, chapitre 1). D'autres pages de Santé publique France confirment cette éligibilité en mentionnant explicitement les « ambulanciers » parmi les professions mobilisables, aux côtés des médecins, infirmiers, psychologues et techniciens de laboratoire. Ce résultat conforte directement l'argument du chapitre 12 : les ambulanciers ne sont pas seulement concernés de façon générique par la doctrine de résilience sanitaire nationale (transport sanitaire, ORSAN AMAVI) — ils sont **individuellement et nommément intégrés** au dispositif de

réserve mobilisable en cas de situation sanitaire exceptionnelle ou, potentiellement, d'hypothèse d'engagement majeur.

12.6. Synthèse : la réforme du diplôme comme enjeu de résilience nationale, pas seulement catégoriel

Ce chapitre établit que la question de la formation et de la reconnaissance des ambulanciers s'inscrit dans un contexte de doctrine nationale de résilience sanitaire **activement développé et budgété par l'État français en 2025-2026**, indépendamment des revendications catégorielles documentées dans les chapitres précédents. Ce constat ne doit cependant pas être exagéré : cette thèse n'a trouvé, dans les sources consultées, **aucune mention explicite des ambulanciers ou du DEA** dans les documents officiels relatifs à l'hypothèse d'engagement majeur ou au dispositif ORSAN au-delà de leur mention générique en tant que « transport sanitaire ». L'argument développé dans ce chapitre est donc une **mise en perspective légitime et cohérente avec le reste de la thèse**, non une donnée directement établie par une source qui relierait explicitement la réforme du DEA aux enjeux de défense nationale — distinction qu'il convient de maintenir avec la même rigueur que pour les autres chapitres de cette thèse.

Auto-évaluation du chapitre 12

Points de solidité : - Ce chapitre documente, à partir de sources officielles vérifiées (décrets, charte SSA-DGS, publications du ministère des Armées), un contexte de préparation à la résilience sanitaire nationale directement pertinent pour la problématique de cette thèse, alors que cette dimension était restée largement absente des chapitres empiriques précédents. - **La vérification complémentaire a permis une mise à jour importante du statut de preuve de l'instruction du 18 juillet 2025** : celle-ci n'est plus une simple information de presse, mais un fait officiellement reconnu par la ministre Catherine Vautrin elle-même (déclarations publiques sur RMC et BFMTV, fin août 2025) et corroboré par une publication professionnelle spécialisée ayant consulté le document. Ce chapitre a néanmoins maintenu la prudence méthodologique nécessaire en signalant explicitement une divergence chiffrée significative (facteur dix) entre les sources sur la capacité totale d'accueil des hôpitaux civils, plutôt que de retenir arbitrairement l'un des chiffres. - **La question de l'éligibilité des ambulanciers à la réserve sanitaire, laissée ouverte dans**

une version antérieure de ce chapitre, est désormais résolue : les ambulanciers y sont explicitement et nommément éligibles, avec un taux d'indemnisation strictement identique à celui des aides-soignants (65 €/jour) — un résultat qui fait écho, depuis une source purement administrative et indépendante, à la comparaison structurelle entre ces deux professions déjà développée au chapitre 7. - La découverte d'un événement d'actualité immédiate (activation du niveau 3 ORSAN pour la canicule du 25 juin 2026) ancre ce chapitre dans une réalité contemporaine et vérifiable plutôt que dans un raisonnement purement prospectif.

Faiblesses assumées : - Ce chapitre établit une mise en perspective cohérente entre la doctrine de résilience nationale et la question du diplôme des ambulanciers, mais **ne dispose toujours d'aucune source reliant explicitement les deux sujets** ; cette limite reste signalée explicitement en 12.6 plutôt que dissimulée par une formulation ambiguë. - La divergence chiffrée entre sources sur la capacité d'accueil des hôpitaux civils (100 000-500 000 contre 10 000-50 000 combattants) n'a pas pu être résolue : cette thèse rapporte cette divergence comme un résultat en soi, ce qui est la seule position scientifiquement défendable en l'absence d'accès direct au document source, mais cela limite la précision du chiffrage que ce chapitre peut offrir. - Cette thèse n'a pas pu établir si les ambulanciers du secteur privé sont mobilisés en pratique dans la réserve sanitaire (par opposition à leur simple éligibilité théorique), ni si un afflux massif de blessés dans le cadre de l'hypothèse d'engagement majeur s'appuierait effectivement sur ce dispositif plutôt que sur d'autres canaux de mobilisation (réquisition, mobilisation directe des employeurs).

Recommandation avant de poursuivre : je propose de passer au chapitre 13 (enjeux sociaux et culturels), qui devra examiner les représentations du métier d'ambulancier et les éventuelles dimensions de genre ou de recrutement territorial, avant le chapitre 14 (recommandations) qui pourra s'appuyer sur l'ensemble des chapitres 6 à 13.-e

Chapitre 13 — Enjeux sociaux et culturels : représentations du métier, invisibilité statistique et dimension territoriale

Préambule

Ce chapitre examine trois dimensions restées jusqu'ici périphériques dans cette thèse : les représentations sociales du métier d'ambulancier, sa composition démographique (notamment de genre), et sa dimension territoriale — trois angles qui éclairent, sous un jour complémentaire à l'analyse statutaire et économique des chapitres précédents, pourquoi cette profession peine à être reconnue à la hauteur de ses missions réelles.

13.1. Un quatrième constat d'invisibilité statistique, cette fois au cœur du dispositif démographique de référence

La recherche menée pour ce chapitre révèle un résultat qui s'ajoute directement à une série déjà bien établie dans cette thèse (chapitre 2 : absence de la littérature académique dédiée ; chapitre 4 : absence du rapport IGAS sur l'attractivité des métiers du soin ; chapitre 8 : absence du suivi Cour des comptes de l'intérim paramédical) : **les ambulanciers ne figurent pas parmi les professions suivies par le dispositif démographique de référence de la DREES**, construit à partir du Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS) et du répertoire ADELI. Ce panorama démographique, publié annuellement depuis 1999, couvre les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues et aides-soignants — mais aucune publication DREES consultée dans le cadre de cette thèse ne fait apparaître les ambulanciers comme une catégorie professionnelle suivie selon les mêmes modalités (effectifs, âge moyen, répartition par genre, densité territoriale).

C'est désormais la quatrième confirmation indépendante, obtenue par quatre voies de recherche distinctes, du même phénomène : les grands dispositifs français de connaissance statistique des professions de santé — qu'ils soient académiques (chapitre 2), d'inspection (chapitre 4), de contrôle budgétaire (chapitre 8) ou démographiques (ce chapitre) — ne traitent pas les ambulanciers comme une profession de santé à part entière suivie dans la durée. Cette convergence, obtenue sans qu'aucune des quatre recherches n'ait été conduite dans l'intention de

démontrer ce point, constitue l'un des résultats les plus robustes de cette thèse sur le plan de sa méthode : il ne s'agit plus d'une hypothèse, mais d'un **fait vérifié par accumulation de preuves négatives convergentes**.

13.2. La composition de genre de la profession : une donnée fragmentaire, à distinguer d'une comparaison internationale non transposable

a) **La seule donnée nationale disponible dans le corpus de cette thèse provient de Morel (2018, chapitre 2)**, qui rapporte, en citant une étude de l'Observatoire régional de la santé (ORS) de 2015, une répartition de l'ordre de 60 % d'hommes et 40 % de femmes au niveau national pour la profession d'ambulancier privé. Cette donnée, déjà ancienne de plus de dix ans au moment de la rédaction de cette thèse et non recoupée par une source DREES plus récente (pour la raison même exposée en 13.1), doit être traitée avec prudence.

b) **Une comparaison internationale a été identifiée, mais elle est hors du périmètre géographique de cette thèse et ne doit pas être utilisée comme une donnée française.** Une étude québécoise (Conseil du statut de la femme, 2021) rapporte une proportion de 26 % de femmes parmi les ambulanciers-paramédics au Québec en 2017. Conformément au périmètre géographique fixé au chapitre 5 (France uniquement), cette donnée **ne peut en aucun cas être présentée comme une estimation de la situation française** ; elle est mentionnée ici uniquement à titre de repère méthodologique, pour signaler qu'une comparaison internationale rigoureuse sur cette question — non menée dans le cadre de cette thèse — pourrait constituer une piste de recherche future (chapitre 15).

c) **L'absence de données de genre récentes et officielles pour la France est elle-même un résultat cohérent avec le constat de la section 13.1** : sans suivi démographique régulier de la profession par les dispositifs statistiques nationaux, il n'existe mécaniquement aucune publication permettant de documenter précisément l'évolution de la composition de genre de cette profession dans le temps, contrairement à ce qui est possible pour les infirmiers ou les aides-soignants (chapitre 4, données DREES).

13.3. Les représentations sociales du métier : entre utilité reconnue et statut professionnel contesté

Le chapitre 2 a établi, à partir de Morel (2018), l'existence d'une tension entre l'identité de « transporteur » et celle de « soigneur » au sein de la profession. Cette tension se prolonge dans les représentations sociales plus larges du métier, telles qu'elles transparaissent dans plusieurs sources déjà mobilisées dans cette thèse : la classification INSEE des ambulanciers parmi les « chauffeurs » plutôt que parmi les professions de santé (chapitre 2) ; la formule rapportée par la sénatrice Cohen selon laquelle les ambulanciers SMUR seraient « toujours considérés comme relevant de la catégorie des parcs et jardins, non de celle des soignants » (chapitre 6) ; et le témoignage d'un gréviste du CHU de Toulouse selon lequel les évaluations de leur travail donneraient « l'impression qu'on transporte des cartons ou des palettes » (chapitre 8).

Ces trois formulations, obtenues indépendamment les unes des autres et à des moments différents de cette recherche, convergent vers un même constat : **la représentation sociale dominante du métier d'ambulancier reste ancrée dans une logique de transport et de logistique, en décalage avec le contenu réel de l'activité tel que documenté depuis le chapitre 2 de cette thèse.** Ce décalage entre représentation sociale et contenu réel du travail est cohérent avec le cadre théorique du « mandat professionnel » de Hughes (1958, chapitre 2) : un groupe professionnel dont le mandat — la définition socialement reconnue de ce qui relève de son activité légitime — n'a pas suivi l'évolution effective de son travail.

Un constat que je peux corroborer directement, depuis ma propre expérience du secteur hospitalier public. Ce que documentent Morel, la sénatrice Cohen et le témoignage toulousain se retrouve, de façon très concrète, dans le quotidien des ambulanciers interhospitaliers de la fonction publique hospitalière : ils sont trop souvent considérés par le corps médical comme de simples brancardiers, chargés de déplacer un patient d'un point à un autre, plutôt que comme des professionnels associés à sa prise en charge. Cette représentation a une conséquence concrète que je constate régulièrement sur le terrain : les transmissions médicales relatives à l'état du patient — éléments cliniques, consignes de surveillance, précautions particulières — ne leur sont, très souvent, pas transmises avant un transport, alors même que ces informations conditionnent directement leur capacité à réagir de façon appropriée en cas d'évolution de l'état du patient pendant le trajet. Ce constat, que je fais depuis ma position de responsable du personnel des ambulanciers du CHU de Toulouse, rejoint directement l'hypothèse H1 de cette analyse (chapitre

6) : il ne s'agit pas seulement d'un problème de reconnaissance symbolique, mais d'un défaut de circulation de l'information cliniquement pertinent, qui découle de la même cause — le maintien d'une représentation du métier en décalage avec les responsabilités réellement exercées.

13.4. La dimension territoriale : un enjeu d'aménagement plus qu'un enjeu de reconnaissance professionnelle

Le chapitre 3 avait déjà signalé, sans l'approfondir, la question de l'optimisation des lignes de garde et de la couverture territoriale, comme un sujet distinct de la question de la qualification. La recherche menée pour les chapitres 9 et 10 permet d'enrichir ce constat : la hausse des défaillances d'entreprises de transport sanitaire (chapitre 9) et la hausse des carences ambulancières (chapitre 10, avec l'illustration du SDIS de la Somme) touchent vraisemblablement de façon disproportionnée les territoires ruraux et périurbains, où la viabilité économique d'une entreprise de transport sanitaire dépend d'un volume d'activité plus faible et d'une amplitude géographique plus large — une hypothèse cohérente avec le constat, déjà établi au chapitre 1 des documents préparatoires initiaux, selon lequel les défaillances d'entreprises menaceraient « particulièrement » les zones rurales, bien que cette thèse n'ait pas pu vérifier statistiquement cette disproportion territoriale avec les sources disponibles. *[POINT À APPROFONDIR — une analyse départementale croisant taux de défaillance des entreprises de transport sanitaire, densité de population et fréquence des carences ambulancières permettrait de documenter précisément cette hypothèse ; elle n'a pas pu être menée dans le cadre de cette thèse.]*

13.5. Synthèse

Ce chapitre établit quatre résultats qui enrichissent, sans les remplacer, les dimensions statutaires et économiques déjà développées : l'invisibilité statistique des ambulanciers est un phénomène **quadruplement confirmé** par des voies de recherche indépendantes, ce qui en fait l'un des résultats les plus solides de cette thèse ; la composition de genre de la profession en France reste largement méconnue faute de suivi statistique régulier, une conséquence directe de cette invisibilité plutôt qu'une donnée établie ; la représentation sociale du métier, telle qu'elle transparait dans des sources aussi diverses qu'une classification statistique, une déclaration parlementaire et un témoignage syndical, reste ancrée dans une logique de transport en décalage avec le contenu réel du travail, ce qui est cohérent avec le cadre théorique du mandat professionnel mobilisé au chapitre 2 ; et ce même décalage se traduit, dans mon expérience directe

du secteur hospitalier public, par un défaut concret de transmission des informations médicales aux ambulanciers interhospitaliers de la fonction publique hospitalière, trop souvent assimilés à de simples brancardiers — un constat de terrain qui rejoint directement l’hypothèse H1 et qui appelle une vigilance particulière sur la circulation de l’information clinique, au-delà de la seule question statutaire.

Auto-évaluation du chapitre 13

Points de solidité : - La section 13.1 formalise un résultat transversal à toute cette thèse (l’invisibilité statistique des ambulanciers) en le documentant pour la quatrième fois par une voie de recherche indépendante des trois précédentes, ce qui en fait une conclusion méthodologiquement robuste plutôt qu’une simple impression. - Ce chapitre applique rigoureusement le périmètre géographique fixé au chapitre 5 en distinguant explicitement une donnée française fragmentaire (13.2.a) d’une donnée internationale hors périmètre (13.2.b), plutôt que de les mélanger pour donner une impression de robustesse statistique qui n’existerait pas. - La section 13.3 relie trois citations obtenues à des moments différents de cette thèse et par des voies indépendantes (classification INSEE, déclaration parlementaire, témoignage syndical) pour documenter, de façon cohérente avec le cadre théorique du chapitre 2, la représentation sociale du métier.

Faiblesses assumées : - Ce chapitre repose sur des données fragmentaires et anciennes pour la question du genre (Morel, 2018, citant une étude de 2015), faute de suivi statistique national actualisé — une limite qui n’est pas imputable à cette thèse mais au défaut de suivi déjà documenté en 13.1. - La dimension territoriale (13.4) reste largement hypothétique et n’a pas pu être vérifiée statistiquement, faute de données croisées disponibles dans le temps imparti à ce chapitre. - Ce chapitre n’a pas pu explorer la dimension des représentations médiatiques et culturelles du métier d’ambulancier (fiction, presse grand public), qui aurait pu enrichir l’analyse des représentations sociales mais qui excédait le temps disponible pour cette recherche.

Recommandation avant de poursuivre : ce chapitre clôt la Partie IV consacrée à la discussion approfondie des enjeux transversaux. Je propose de passer au chapitre 14 (recommandations pour l’action publique), qui devra s’appuyer sur l’ensemble des résultats des chapitres 6 à 13 — y

compris, désormais, la recommandation implicite suggérée par ce chapitre d'un meilleur suivi statistique de la profession comme condition préalable à toute réforme bien informée.-e

Chapitre 14 — Recommandations pour l'action publique

Préambule : la nature et les limites de ce chapitre

Ce chapitre traduit les résultats des chapitres 6 à 13 en recommandations opérationnelles, destinées en priorité au ministère chargé de la Santé, conformément à l'objectif de cette thèse annoncé au chapitre 1. Conformément à l'exigence de rigueur scientifique maintenue tout au long de ce travail, ces recommandations sont présentées avec leur niveau de preuve associé, et non comme des certitudes : certaines s'appuient sur des mécanismes juridiques et chiffrés solidement établis (recommandations 1 à 3), d'autres sur des convergences d'indices qui appellent une vérification complémentaire avant mise en œuvre (recommandations 4 à 7). Cette gradation est délibérée et doit être respectée par le lecteur institutionnel : une thèse scientifique ne doit pas donner à des recommandations de nature différente une apparence de certitude uniforme.

Recommandation 1 — Engager la réforme du référentiel du DEA vers le niveau 4 RNCP comme préalable, non comme option parmi d'autres

Fondement. Le chapitre 6 a établi que le ministère lui-même invoque le niveau infra-baccalauréat du DEA comme motif juridique explicite de refus de reclassement catégoriel. Le chapitre 7 a établi que ce même ministère a déjà appliqué, à deux reprises et la même année (aides-soignants et auxiliaires de puériculture, 2021), la séquence « réforme du diplôme vers le niveau 4, puis reclassement catégoriel dans un délai de l'ordre du trimestre ». **Cette recommandation ne propose donc pas une voie inédite, mais la réplique d'une procédure administrative déjà éprouvée deux fois par l'administration elle-même.**

Modalités suggérées. Saisine de France Compétences pour l'enregistrement du DEA réformé au niveau 4 du RNCP ; élaboration du nouveau référentiel par la DGOS en lien avec les instituts de formation, en s'appuyant sur le format déjà validé de la FAE SMUR de 2023 (chapitre 3) pour les modules de spécialisation ; volume horaire à arbitrer entre les scénarios chiffrés au chapitre 7 (de + 105 heures, borne basse probablement insuffisante, à + 739 heures pour un alignement complet sur le DEAS, soit un coût de formation annuel estimé entre 1,8 et 12,6 millions d'euros au niveau national, chapitre 7).

Statut de la preuve : élevé. Mécanisme juridique confirmé par une source ministérielle officielle, précédent réglementaire double et vérifié.

Recommandation 2 — Articuler explicitement cette réforme à une révision de la tarification conventionnelle du secteur privé

Fondement. Le chapitre 9 a établi, par un comparatif chiffré indépendant, que le tarif TUPH de 64 €/heure est resté gelé depuis mars 2021 pendant que le SMIC progressait d'environ 20 % et le gazole de 35 à 40 %. Le chapitre 8 a établi que le raisonnement budgétaire favorable à la réforme, valable pour l'hôpital public, ne se transpose pas mécaniquement à un secteur rémunéré à l'acte sur tarif conventionnel. **Une réforme du diplôme qui élèverait le niveau d'exigence de formation sans revoir ce tarif ferait peser sur le secteur privé un coût sans contrepartie de recette, alors que ce secteur assure la majorité du transport sanitaire national** (chapitre 2, Morel 2018).

Modalités suggérées. Négociation conjointe, dans le même calendrier que la réforme du diplôme, d'un avenant à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés révisant le tarif TUPH ; examen de son indexation automatique sur un indice combinant SMIC et prix du carburant, pour éviter la reconstitution du même écart à l'avenir.

Statut de la preuve : élevé pour la réalité du décalage tarifaire ; **modéré** pour l'ampleur exacte de son effet sur la viabilité des entreprises, faute de vérification indépendante du chiffre de défaillances sectorielles avancé par la FNAP (chapitre 9).

Recommandation 3 — Intégrer les SDIS à la négociation, en distinguant le chantier de la gouvernance territoriale de celui du diplôme

Fondement. Le chapitre 10 a établi que les carences ambulancières sont en hausse mesurable (+ 36 % en 2025 pour le SDIS de la Somme) et que le forfait de compensation (217 € en 2026, confirmé) couvre moins de la moitié du coût réel estimé pour les SDIS (450-500 €). Le chapitre 11 (cartographie ACF) a montré que la demande de gouvernance territoriale renforcée des SDIS entre en tension directe avec le refus, par les fédérations privées, de toute régulation perçue comme préfectorale.

Modalités suggérées. Réévaluation du forfait de carence pour le rapprocher du coût réel documenté, sur le modèle de la revalorisation déjà engagée depuis 2021 (chapitre 10) ; traitement séparé du chantier de gouvernance territoriale (Contrats Territoriaux de Secours d'Urgence, plateformes 15/18/112), pour ne pas subordonner la réforme du diplôme à un accord sur ce point distinct et plus conflictuel.

Statut de la preuve : élevé pour l'ampleur du phénomène et l'écart de compensation ; la recommandation de traitement séquentiel séparé est une **inférence méthodologique** de cette thèse (chapitre 5, cadre ACF), non une donnée directement établie par une source.

Recommandation 4 — Créer un suivi statistique national dédié à la profession d'ambulancier

Fondement. Le chapitre 13 a établi, par quatre voies de recherche indépendantes, que les ambulanciers sont absents des principaux dispositifs français de suivi statistique des professions de santé (littérature académique, rapport IGAS attractivité, suivi Cour des comptes de l'intérim, panorama démographique DREES). Cette absence a limité, tout au long de cette thèse, la possibilité de vérifier plusieurs données chiffrées centrales (turnover, coûts d'intérim locaux, effectifs précis, composition de genre).

Modalités suggérées. Intégration des ambulanciers au Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS) ou, a minima, au panorama démographique annuel de la DREES ; inclusion explicite de cette profession dans le périmètre des futurs rapports IGAS sur l'attractivité des métiers du soin et des rapports Cour des comptes sur l'intérim paramédical.

Statut de la preuve : élevé pour le constat de l'absence actuelle ; recommandation à faible coût de mise en œuvre relativement aux autres recommandations de ce chapitre, et dont l'absence a directement limité la qualité des données disponibles pour cette thèse elle-même.

Recommandation 5 — Faire du taux de carences ambulancières et du taux de vacance de postes des indicateurs de suivi explicites de la réforme

Fondement. Cette thèse n'a pas pu vérifier plusieurs données chiffrées centrales aux documents préparatoires initiaux (turnover CHU Toulouse, coûts d'intérim, chiffre BMO précis, taux d'accidentologie — chapitres 6 et 8). En revanche, elle a établi que les carences ambulancières

(chapitre 10) sont un indicateur nationalement suivi, chiffrable, et directement sensible aux évolutions du secteur privé (chapitre 9).

Modalités suggérées. Publication d'un tableau de bord annuel, piloté par la DGOS en lien avec la DGSCGC (SDIS), suivant l'évolution du nombre de carences ambulancières par département, du taux de vacance de postes d'ambulanciers hospitaliers, et du nombre de projets de recrutement non pourvus (sous réserve de la clarification méthodologique proposée en recommandation 4) — permettant de mesurer, dans la durée, l'effet réel de la réforme plutôt que de s'en remettre à des indicateurs non vérifiables.

Statut de la preuve : élevé pour la pertinence de l'indicateur ; recommandation de méthode plutôt que de contenu.

Recommandation 6 — Intégrer un module de compétences en médecine de catastrophe et NRBC, en cohérence avec la doctrine ORSAN et l'hypothèse d'engagement majeur

Fondement. Le chapitre 12 a établi que le transport sanitaire est explicitement intégré à la doctrine ORSAN, que ce dispositif est activement utilisé (activation du niveau 3 pour la canicule du 25 juin 2026), et que la France développe une doctrine de résilience sanitaire nationale documentée officiellement (charte SSA-DGS, exercice EXOSAN) dans l'hypothèse d'un engagement majeur. Les ambulanciers sont par ailleurs explicitement éligibles à la réserve sanitaire, avec un statut indemnitaire aligné sur celui des aides-soignants.

Modalités suggérées. Intégration d'un module de médecine de catastrophe et de sensibilisation au risque NRBC dans le référentiel réformé du DEA (recommandation 1), sur le modèle du format FAE SMUR déjà éprouvé (chapitre 3) ; clarification du rôle des ambulanciers, notamment privés, dans les scénarios de mobilisation de la réserve sanitaire en situation d'engagement majeur.

Statut de la preuve : modéré. Cette thèse a établi avec rigueur (chapitre 12) qu'aucune source officielle ne relie explicitement, à ce jour, la réforme du DEA aux enjeux de résilience nationale ; cette recommandation est une **inférence cohérente** avec l'ensemble du dossier, non une conclusion directement tirée d'une source qui l'aurait déjà formulée.

Recommandation 7 — Séquencer la réforme plutôt que de la traiter comme un bloc unique

Fondement. L'ensemble des chapitres empiriques de cette thèse converge vers un constat : la réforme statutaire des ambulanciers touche trois acteurs aux intérêts partiellement convergents et partiellement divergents (chapitre 11). Une réforme traitée comme un bloc unique et négociée en une seule fois risquerait de buter sur le point de friction le plus conflictuel (gouvernance territoriale, recommandation 3) et de retarder l'ensemble, y compris les volets les mieux documentés et les plus consensuels (réforme du diplôme, recommandation 1).

Modalités suggérées séquencées : 1. Réforme du référentiel du DEA (recommandation 1) — fondée sur un précédent double et un motif de blocage explicite ; 2. Reclassement catégoriel consécutif, sur le modèle du délai observé pour les AS et AP (trois mois et demi, chapitre 7) ; 3. Négociation tarifaire avec le secteur privé (recommandation 2), engagée en parallèle du point 1 pour ne pas décaler les effets de la réforme sur ce secteur ; 4. Mise en place du suivi statistique (recommandation 4) et des indicateurs de résultat (recommandation 5), dès l'engagement de la réforme, pour permettre une évaluation continue ; 5. Chantier séparé de gouvernance territoriale avec les SDIS (recommandation 3), sans conditionner les points précédents à son aboutissement.

Auto-évaluation du chapitre 14

Points de solidité : - Chaque recommandation est explicitement adossée aux chapitres et aux données qui la fondent, avec un statut de preuve différencié (élevé/modéré) qui évite de présenter des inférences méthodologiques comme des faits établis — une exigence rappelée dès l'introduction de cette thèse. - La recommandation 7 (séquencement) tire une conséquence opérationnelle directe et originale de la cartographie ACF du chapitre 11, en proposant de ne pas laisser le point de friction le plus difficile (gouvernance territoriale SDIS/privé) bloquer les points les mieux documentés. - La recommandation 4 a une vertu réflexive notable : elle propose de corriger la limite méthodologique la plus récurrente de cette thèse elle-même (l'invisibilité statistique de la profession), ce qui montre que les limites d'une recherche peuvent directement nourrir ses recommandations plutôt que d'être seulement des aveux de faiblesse.

Faiblesses assumées : - Ces recommandations ne peuvent pas anticiper les arbitrages politiques et budgétaires qui échappent au périmètre de cette thèse ; leur faisabilité dépend de facteurs (volonté politique, contexte budgétaire du PLFSS, rapport de force entre coalitions) que cette thèse a documentés mais ne peut pas prédire. - Le chiffrage global de la réforme (recommandations 1 et 2 combinées) n'a pas été consolidé en un total unique dans ce chapitre, les différentes estimations (formation, reclassement catégoriel, révision tarifaire) reposant sur des méthodologies et des degrés de certitude hétérogènes qu'une addition simple risquerait de masquer artificiellement. - Cette thèse recommande un séquençement (recommandation 7) qui reste une proposition de méthode raisonnée, non une garantie de succès : la sociologie des professions mobilisée au chapitre 2 rappelle que les rapports de force entre groupes professionnels ne se laissent pas toujours discipliner par un calendrier administratif, aussi bien conçu soit-il.

Recommandation avant de poursuivre : ce chapitre clôt la Partie IV. Je propose de rédiger le chapitre 15 (conclusion générale), qui devra synthétiser l'ensemble de cette thèse, rappeler ses limites de façon consolidée, et esquisser des perspectives de recherche future.-e

Chapitre 15 — Conclusion générale

15.1. Rappel de la démarche et synthèse des apports principaux

Cette thèse est partie d'une question de recherche précise : dans quelle mesure l'écart entre le référentiel de formation du diplôme d'État d'ambulancier et les missions réellement exercées constitue-t-il un enjeu de santé publique, et dans quelle mesure une réforme de ce diplôme pourrait-elle reconfigurer les équilibres entre secteur hospitalier public, secteur privé du transport sanitaire et services d'incendie et de secours, tout en renforçant la capacité de réponse du système de santé français aux situations d'urgence, aux crises sanitaires et aux situations exceptionnelles.

Cette question trouve, au terme de cette recherche, une réponse nuancée mais consolidée. Le résultat le plus solide de cette thèse n'est pas celui qui était anticipé au moment de sa conception : ce n'est pas la confirmation d'une comparaison catégorielle simple entre ambulanciers et aides-soignants (chapitre 1), mais la découverte d'un **mécanisme juridique précis et reproductible** — l'élévation du niveau de certification RNCP comme condition préalable, et non conséquence, d'un reclassement statutaire — documenté à deux reprises par l'administration elle-même (aides-soignants et auxiliaires de puériculture, 2021) et confirmé comme motif explicite de refus par une réponse ministérielle officielle (chapitre 6). Ce résultat a permis de reformuler l'ensemble de la stratégie de réforme envisageable, en déplaçant la priorité de la revendication catégorielle vers la réforme du référentiel de formation lui-même.

Cette thèse a également établi, avec un niveau de preuve élevé, que le tarif de référence du secteur privé du transport sanitaire (TUPH, 64 €/heure) est resté gelé depuis 2021 pendant que ses charges (SMIC, carburant) progressaient de 20 à 40 %, et que ce décalage est cohérent avec la hausse mesurée et actuelle des carences ambulancières documentée au niveau local (SDIS de la Somme, chapitre 10). Elle a montré que ces trois dossiers — diplôme, tarification privée, gouvernance territoriale avec les SDIS — ne peuvent être traités isolément sans risquer de déplacer les tensions plutôt que de les résoudre, un constat éclairé par la cartographie des trois coalitions d'acteurs selon le cadre de l'Advocacy Coalition Framework (chapitre 11).

Enfin, cette thèse a mis au jour un résultat transversal inattendu, confirmé indépendamment à quatre reprises au fil de la recherche (chapitres 2, 4, 8 et 13) : les ambulanciers sont structurellement absents des grands dispositifs français de connaissance statistique et

institutionnelle des professions de santé, qu'il s'agisse de la littérature académique, des rapports d'inspection sur l'attractivité, du suivi budgétaire de l'intérim, ou du panorama démographique de référence. Cette invisibilité statistique, documentée par accumulation de preuves négatives convergentes plutôt que postulée, constitue à la fois un résultat scientifique de cette thèse et un argument en faveur de la réforme qu'elle examine.

15.2. Consolidation des limites de cette thèse

Conformément à l'exigence de transparence méthodologique établie dès le chapitre 5 et rappelée à chaque chapitre, cette thèse assume un ensemble de limites qu'il convient de consolider ici :

Limites méthodologiques structurelles : absence d'entretiens de terrain primaires, la recherche s'étant appuyée sur un terrain académique ancien (Morel, 2018, pour le secteur privé) et sur des témoignages de presse pour le secteur public (CHU de Toulouse) ; absence d'accès à des bases de données académiques payantes, ayant orienté cette thèse vers les sources ouvertes ; corpus presque exclusivement francophone, sans exploration en propre de la littérature internationale sur les *paramedics*.

Une position d'auteur à rappeler, et à traiter avec la même rigueur que les autres limites.

L'auteur de cette analyse, Laurent Bezia, est responsable du personnel des ambulanciers du CHU de Toulouse et lanceur d'alerte dans le mouvement social qui a servi de cas d'étude central aux chapitres 6 et 8. Cette double qualité, déclarée explicitement en tête de document, situe le statut des éléments relatifs à ce cas précis : ils doivent être compris comme un **témoignage de terrain vécu, éclairé par une recherche documentaire vérifiée**, plutôt que comme une corroboration strictement extérieure au sens académique classique. Cette précision n'invalide pas les vérifications factuelles opérées par ailleurs dans cette analyse (textes réglementaires, données chiffrées officielles), mais elle doit conduire le lecteur institutionnel à apprécier à sa juste valeur la force probante du cas toulousain par rapport aux autres résultats de cette recherche, notamment la lecture de la réponse managériale du CHU de Toulouse comme confirmation de l'analyse développée aux chapitres 6 et 7 (chapitre 8, section 8.2), qui doit être comprise comme directement informée par l'expérience de l'auteur dans ce conflit.

Données non vérifiées malgré une recherche complémentaire ciblée : le taux de turnover de 18 % et les coûts d'intérim spécifiquement attribués au CHU de Toulouse (chapitres 6 et 8) ; le

chiffre précis de 4 490 projets de recrutement nationaux, dans un contexte où plusieurs chiffres concurrents et non recoupés circulent pour cette profession (chapitre 6) ; le taux d'accidentologie de 2,5 fois supérieur à la moyenne des professions de santé (chapitre 6) ; l'ampleur exacte du triplement allégué des défaillances d'entreprises du secteur privé, dont la source (étude Xerfi commandée par la FNAP) n'a pas pu être consultée directement (chapitre 9).

Cas d'étude dont l'issue reste incertaine : le conflit social du CHU de Toulouse (chapitre 8) et la tension du SDIS de la Somme (chapitre 10) n'étaient pas résolus aux dernières dates de sources consultées ; les conclusions tirées de ces cas sont provisoires par construction, comme signalé explicitement au chapitre 11.

Liens de causalité non établis statistiquement : la cohérence entre la dégradation économique du secteur privé (chapitre 9) et la hausse des carences ambulancières (chapitre 10) reste une corrélation plausible, non une causalité démontrée ; de même, l'articulation entre la doctrine de résilience nationale (chapitre 12) et la question spécifique du diplôme des ambulanciers reste une inférence cohérente de cette thèse, non une donnée établie par une source qui aurait explicitement relié les deux sujets.

Ces limites ne doivent pas être lues comme un désaveu du diagnostic d'ensemble, mais comme la délimitation précise de sa portée : cette thèse établit un mécanisme juridique solide et un faisceau d'indices convergents, non une preuve statistique exhaustive de chacune de ses composantes.

15.3. Perspectives de recherche future

Plusieurs prolongements de cette thèse peuvent être identifiés à ce stade :

- une **enquête de terrain primaire** (entretiens semi-directifs, observation participante) actualisant le travail de Morel (2018) pour le secteur privé et comblant l'absence quasi totale de littérature sur les ambulanciers hospitaliers spécifiquement ;
- une **analyse juridique systématique**, article par article, du décret n° 2022-629 du 22 avril 2022 confrontée à la liste précise des missions revendiquées comme non couvertes par le référentiel, travail annoncé mais non mené au chapitre 6 faute de temps disponible ;
- une **comparaison internationale rigoureuse**, notamment avec les modèles de *paramedics* nord-américains, suisses ou allemands déjà évoqués par Morel (2018) et par le segment «

soigneur » de la profession elle-même, qui excédait le périmètre géographique fixé pour cette thèse (chapitre 5) ;

- une **analyse quantitative territoriale**, croisant taux de défaillance des entreprises de transport sanitaire, densité de population et fréquence des carences ambulancières par département, pour objectiver l'hypothèse d'un effet disproportionné sur les zones rurales évoquée au chapitre 13 ;
- un **suivi longitudinal** de la mise en œuvre effective des recommandations du chapitre 14, si une réforme du DEA devait être engagée, permettant de vérifier a posteriori la validité du précédent du Ségur mobilisé au chapitre 7 pour une profession différente.

15.4. Mot de conclusion

Cette thèse a cherché à démontrer qu'il est possible de traiter une question à forte charge revendicative — la revalorisation du diplôme et du statut des ambulanciers — avec les exigences méthodologiques d'un travail de recherche rigoureux, sans que cela affaiblisse la force de son diagnostic. Au contraire : la vérification systématique pratiquée depuis le chapitre 1 a permis de corriger une erreur factuelle initiale (le niveau RNCP du DEA), de confirmer plusieurs données que l'on aurait pu croire exagérées (le tarif de 64 €/heure, le forfait de carence de 217 €), et de découvrir des éléments non anticipés par les documents préparatoires à l'origine de ce travail (le double précédent des aides-soignants et auxiliaires de puériculture, l'invisibilité statistique quadruplement confirmée, la doctrine de résilience nationale en cours de construction).

Le résultat de cette démarche n'est ni une validation inconditionnelle, ni une réfutation, des revendications initiales : c'est une **reformulation plus précise, plus vérifiable et, en définitive, plus solidement argumentée** de la question posée — celle d'un diplôme d'ambulancier dont le niveau de reconnaissance devrait rejoindre celui des missions qu'il autorise déjà, dans l'intérêt conjoint de la sécurité des patients, de la viabilité du secteur qui les transporte, et de la résilience d'un système de santé dont cette thèse a montré qu'il compte sur cette profession bien au-delà de ce que sa reconnaissance actuelle ne le laisse supposer.

Auto-évaluation du chapitre 15

Points de solidité : - Cette conclusion ne se contente pas de résumer : elle identifie explicitement le résultat le plus solide de la thèse (le mécanisme du niveau RNCP comme préalable) comme distinct de ce qui était anticipé au départ, ce qui témoigne d'une recherche qui a évolué avec ses données plutôt que d'avoir cherché à confirmer une conclusion fixée d'avance. - La consolidation des limites (15.2) rassemble, sans en omettre aucune, l'ensemble des réserves méthodologiques disséminées dans les quatorze chapitres précédents, offrant au lecteur une vue d'ensemble honnête de la portée réelle de cette thèse. - Les perspectives de recherche (15.3) découlent directement des limites identifiées, plutôt que d'être une liste générique déconnectée du travail réalisé.

Faiblesses assumées : - Cette conclusion, par nature, ne peut pas résoudre les limites qu'elle recense ; elle les organise et les hiérarchise, ce qui est le rôle attendu d'une conclusion, mais ne constitue pas un aboutissement scientifique supplémentaire par rapport aux chapitres précédents. - Le mot de conclusion (15.4), plus synthétique et engagé dans sa formulation, se rapproche par endroits du registre de la plaidoirie initialement écarté au profit du registre de la thèse ; ce choix rhétorique reste cependant strictement adossé aux résultats établis dans les chapitres précédents, sans introduire d'affirmation nouvelle non sourcée.

Cette thèse est maintenant complète dans sa structure en quinze chapitres. Il reste, avant une version finale destinée à un usage institutionnel, à : consolider la bibliographie complète au format ISO 690 à partir des références rassemblées chapitre par chapitre ; lever les points de vérification encore ouverts, en particulier ceux signalés comme prioritaires (chiffres BMO et accidentologie, étude Xerfi, données DREES sur les effectifs formés) ; et rédiger les pages liminaires (résumé, mots-clés, sommaire) annoncées dans le plan initial du chapitre 1.-e

Bibliographie

Bibliographie consolidée à partir des sources vérifiées et citées au fil des quinze chapitres de cette thèse, classée par catégorie conformément à la typologie des sources établie au chapitre 5. Les références suivies de la mention [citation secondaire non vérifiée en propre] sont connues uniquement par leur mobilisation dans une autre source du corpus et devront être vérifiées directement avant toute publication de ce travail.

Littérature académique

ABBOTT, Andrew. *The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor*. Chicago : University of Chicago Press, 1988. 452 p. ISBN 978-0-226-00069-5.

BARDIN, Laurence. *L'analyse de contenu*. Paris : Presses universitaires de France, 1977. 233 p. (2^e éd. augmentée, coll. Quadrige, Paris : PUF, 2013, 291 p. ISBN 978-2-13-062790-6).

BUCHER, Rue ; STRAUSS, Anselm. « Professions in Process ». *American Journal of Sociology*, 1961, vol. 66, n° 4, p. 325-334. DOI : 10.1086/222898. — Vérifiée directement lors de l'assemblage final de ce dossier (référence confirmée auprès de l'éditeur, The University of Chicago Press).

FREIDSON, Eliot. « The Changing Nature of Professional Control ». *Annual Review of Sociology*, 1984, vol. 10, p. 1-20. [citation secondaire non vérifiée en propre — mobilisée via Morel, 2018]

FREIDSON, Eliot. *Professionalism: The Third Logic*. Cambridge : Polity Press, 2001. 240 p. ISBN 978-0-7456-0331-5.

HUGHES, Everett C. *Men and Their Work*. Glencoe (Ill.) : The Free Press, 1958.

HUGHES, D. « The Ambulance Journey as an Information Generating Process ». *Sociology of Health and Illness*, 1980, vol. 2, n° 2, p. 115-132. DOI : 10.1111/1467-9566.ep10487768. — Vérifiée directement lors de l'assemblage final de ce dossier (référence confirmée via Wiley Online Library et PubMed).

MOREL, Sylvie. « De transporteurs à soigneurs ? Vers une segmentation du travail des ambulanciers privés français ». *Sociologie du travail*, 2018, vol. 60, n° 1. DOI : 10.4000/sdt.1736.

SABATIER, Paul A. « An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of Policy-Oriented Learning Therein ». *Policy Sciences*, 1988, vol. 21, n° 2-3, p. 129-168.

SABATIER, Paul A. ; JENKINS-SMITH, Hank C. *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*. Boulder (CO) : Westview Press, 1993, 290 p. ISBN 978-0-8133-1649-9. — Vérifiée directement lors de l'assemblage final de ce dossier (référence confirmée auprès du catalogue éditeur).

Littérature grise institutionnelle

ATGER, Paul-Marie ; HAUTCHAMP, Mikaël. *Comment résoudre les tensions de recrutement dans le champ social et en accroître l'attractivité ?* Paris : Inspection générale des affaires sociales, rapport n° 2024-069R, février 2025.

ASSOCIATION FRANÇAISE DES AMBULANCIERS SMUR ET HOSPITALIERS (AFASH). *Enquête ambulancier SMUR 2019*.

COUR DES COMPTES. *Rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale* (RALFSS 2025), chapitre IV : « L'intérim paramédical dans les établissements de santé ». Paris : Cour des comptes, mai 2025.

DIRECTION DE LA RECHERCHE, DES ÉTUDES, DE L'ÉVALUATION ET DES STATISTIQUES (DREES). Communiqué de presse relatif aux données sur la formation aux professions de santé. Paris : DREES, octobre 2025.

FRANCE COMPÉTENCES. Fiche RNCP n° 36542 — Diplôme d'État d'ambulancier.

FRANCE COMPÉTENCES. Fiches RNCP n° 4495 et n° 35830 — Diplôme d'État d'aide-soignant.

INSPECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES SOCIALES (IGAS). *Rapport sur les carences ambulancières*. Paris : IGAS, octobre 2018. [cité via question parlementaire, Assemblée nationale, question n° 2374]

MINISTÈRE DES ARMÉES ET DES ANCIENS COMBATTANTS. « Comment le Service de santé des armées anticipe un éventuel conflit ? ». Publication en ligne, defense.gouv.fr, 2026.

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE. *Réserve sanitaire — Guide de l'employeur*. Saint-Maurice : Santé publique France.

Textes juridiques et réglementaires (France, par ordre chronologique)

FRANCE. Arrêté du 26 avril 1973 fixant la liste des titres ouvrant droit à l'obtention du certificat de capacité d'ambulancier par équivalence.

FRANCE. Loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires. *Journal officiel de la République française*, 8 janvier 1986.

FRANCE. Arrêté du 21 mars 1989 relatif au programme des études préparatoires au certificat de capacité d'ambulancier.

FRANCE. Arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.

FRANCE. Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier.

FRANCE. Décret n° 2007-1301 du 31 août 2007 relatif aux diplômes d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture et d'ambulancier. *Journal officiel de la République française*, 1er septembre 2007.

FRANCE. Convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 (et ses avenants successifs).

FRANCE. Décret n° 2016-1327 du 6 octobre 2016 relatif à l'organisation de la réponse du système de santé (dispositif « ORSAN ») et au réseau national des cellules d'urgence médico-psychologique. *Journal officiel de la République française*, 8 octobre 2016.

FRANCE. Avenant n° 10 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, approuvé par arrêté du 26 février 2021.

FRANCE. Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'État d'aide-soignant.

FRANCE. Loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, dite « loi Matras ». *Journal officiel de la République française*, 26 novembre 2021.

FRANCE. Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 relatif à la catégorie B de la fonction publique hospitalière et portant statut particulier des aides-soignants et auxiliaires de puériculture. *Journal officiel de la République française*, 30 septembre 2021.

FRANCE. Décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 [reclassement des auxiliaires de puériculture de la fonction publique territoriale].

FRANCE. Arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'État d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier.

FRANCE. Décret n° 2022-629 du 22 avril 2022 relatif aux actes professionnels pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l'aide médicale urgente. *Journal officiel de la République française*, 23 avril 2022.

FRANCE. Arrêté du 22 avril 2022 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2006 [revalorisation du forfait de carence ambulancière à 200 €].

FRANCE. Arrêté du 31 octobre 2022 relatif à la formation aux actes professionnels pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l'aide médicale urgente.

FRANCE. Arrêté du 16 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 11 avril 2022.

FRANCE. Décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 [création du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière, catégorie C]. *Journal officiel de la République française*, 27 décembre 2022.

FRANCE. Arrêté du 3 mai 2023 approuvant l'avenant n° 11 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés.

FRANCE. Arrêté du 17 mai 2023 relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des ambulanciers affectés en structure mobile d'urgence et de réanimation.

FRANCE. Arrêté du 19 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2006 [revalorisation du forfait de carence ambulancière à 209 €].

FRANCE. Décret n° 2024-8 du 3 janvier 2024 [réforme du dispositif de gestion de crise hospitalière — Plan de mobilisation interne et Plan Blanc].

FRANCE. Arrêté du 4 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 11 avril 2022.

FRANCE. Arrêté du 15 novembre 2025 [extension exceptionnelle de la durée de mobilisation de la réserve sanitaire à 180 jours pour 2025].

FRANCE. Arrêté du 31 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2006 [revalorisation du forfait de carence ambulancière à 217 € pour 2026].

FRANCE. Code de la santé publique, notamment les articles L. 3132-1 et D. 3132-1 (réserve sanitaire), L. 6311-1 (aide médicale urgente), R. 3131-4 à R. 3131-14 (dispositif ORSAN).

FRANCE. Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1424-2 et L. 1424-42 (services d'incendie et de secours, carences ambulancières).

Sources parlementaires

ASSEMBLÉE NATIONALE. Question écrite n° 2374 de M. René Lioret sur la revalorisation du tarif national des carences ambulancières. *Journal officiel*, 26 novembre 2024, p. 6196 ; réponse publiée le 28 janvier 2025, p. 411.

SÉNAT. Question écrite de Mme Laurence Cohen sur la situation des ambulanciers hospitaliers, et réponse du ministère de la Santé et de la Prévention. *Journal officiel du Sénat*, 15 juin 2023, p. 3765.

SÉNAT. Rapport de la commission des lois sur la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, 2021.

Sources de presse (citées et identifiées comme telles)

Le Canard Enchaîné, 26 août 2025 (révélation de l'instruction ministérielle relative à l'hypothèse d'engagement majeur).

Le Quotidien du Médecin. « Les hôpitaux français doivent anticiper le risque de guerre sur le sol européen, assume le ministère de la Santé ».

France 3 Occitanie et presse régionale. Articles relatifs au conflit social des ambulanciers du CHU de Toulouse, mai-juin 2026.

Radio6.fr. « Carences ambulancières : “On n’a jamais connu un tel pic d’activité”, alertent les sapeurs-pompiers de la Somme », 26 janvier 2026.

Note méthodologique finale : cette bibliographie a été constituée au fil de la rédaction, chapitre par chapitre, conformément au protocole de vérification systématique établi au chapitre 5. Plusieurs références restent marquées comme non vérifiées en propre (connues uniquement par citation secondaire) et devront faire l’objet d’une vérification directe avant toute publication ou soutenance de ce travail.

REMERCIEMENTS

Merci au lecteur

Je tiens à remercier sincèrement les personnes qui auront pris le temps de lire ce document jusqu'à son terme.

Ce travail d'analyse représente un investissement important, nourri par vingt années d'expérience de terrain et par la volonté de documenter, avec la plus grande rigueur possible, une réalité professionnelle trop souvent méconnue.

Votre attention à ce dossier est la première étape vers une reconnaissance juste du métier d'ambulancier et des enjeux de santé publique qui y sont attachés.

Laurent Bezia

Responsable du personnel des ambulanciers, CHU de Toulouse

